

UNIVERSITETSMATERIALE

PRIVAT AKADEMISK ARKIV

22

BIND
I

VÆRK
ARKIV

EGET AKADEMISK ARBEJDE

BACHELORPROJEKT · SPECIALEFORBEREDENDE · SPECIALE

Eugenik, autonomi, omsorg og sygeplejeetik

JESPER JUNGLØW NIELSEN

Universitetsmateriale – sortering og arkiv

Eget akademisk arbejde

Bind I · Bachelorprojekt, specialeforberedende opgave og speciale

Jesper Jungl w Nielsen

Kolofon

Titel	Eget akademisk arbejde – Bind I
Undertitel	Bachelorprojekt, specialeforberedende opgave og speciale
Forfatter redaktion	og Jesper Jungløw Nielsen
Serie	Universitetsmateriale – sortering og arkiv
Bognummer	22
Udgave	Privat arkivudgave, 2026
Grundlag	Tre afsluttede akademiske arbejder fra det private universitetsarkiv

Historiske værktekster gengives i redaktionelt normaliseret sats. Faglige præciseringer dokumenteres særskilt og ændrer ikke originalernes ordlyd.

Redaktionelt forord

Dette bind samler tre afsluttede arbejder fra det akademiske arkiv: bachelorprojektet om liberal eugenik, den specialeforberedende undersøgelse af autonomi og etik i sygeplejen samt det færdige speciale om autonomi, omsorg og professionsetik. Sammen viser de både et tematisk slægtskab og en faglig udvikling fra bioetisk teknologikritik til praktisk etisk dømmekraft.

Bogen er en værkudgave, ikke en ny bog skrevet oven på de gamle tekster. Argumenter, formuleringer og historiske vurderinger er derfor bevaret. Typografi og overskriftsniveauer er normaliseret, mens de originale fodnoter er samlet efter hvert værk. De vigtigste faglige fejl og forenklinger er dokumenteret i Bilag A.

Materialet er privat. Navn står kun i bogens faste krediteringsfelter, og det gamle årskortnummer er fjernet fra værktekster og filvisning. Mails, godkendelser, udkast, parallelversioner og arbejds papirer er ikke blandet ind i denne rene værkudgave; de registreres i Bilag B og hører til bind II eller det private arkiv.

Redaktionel note om værkudgaven

Bachelorarkivet indeholder flere tekststadier. Den anvendte version er den mest komplette sammenhængende udgave med titel, hovedafsnit, konklusion og resumé. Den kortere rettede variant og øvrige udkast er registreret, men ikke sammenblandet med værkteksten.

Den specialeforberedende opgave findes både som afleverings-PDF og som to tekstligt ens DOCX-varianter. DOCX-versionen anvendes, fordi den bevarer de oprindelige notehenvisninger og kan sættes uden at ændre indholdet.

Specialet findes som færdig DOCX, XTRA-variant og udskriftsfiler. Den færdige, ikke-XTRA-markerede DOCX er hovedkilde. Det oprindelige formelle omslag dokumenterer Aarhus Universitet, speciale i filosofi, vejleder Jørgen Husted, studieordning Kandidat/2007, 74 originalsider og 175.824 typeenheder; personidentifikator er udeladt.

Faglige præciseringer står ved siden af værkerne, ikke inde i dem. Dermed kan læseren både møde de historiske tekster på deres egne præmisser og se, hvor en nutidig akademisk kontrol kræver skel, forbehold eller bibliografisk rettelse.

Indhold

Bind I er en værkudgave. Originalernes rækkefølge og argumentbevægelse er bevaret.

Redaktionelt forord	4
Redaktionel note om værkudgaven	5
VÆRK I · Liberal eugenik – et etisk dilemma	8
Indledning	8
Det filosofiske perspektiv i kritikken af liberal eugenik	10
Perspektivløshed og fremmedbestemmelse	12
Om inducering af et grundgode og livet som gave – Kan religionen give os et svar?	18
Konklusion	25
Resumé	27
VÆRK II · Autonomi og etik i sygeplejen – specialeforberedende prøve	31
Præsentation af speciale-projekt	31
Til besvarelse af spørgsmålet mellem autonomi og etik i sygeplejen vil jeg gøre brug af følgende litteratur:	32
Moralsk autonomi	33
Om forholdet mellem autonomi og paternalisme	36
Personlig integritet og værdighed – at handle med omsorg	39
Sammenfatning	41
Litteraturliste	42
VÆRK III · Autonomi, etik og sygepleje	45
Indledning	45
Metodeovervejelse	49
Begrebsdefinitioner	51
Det kantianske autonomibegreb	52

Indhold · fortsat

Kant i praksis – om anvendelse af det kantianske autonomibegreb	57
Case	62
Fra moralsk til personlig autonomi	67
Selvbestemmelse og personlig autonomi – et konsekvensbetragtende perspektiv	70
Konflikten mellem den personlige autonomis begrundede valg og paternalisme	83
Om forholdet mellem autonomi og omsorg	85
Kritik af det ontologiske omsorgsideal	96
De Sygeplejeetiske Retningslinjer – Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis	99
Case analyse	102
Identifikation	103
Etisk analyse	105
Konklusion	110
Engelsk resumé / English resume	117
Litteraturliste	119
Efterord · Fra eugenik til sygeplejeetik	125
Personlige og etiske refleksionsspørgsmål	126
Redaktionelle kontrolnoter	128
Bilag A · Faglige rettelser og redaktionelle præciseringer	130
Bilag B · Materiale- og filoversigt	132

VÆRK I • BACHELORPROJEKT

Liberal eugenik – et etisk dilemma

Habermas, genetisk design, autonomi og menneskelig selvforståelse

Genre	Bachelorprojekt
Hovedspor	Jürgen Habermas og Nicholas Agar
Kildevalg	Komplet sammenhængende version med resumé
Redaktion	Ordlyd bevaret; noter samlet efter værket

VÆRK I • AFSNIT 01

Indledning

Denne analyse vil forsøge, at betone nødvendigheden af en filosofisk regulering af brugen af liberal eugenik. Selvom videnskab endnu ikke kan udfører genetisk design, så er der en stigende nødvendighed for at holde videnskaben indenfor acceptable etiske rammer således at videnskaben ikke kommer til at stå uden for det sociale spænd hvori vi danner vores forståelse af hvad det vil sige at være menneske og hvilke rettigheder vi besidder.

Som udgangspunkt bruges den tyske filosof Jürgen Habermas' værk *Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik*, hvor i det påpeges, at udsættes subjekt for designede genetiske forandringer mister det dets tilhørsforhold til verden og bliver derigennem fremmedbestemt. Dette resulterer i etiske komplikationer, som eksempelvis forringet selvverd, manglende tilhørsforhold og ikke mindst krænkelse af subjekts frihed.

Som modstykke til dette finder vi den liberale eugeniks fortalere Nicholas Agar og værket *In Defence of Human Enhancement*, som forsøger at retfærdiggøre brugen en liberal gendesign.

I afsnittet *Det filosofiske perspektiv i kritikken af liberal eugenik* betones denne nødvendighed af filosofisk regulering af brugen af eugenik. Der tages udgangspunkt i den kantianske forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. At mennesket er mål-sig-selv og aldrig et middel. Hertil finder vi de livsanskuelser som har dannet grundlag for hvordan vi forstå os selv som menneske; at vi er frie handlende væsner. Denne ret til at autonomt livsførelse kan ikke gå på kompromis med den liberale tankegang, da disse fjerne subjektets ret til at været frit og vi ser hvorledes liberalisterne instrumentalisere mennesket og derved gør dem til middel og ikke mål.

Som udgangspunkt er det filosofiske perspektiv et forsøg på at komme på forkant med de eventuelle fare som vi kan møde i en fremtidig brug af eugenik. Der vil således argumenteres for, at genetisk design kan resultere i perspektivløshed og ikke mindst fremmedbestemmelse.

Netop denne fare betones i afsnittet *Perspektivløshed og fremmedbestemmelse*, hvor der gives en dybtgående analyse af disse etiske dilemmaer. Diskussionen tager udgangspunkt i Agar liberale forsvar med påstanden om at der ikke er en moralsk distancering mellem genetisk brug og miljø. Der forsøges en forening af disse under begrebet nurture, som for Agar er et væsentligt argument for brugen af liberal eugenik. Men jeg vil mene at Agars udgangspunkt ikke er berettiget og vi må i stedet for fokusere på subjekts autonomi og dets tilhørsforhold i verden. Vi kan i diskussionen således konkludere tre punkter som sætter spørgsmålstejn ved brugen af liberal eugenik; subjekt kan anklage sin designer for dets genom sammensætning, det er ikke muligt at afværge de genetiske ændringer og vi kan ikke have indblik i hvad der forekommer som et grundgode for subjektet.

I afsnittet *Om inducering af et grundgode og livet som gave – Kan religionen give os et svar?* vil der blive givet et svar på nogle af de grundlæggende spørgsmål som Habermas ikke selv giver, nemlig hvad vil det så sige at være menneske i denne sammenhæng. Der vil blive sat spørgsmålstejn ved, hvorvidt designer kan have en objektiv til induceringen af grundgoder og her vil vi se at eksempelvis kristendommen kan give os et svar på hvorfor vi ikke selv kan designe liv medsubjektive præferencer. Habermas giver ikke en eksistentiel indgangsvinkel i sin kritik, men det svar vi ikke finder hos ham mener jeg at vi kan finde hos Knud Ejler Løgstrup som viser, at livet er en gave hvor mennesket kan finde forståelse af sig selv ved at det altid har noget af den andens liv i sin hånd. Heri også en påstand om, at dette vil vi ikke kunne have i tilfælde at et designet liv da dette vil være blevet sat uden for de etiske rammer eksempelvis kristendommen og Løgstrup fremlægger. I dette afsnit betones derved tanken om livetsskænkethed og det at vi skal tage vare for hinanden igennem næstekærligheden, dette kan vi gøre fordi at vi alle er lige væsner men underlægges vi genetisk design vil vi netop have distanceret os væk fra dette og livet vil derfor ikke længere være et liv

skabt på eksterne præmisser og vi vil derfor ikke kunne behandle alle som værende skabt lige i Guds billede.

Analysen rundes af med en *konklusion* hvor vi vil se, at de liberale ikke formår, at have gennemslagskraft i deres argumenter og at Habermas har ret i at der er en nødvendighed for en filosofisk regulering af den liberale eugenik.

VÆRK I • AFSNIT 02

Det filosofiske perspektiv i kritikken af liberal eugenik

I værket *"Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik?"* diskuterer Jürgen Habermas de problemstillinger som vi må imødegå, hvis vi lader en liberal eugenik være en alment accepteret indgreb i den menneskelige arvemasse. Spørgsmålet om liberal eugenik er for Habermas et spørgsmål om krænkelse af menneskets subjektive autonomi og dets dertilhørende rettigheder; *"Moralsk dømmende og handlende subjekter forudsætter gensidig tilskrivelsesduelighed, de tilskriver sig selv og andre evnen til at føre et autonomt liv og forventer solidaritet og ligeagtelse af hinanden"*^[1]. Denne fundamentale ret til at føre et autonomt liv vil for den liberale eugeniske fortæller ikke være muligt, da de fjerner menneskets ret til at være frie væsner og for disse er mennesket ikke andet end blot et instrumentaliseret væsen; et middel, ikke mål. Derved vender de liberale sig fra den kantianske deontologiske tankegang om mennesket som mål i sig selv; mennesket må være et mål og aldrig et middel. Det er gennem denne opfattelse at vi har skabt fundamentet for det frie menneske og dets dertilhørende livsanskuelse som er hele grundstrukturen i hvorledes vi opfatter os selv som eksistentielle og subjektive fornuftsvæsner.

Lader vi mennesket være et middel og ikke et mål, som vi senere vil se det forekomme hos den liberale eugeniske Nicholas Agar, så vil jeg mene, at mennesket mister hele sit grundlag for, at være et selv-handlende subjekt i verden – mennesket vil blive reduceret til et objekt i verden og for at undgå dette bliver vi nødt til at søge en filosofisk reguleringsform. Tesen lyder, at eugenikken giver os fremtidige muligheder som på det etiske plan bliver nødt til at tages til debat og reguleres for ikke at ende i store sociale faldgrupper, fremmedbestemmelse af subjekt og dertilhørende manglende autonomi.

Jürgen Habermas repræsenteres af den negative eugenik, hvor vi godt kan tillade os at forhindre arvelige sygdomme men det er moralsk og etisk forkert at tilskrive subjekt ekstra egenskaber i kraft af gentilskrivelser. Den liberale eugenik repræsenteres ved Nicholas Agar, som accepterer og argumenterer for, at det er etisk acceptabelt at tilskrive subjekt ekstra genetiske egenskaber så længe at disse tilskrives af dennes forældre eller værge. Den positive eugenik

er i denne analyse ikke relevant, da diskussionen ikke vil komme ind på, hvorvidt staten skal spille en rolle i reguleringen af genetiske ændringer.

I ”*Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik*” påpeges der de forskelligheder som er i vores kulturelle perspektiv på genetisk forbedring. I Tyskland diskuteres en principiel debat om normativt mættede personbegreber og metafysisk ladede naturkonceptioner i skeptisk diskussion om den videre genteknologiske udvikling skal fortsætte; der er i Tyskland og kontinentaleuropa fokus på den objektive ret. Eugenikken mødes af forsigtighed, hvilke er ganske naturligt taget den europæiske historie i betragtning. I USA ser vi visse tendenser til at udviklingen af nye teknologier som ikke drages i tvivl. Der er altså tale om en usvækket og til tider en ganske ukritisk tillid til videnskaben. En videnskab som bevæger sig fra en anvendelse af genterapi til en *shopping in the genetic supermarket*^[2]. Det er i tilfælde af denne uagtsomhed at vi må tage debatten om liberal eugenik op til diskussion. Jeg vil derfor påpege, som Habermas også til dels gør det, at vi må forholde os til tunge filosofiske mastodonter som John Locke og ikke mindst Immanuel Kant og dennes tilgang til tanken om det frie menneske og dertilhørende immanente ret til autonomi. Det forekommer at den liberale eugeniks fortalere mangler en sammenhæng og retfærdiggørelse af eugenisk brug og det er netop denne mangel som Habermas påpeger når han taler om ”*shopping in the supermarket*”; de liberale argumenter for at forældre som værger kan udnytte eugenikken uafhængigt af deres ufødte barns vilje er et decideret brud på subjektets ret til at være autonomi væsen. Der er i sin enkelthed tale om at brugen af liberal eugenik gør, at subjekt nægtes retten til at besidde kontingent individuel livshistorie og den dertilhørende ret til etisk livsudformning.

Det filosofiske perspektiv i diskussionen tager udgangspunkt i dette og den dertilhørende fare for perspektivløshed og fremmedbestemmelse i subjektet som i sidste ende vil resultere i konsekvenser som vi ikke kan tillade os at tilbyde et fornuftsvæsen.

VÆRK I • AFSNIT 03

Perspektivløshed og fremmedbestemmelse

I sit pro liberale værk ”*Liberal eugenics – In Defence of Human Enhancement*” argumenterer Nicholas Agar imod tanken om at subjekt vil besidde en fremmedbestemmelse i sin selvforståelse af jeget, da subjekt er i stand til at handle imod de genetiske egenskaber som er blevet induceret af en gendesigner. Agar bygger hovedsageligt sit forsvar af liberal eugenik i forhold til begrebet nurture;

”The moral image of nurture suggest the following idea, which I call nurture principle for its connection with NURTURE: if we are permitted to

produce certain traits by modifying our children's environments, then we are also permitted to produce them by modifying their genomes^[3]

Agar argumenterer for af subjektet 'skabes' af en sammensætning af genetik og miljø. Deraf begrebet *nurture* som er en sammenkobling af disse to begreber. Genetik og miljø bidrager med forskelligt til realiseringen af subjektet. Det liberale argument lyder at både genetik og miljø begge burde evalueres under sammen moralske forudsætninger, hvis de hver for sig kan nå de samme mål. Dette vil sige, at Agar forsøger at skabe et moralsk etisk lighedstegn mellem brug af genetik og brugen af at forme et ufødt barn gennem miljø, eksempelvis via diæt. Vi kan spørge om ikke en gravid kvinde netop bruger miljøet (diæt) som en bestemt måde at nå sit eget mål på; hun former altså fosteret ved at indtage specifik føde således at fosteret kan nå et specifikt mål. Spørgsmålet skal hertil lyde at hvis vi er tilladte til at påvirke fosterets miljø på en specifik og bestemt måde for at nå et mål, vil det så ikke være inkonsistent hvis vi netop ikke tillod en genetisk ændring med præcis samme mål?

Besvarelsen af dette spørgsmål vil jeg belyse fra en anden vinkel? Allerede i den fundamentale genændring mister subjektet sin objektive ret til at være lige anerkendt da det ikke vil besidde samme objektive ret fordi at vi kan i en given situation altid stille spørgsmålstejn ved, hvorvidt subjekt handler efter egen fri vilje eller om dets handlen er et udtryk af gendesigners konstruktion af subjektet. Spørgsmålet handler derfor ikke om, hvorvidt vi kan koble genetik og miljø sammen i begrebet *nurture* men om hvorvidt vi kan fratage et subjekt dets autonomi og derved også i særdeleshed ændre dets tilhørsforhold til verden og sin egen selvforståelse af selvbevidstheden. Jeg vil derfor også give Habermas ret når han netop sætter dette som den centrale problemstilling i diskussionen: *"Den objektive ret legemliggør og fortolker den stiftende idé om den gensidige anerkendelse af frie og lige personer, der slutter sig sammen frivilligt for i fællesskab legitimt at regulere deres samliv med den positive ret midler."*^[4]

Det er i fratagelsen af denne objektive ret at subjektet mister sin autonomi og får fordrejet sin egen selvforståelse og derved opstår fremmedbestemmelsestanken om subjektet. Jeg vil påstå at det er moralsk forkasteligt, at sætte subjekt i en situation, hvorved det ikke selv er klar over hvorvidt det har handlet efter egen fri vilje eller om det er underlagt gendesigners egne mål og vilje. Habermas udtrykker dette således:

"Det indebærer ikke nogen intervention i de friheder, der moralsk tilkommer enhver født person, hvad enten han er naturligt avlet eller genetisk programmeret; men den berører en naturlig forudsætning for den berørte persons bevidsthed om at kunne handle autonomt og ansvarligt."^[5]

Ud fra dette kan vi konkludere at *"programmerede personer ikke længere vil kunne betragte sig selv som udelte ophavsmænd til deres egen livshistorie"* og *"at de ikke mere uindskrænket vil kunne betragte sig som jævnbyrdige personer i forholdet til de tidligere generationer."*^[6] Det betyder at det at nødvendigvis må forekomme uacceptabelt at subjektet ikke er i stand til at kunne handle frit grundet designers genkonstruktion og i kendskab til denne modifikation af generne vil subjektet ikke kunne besidde en kontingent og individuel livshistorie, hvilket kan resultere i en fremmedbestemmelse af subjekt selv.

Subjekt mister i denne fremmedbestemmelse sin relation til og forståelse af sig selv i verden fordi at subjekt mister forståelsen af sin egen selvforståelse. Resultatet heraf vil ende i en forståelse af subjekt som værende i manglende besiddelse af selv værd, et selv værd som ikke vil kunne finde sin plads i verden fordi at den er blevet frataget retten til at besidde autonomi grundet en designers inducering af meningsløshed forvoldt ved ændring af subjekt gener. Subjektet som har været underlagt en gendesigners manipulation vil altså være sat udenfor det moralske spil som omverdenen er underlagt og det vil samtidig ikke kunne finde relation til omverdenen; subjektet vil så at sige have mistet retten til at være et subjekt og i stedet blive et objekt for verden og dets designer.

I *"Liberal Eugenics – In Defence of Human Enhancement"* forsøger Nicholas Agar at bortforklare argumentet om at subjekt vil være fremmedbestemt og ikke kunne finde sig hjemme i verden ved at argumentere for, at selv om subjekt er blevet induceret med andre grundgoder end dets uligeværdige samtidige så vil subjekt være i stand til at kunne kontrollere de genetiske fordele som det er blevet pålagt. Således argumentere Agar for, at selv om et subjekt har fået tildelt en egenskab som det under normale omstændigheder ikke ville besidde så kan denne kontrolleres og undermineres af subjektet selv: *"It is true that someone cannot, as an adolescent, change the fact that his parents have engineered his genome – but he does have some control over the influences of the genes that he has received"*^[7]. Det er altså muligt at kontrollere egenskaben, dog vil jeg påpege Agars brug af pronomen *some* som indikerer at subjekt ikke er i stand til at kunne kontrollere absolut over det inducerede gode og derved vil jeg mene at vi kan tillade os at have et mistillidsforhold til argumentet. Nicholas Agar fortsætter sit argument: *"The child's act refusing to go to school does not change genes, but it does prevent them from having the effects on his intellect that they would otherwise have had."*^[8] Agars indvending mod bl.a. Habermas bygger på, at han mener at de fleste som er imod liberal eugenik, bygger deres indvending mod eugenik på en antagelse af genetisk determinisme. Som tidligere påpeget så bliver subjektet formet gennem miljø og derfor kan vi endnu engang spørge om ikke vi også kan ændre subjekt gennem genetiske ændringer, fordi at rent

moralsk gør det ikke nogen forskel fordi at nurture begrebet i sig selv forener genetik og miljø og vi skal ikke skelne mellem disse fordi at det ikke gør nogen forskel om hvorvidt målet med subjekt bliver nået via eksempelvis diæt under graviditeten eller om målet bliver nået via genetiske design ændringer og tilskrivelser. Målet for Agar og den liberale eugeniks fortalere er, at den moralske opfattelse vi har om genetisk manipulerede fordele i sig selv ikke er forkert da der for disse fortalere søges og argumenteres for en kompatibel symmetri mellem genetik og miljø.

Det liberale svar på kritikken er ikke tilfredsstillende, for Agar viger uden om spørgsmålet om hvorvidt vi kan tillade os at fratage fostersubjektets autonomi rettigheder. De liberale fortaler accepterer ganske enkelt ikke retten til frihed for individet. Det virker derfor også usammenhængende når de prøver at forene miljø og genetik i kraft af nature begrebet. At tale om, at nature kan forene begreberne er ganske enkelt stadigvæk et overgreb på individet. For Agar gennemskuer netop ikke forskellen på *en dressur opdragelse* (eksempelvis igennem moderens diæt i fostertilstand) og en genetisk påført egenskabs-opdragelse. Der er forskel på at opdrage subjekt under dressur forhold, man kan eksempelvis forme subjekt i prænatal tilstand, og under liberal genetisk opdragelse. Opdrages subjekt under de liberale forhold, og det er ganske ligegyldigt om hvorvidt subjekt kan kontrollere sine gen-modificerede egenskaber eller ej, for subjekt har stadig ikke den frihed som dressur opdragelsen tilbyder. Dette er på trods af at selv dressuropdragelsen kan opstille rammer som er etisk utilfredsstillende, så kan denne form for opdragelse aldrig tilsidesætte subjekts frihed – det er altid i stand til at tænke frit, hvilket vi kan forstille os ikke vil være muligt hvis prænatale indgreb har fundet sted. Modsvaret er Agars argument om at vi kan kontrollere vores genetiske ændringer, eksempelvis ved at undlade at eksempelvis følge sin skolegang, hvilket blev belyst tidligere: *"The child's act of refusing to go to school does not changes genes, but it does prevent them from having effects on his intellect that they would otherwise have had."*^[9] Dette argument er dog utilfredsstillende. Det er rigtigt at, hvis subjekt undlader at følge sin skolegang så vil den påførte egenskab ikke udfolde sig og derved menes der, at den kan kontrolleres og tilsidesættes, hvis subjekt har interesse i dette. Men dette er i og for sig lige meget for vi kan ikke komme uden om det faktum at subjekt allerede på forhånd er blevet pålagt en ikke-naturlig egenskab som blot endnu ikke, og muligvis aldrig vil blive realiseret. Et liv med urealiseret genetisk egenskab er stadig et brud på subjekts rettigheder og en krænkelse af *den fremtidige livshistories individuelle forløb*^[10]. Det forekommer altså ikke muligt at drage en sammenligning mellem dressuropdragelse og genetisk påført egenskabs-opdragelse og jeg vil give Habermas ret når han udtaler:

"For så vidt forældre kan anklages for bestemte pædagogiske styringer, fordi de præjudicerer evner, der kunne få ambivalente følger i en senere livshistories uforudselige kontekst, udsætter ophavsmanden til genetiske programmer sig virkelig for anklagen om, at han uretmæssigt påtager et ansvar for en fremtidig persons liv, der må vedblive at være forbeholdt denne person selv, hvis hans bevidsthed om at være autonom ikke skal tage skade^[11]"

Ganske vidst kan også en dressuropdragelse underkue individet gennem livet men dette ændre ikke det faktum at ændre vi subjekts gener i kraft af design så er denne ikke længere selv ophavsmand til eget liv, men må i stedet for leve i vished om, at en designer har manipuleret dets gener således, at der kan sættes tvivl ved egne handlinger og tanker. Dette betyder, at gendesigneren virkningsfuldt er blevet til medophavsmand til subjektets liv, da designers indgreb griber ind i subjekts selvforståelse af sig selv som værende autonomt væsen. Ved genetisk indgreb generer designer altså tvivl om hvorvidt subjekt handler efter egne eller designers vilje. Jeg mener at vi kan konkludere, at dette vil føre til en række konsekvenser som vi ganske enkelt ikke kan tillade os at byde fornuftsvæsnere:

- Subjektet kan anklage sin designer for dets genoms sammensætning, hvilket betyder at designer har indflydelse på, hvorledes subjekts liv udformes.
- Dette bestyrkes i, at der ikke er en konstant mulighed for at afværge programmering, hvilket adskiller sig fra dressuropdragelse, hvor dette faktisk er muligt.
- Inducering af 'grundgoder' forekommer forkert, da det ikke er muligt, at give en objektiv livshistorisk tilgang til disse – derved kan det som designer opfatter som et gode blive en betydelig last for subjekt.

Det er i denne inducering at fremmedbestemmelsen finder sted, hvilket resulterer i flere etiske problemstillinger, som vi har netop har belyst. Men vi kan tage argumentet imod den liberale eugenik ved at sætte spørgsmålstegn ved, hvorledes designer kan retfærdiggøre induceringen af et gode uden at have en objektiv adgang til at vurdere hvorledes denne gode rent faktisk er det gode. Dette betyder, at ikke blot har designer krænket subjekts autonome ret og derved også gjort det til et bundet væsen fordi at designer altid vil være til stede i subjektets egen bevidst men samtidig har designer induceret et grundgode uden at kunne retfærdiggøre sin ret til at vurdere at dette faktisk er et gode og ikke en last. Vi kan forstille os et scenarium, hvor subjekt er af designer blevet tildelt en exceptionel god hukommelse, hvilket betyder at subjekt har en egenskab, hvor det ikke forekommer muligt for det at glemme. Dette lyder, hvis vi ikke tænker eksemplet igennem, som en god egenskab – men man skal ikke tænke ret langt ud over dette før man vil blive klar over, at sådan en hukommelse vil kunne blive en stærk negativ byrde for subjektet,

hvilket egentligt ikke var meningen med denne induceret grundgode. Problemet er ikke, at vi vil være i stand til at huske alle de gode ting som vi oplever igennem vores liv men det faktum, at vi aldrig vil kunne undertrykke og glemme alle de negative indtryk som vi imødegår og oplever gennem hele livet. Vi kan ikke retfærdiggøre dette overfor det designede subjektet. Det faktum at subjekt aldrig vil kunne glemme de forfærdelige, deprimerende og livstafagende indtryk som det møder og føler gennem livet vil resultere i et individ, hvis psykologiske tilstand vil ende i det rene fordærv. *”Er forældre, der kun ønsker det bedste for deres børn virkelig i stand til at forudse de omstændigheder – og samspillet af disse omstændigheder – under hvilket f.eks. en glimrende hukommelse eller en høj intelligens vil være en velsignelse?”*^[12] Ud fra dette vil jeg mene, at vi ikke kan fuldføre et liberal eugenisk gendesign fordi, at subjekt netop ikke vil kunne kontrollere sine designede egenskaber.

VÆRK I • AFSNIT 04

Om inducering af et grundgode og livet som gave – Kan religionen give os et svar?

Subjekt bliver fremmedbestemt ved tilskrivelse af grundgoder. Ved inducering af disse har vi set, at Agar ikke har kunnet komme med et retfærdiggjort argument for brugen af liberal eugenik. Ved tilskrivelsen af ekstraordinær egenskab ved subjekt berør vi ikke kun subjektets egen livshistorie men også hele tanken om hvor vores etiske grænse går. Og som Habermas understreger i sin analyse af *Den Menneskelige Naturs Fremtid – på vej mod en liberal eugenik* så er denne tankegang det første skridt på vejen mod en opløsning af den deontologiske etik som sikre subjektet dets selvstændighed og ikke mindst sin egen unikke selvbevidsthed og tilstedeværelse: *”Den således fremmedgørende diffusion eller opspaltning af den egen identitet er et tegn på en begyndende opløsning af det grænseopretholdende deontologiske beskyttelseshylster, der først sikre, at personen er ukrænkelig og den egne subjektivitet uerstattelig*^[13]”. Dermed påpeger Habermas denne analyses hovedargument, nemlig at subjektet krænkes hvis vi bryder den deontologiske tankegang om, at mennesket i sig selv er målet og ikke midlet. Til gengæld gives der af Habermas ikke noget svar på, om der kan være en mere objektiv grund til at bevare deontologien og hele tanken om mennesket tilstedeværende værende af sådanne art at vi ikke kan tillade os at ændre dets gener og derved hele dets forhold til tanken om begrebet liv-i-sig-selv. Vi må, for at finde et eventuelt svar til dette, vende os mod religionen og tanken om livet som skabt. Jeg vil påstå at, i deontologien finder vi det normative fundament i, at vi som subjekter og mennesker besidder pligter som er absolutte, hvilket derved betyder, at de er ufravigelige. Derfor kan vi ikke designe et liv som vi selv ønsker fordi at dette vil vige

udenfor rammerne af, hvad vi som mennesker har ret til at gøre. *"Tilliden står ikke til os. Den er givet. Vort liv er nu engang hen over hovedet på os skabt sådan, at det ikke kan leves på en anden måde end ved at det ene menneske i vist eller begæret tillid udlevere sig og giver mere eller mindre af sit liv i den andet menneskes hånd.^[44]"* skrev Knud Ejler Løgstrup i sit værk *Den Etske Fordring* fra 1956. Implicit i dette er den påstand at livet er skabt, ikke af mennesket selv, men af noget udefrakommende og eksternt. Dertil er den tilhørende påstand om, at vi som mennesker lever vores liv i *den andet menneskes hånd*. Løgstrup giver, ifølge sig selv, ikke en kristen etik men en universel etik – dog vil jeg mene, at der gives en etik som bygger på den kristne etiks fundament. Det interessante ved inddragelsen af Løgstrup i en analyse af liberal eugenik er, at Løgstrup belyser næstekærligheden som værende det som holder os sammen som subjekter og mennesker, og endda på flere niveauer. Tanken om næstekærlighed må nødvendigvis bero på, at vi som mennesker alle er skabt lige, i den forstand at vi er mennesker, som i Løgstrups termer, har modtaget livet som en gave fra noget større end os selv, altså Gud. Men hvis subjektet har været under en gendesigners behandling er subjektet ikke længere af sådanne karakter at vi kan behandle dette på ligeværdig fod, da det ikke besidder livet som en gave fra Gud men blot er designet til at være det som det nu engang er blevet. Dette betyder, at vi ved liberal eugenik og dets indicering af grundgoder, bevæger os med kraftige skridt væk fra det fundament som holder hele vores livsforståelse sammen; tanken om næstekærligheden og at vi alle besidder en subjektiv unikheds karakter. I næstekærligheden finder vi tanken om kendsgerningen^[45], men vi kan i tilfælde af liberal eugenik spørge, hvad skal vi bruge denne kendsgerning til, når vi allerede har brudt fordringen ved, at pålægge det andet subjekt en fordring – derved kan vi ikke tale om en uudtalt fordring hos Agar og hele den liberale eugeniks tilhængere. Den liberale eugenik tillader jo netop ikke en uudtalt fordring fordi, at den har ændret ved subjekts egen forståelse af selvbevidstheden, derved kan subjekt ikke finde svar på, hvad der er den rette handling at gøre, hvilket for Løgstrup er noget rent subjektivt fordi, at det rette handlen finder subjektet i fantasien, indlevelse og forståelse for den anden^[46].

Vi kan spørge til, hvorvidt designer kan have en sandfærdig og objektiv tilgang til induceringen af et grundgode hos subjekt? Dette kan designer ikke have og fortager derfor ved induceringen en subjektiv tilrettelæggelse af det andet subjekts livsførelse, hvilket betyder, at designer bevæger sig væk fra det objektive liv og former det ved egne præferencer og derved også fratager subjekts ret til, at besidde et liv som er blevet *skænket som gave* af Gud. Følger vi til gengæld Løgstrups etik, vil vi kunne finde svar på de etiske og eksistentielle spørgsmål som Habermas ikke selv besvare i sin kritik af liberal eugenik. I *Den menneskelige natur fremtid – på vej mod en liberal eugenik* forekommer det problematisk for Habermas, at finde en forståelse af hvad vi

er som menneske og vi kan hertil spørge om en eventuel kristen eksistentialisme kan udfylde dette tomrum for Habermas og hans belysning af den menneskelige eksistens.

Både Habermas læner sig op ad en kristen tilgang til hvad livet er – dog kan vi godt savne en mere dybdegående analyse af hvad livet egentligt er for Habermas. Løgstrup bruges til at komme med svar på dette, da Habermas ikke selv giver et tilfredsstillende svar. Løgstrups etik beror på det deontologiske udsagn om, at man ikke må bruge andre som middel men altid kun som mål. Derfor kan man hos Løgstrup ikke tale om at pådutte det andet subjekt en tvang. Dette skyldes, at bruger vi og underlægger vi den anden under tvang mister den anden sin frihed. Dertil netop også et argument mod liberal eugenik og det faktum, at det andet subjekts frihed berøves når det har været underlagt en designers præferencer. Dermed fejler liberal eugenik også i Løgstrups tanke om, at varetagelsen af den anden ikke må hindre den anden i at forstå sit liv som modtaget^[17] - Et subjekt værende manipuleret af en designer mister netop hele sin forståelse af egen livshistorie, hvis det bliver hindret i at forstå sit liv som gave. Dette betyder, at vi hos Løgstrup får sat et mere eksistentiel og dybtgående perspektiv ind over forståelsen af hvorfor vi ikke må krænke subjekts livsforståelse. Habermas lagde grundlaget for dette argument tidligere i analysen men inddrager vi Løgstrups etik så finder vi nu et meget mere eksistentiel forhold i forståelsen af subjekts livshistorie og hvorfor det forekommer som værende nedværdigende overfor subjekt at frarøve det dets autonomi og selvforståelse af selvbevidsthed; subjekt har ganske enkelt et behov for at kunne forstå sig selv i det udtale og i forståelse af at livet er en gave skænket af Gud – derved undgår subjekt nemlig at blive reduceret til en ting i verden, altså et objekt for andre, og kan derved skabe sin egen identitet og selvbevidsthed^[18].

Forstår subjekt livet som skænkethedens livsforståelse, så ser vi netop også, at kendsgerningen selv er ensidig. Dette er fundamentalt for vores livsførelse, fordi vi ikke kan tillade os at forvente noget af den anden, da vi hos Løgstrup, allerede er skyldnere: X kan ikke sige at Y skal tage vare for X's liv. Dette er en ren kristen tankegang men den giver alligevel et bud på hvordan vi skal forstå det at leve i relation til hinanden og derved også forstå vores egen livshistorie og derved også undgå fremmedbestemmelse. Men for den liberale eugenik kan vi ikke tale om ikke at skyldte noget for subjektet vil netop altid skyldte designer sit liv og derfor vil subjekt aldrig kunne leve et liv skabt på frihedens fundament.

Det liberale modsvar hertil vil lyde, at vi kan stille spørgsmålstejn ved relevansen af, hvorvidt det overhovedet vil give mening at tale om fremmedbestemmelse, da subjekt altid vil kunne vil kunne bebrejde sine forældre for eventuelt at være født med det forkerte køn. Dette betyder, at subjekt altid vil kunne anklage sine forældre for at værende X når det vil have

været Y, eksempelvis kan vi tænke en dreng som vil være pige beskylde sine forældre for at han har fået det køn som han nu engang har fået. Men dette liberale modsvar er ikke tilfredsstillende, da denne argumentationsform ikke er andet end et tomt argument, da subjektet ikke kan være i stand til at tilbageprojicere sin egen identitetsværende til en kønsneutral fortid^[19].

Habermas fremstiller Dworkins argument om det at anklage sine forældre for kønsutilfredsstillelse, værende på lige fod med en etisk retfærdiggørelse af genetisk indgreb. Dog vil jeg mene, at Dworkin derved differencer mellem henholdsvis maskulinum og femininum og derved foreligger han en deskriptiv forståelse af hvorledes disse burde forme deres livsudfoldelse. Dette betyder at Dworkin og den liberale eugeniks fortalere ikke acceptere den normative lighed mellem kønnene og allerede på forhånd har vurderet, hvorledes disse skal indpasse sig i en verdensforståelse. Der er i denne tankegang tale om en slags på forhånd bedrevidenhed som betyder, at hvis vi designer subjekt til at være eksempelvis af hankøn, så har vi ikke givet plads til dennes frihed men vi har allerede på forhånd lagt faste rammer for, hvordan et liv skal leves^[20]. I ekstreme tilfælde betyder dette, at vi vil ende i en nichetilgang til forståelsen af det menneskelige væsen, hertil søger vi ikke at tilfredsstille subjekts egne behov men i stedet forsøger vi at tilfredsstille vores egne præferencer. Dette resulterer i, at vi ikke længere acceptere livetsskænkethed og derved viger vi bort fra den eksistentielle forståelse og udfoldelse af livet som bl.a. en kristen livsførelse kan give hvis vi eksempelvis følger den etik som vi har set fremlagt af Løgstrup.

”Jeg hævder da, at mennesket og i det hele taget ethvert fornuftsvæsen eksisterer som mål i sig selv, ikke blot som middel til vilkårlig brug for denne eller hin vilje; tværtimod må det i sine handlinger, både når de er rettede mod det selv og mod andre fornuftsvæsener, altid tillige betragtes som mål^[21]”

Således skrev Kant i værket *Grundlæggelse af sædernes metafysik*,. Vi ser netop her at mennesket som fornuftsvæsen ikke er et middel men selve målet. Og som både Kant og Løgstrup giver udtryk for, så skal vi tage hånd om andre mennesker fordi, at disse er en del af vores eget liv. Problematikken ved den liberale eugenik ligger i den tidligere nævnte fremmedbestemmelse og manglende autonomi hos subjektet – derudover ser vi også den liberale eugeniske tanke om hvad mennesket er, befinder sig udenfor rammerne af det værdigrundlag som danner ramme for den verden vi nu engang lever i og hvor vi alle er skabt lige.

Fra det religiøse synspunkt er denne tilgang til forståelsen af mennesket som værende fornuftsvæsen en fuldstændig fordrejning af hvorledes menneskets rolle udspilles i verden. Man kan sige, at mennesket i den liberale tankegang har bevæget sig væk fra Gud og den dertilhørende etiske og

eksistentielle livsførelse og vi er endt udenfor for kristnesammenspil som sikre vores plads og selvbevidsthedslære. Dette betyder, at vi med Lutherske termer er af ondt og vildt karakter^[22], men i modsætning til Luthers samtid kan vi ikke længere fæstne mennesket ved brug af den kristne livsforståelse. Vi kan sige at vi med den liberale tankegang i hånden bevæger os dybere ind i synden og længere væk fra frelsen og Guds ordnede to regimente er ikke længere den søgte vej som derved heller ikke længere kan værges mod de ukristelige og holde disse nede ved rod.

At blande 500-600 år gammel troslære ind i debatten om liberal eugenik kan måske forekomme absurd men det giver til gengæld et godt billede af, at mennesket er på vej ud af rammerne for, hvad det vil sige, at være menneske. Kritikken af liberal eugenik skal dog ikke være en kritik af videnskabens fremdrift men det skal være en kritik af, hvorledes vi vil placere de moralske og etiske rammer som udspiller sig i de samfund som vi nu engang lever i. *"If bioengineering made the myth of the self-made man come true, it would be difficult to view our talents as gift for which we are indebted, rather than as achievements for which we are responsible"*^[23]. Dertil kan vi i vores forståelse af mennesket og vores egen selvbevidsthed altid slå tvivl om, hvorvidt vi overhovedet kan tale om at subjekt selv er skyld i en udført handling og derved også om hvorvidt subjekt vil kunne takke sig selv, hvis det eksempelvis har præsteret at udføre en ekstraordinær handling. Sådanne handling vil nemlig altid kunne føres tilbage på en designer og dennes præferencer og derved vil subjekt kunne finde sig selv i et stadie af fremmedbestemmelse, hvor det vil kunne så tvivl om sin egen eksistens som et væsen med fri vilje og handlekraft. Til gengæld vil vi ifølge Michael Sandel kunne finde en eksistentiel tilfredsstillelse i vores egen livsførelse og livshistorie, hvis vi kan projicerer vores handlinger tilbage på noget større end en menneskelig designer, nemlig Gud og det kristne livssyn:

"One of the blessings of seeing ourselves as creatures of nature God or fortune is that we are not wholly responsible for the way we are. The more we become masters of our genetic endowments, the greater the burden we bear for the talents we have and the way we perform"^[24].

Dette betyder, at acceptere vi livetsskænkethed så vil vi kunne se os selv som skabt af Gud og derved kan vi ikke til fulde bebrejde os selv for det subjekt som vi nu engang er. Men i modsætning til det designede subjekt, så vil vi altid have en eksistentiel forståelse af, hvad det vil sige at være et individ også selv om vi ikke selv er det fuldkomnende grundlag for måde vi er skabt på som individer. Vi har dertil også, altid en bestræbelse i vores livsførelse, nemlig at bestræbe os på, at leve et liv en overensstemmelse med den kristnelivsførelse. Derimod møder eguenikken et problem ved, som også Sandel påpeger, at dets mere vi er herre over vores egne gener dets større bliver den byrde som vi bærer på vores skuldre. Denne byrde betyder, at vi

ikke længere vil være i stand til at sætte pris på livet som det nu engang er – vi vil nemlig ikke længere være i stand til at forstå det eksistentielle gode ved en kristen livsførelse med et liv skabt af Gud men i stedet vil vi bære en byrde på vores skuldre som vi som mennesker ikke vil være i stand til at bære og vi ville ende i en livsførelse betonet af eksistential uvished.

Vi har set, at når den liberale eugenik vil inducere et grundgode, som det i øvrigt ikke kan have en objektiv vurdering af, så mister subjektet den frie tilgang til at leve et liv med eksistential mening. Dette betyder, at hvis en designer har manipuleret dets gener, så vil det ikke engang være i stand til at følge eksempelvis en kristenlivsførelse fordi, at det vil være sat uden for de rammer som netop ligger til grund for sådan en livsførelse; nemlig at livet er skabt og derved en gave. Af samme grund vil vi ikke engang kunne være i stand til at leve et universelt etisk liv som eksempelvis hos Løgstrup fordi, at der vil være en klar skillelinje mellem det subjekt som har været underlagt gendesign og det frie subjekt som er i stand til at forstå og se sig selv værende på lige fod med dets medmennesker og derved også besidde de samme etiske rammer og grundvilkår. Disse vilkår kalder Løgstrup ikke for en kristen etisk livsførelse men dets fundament er bygget på sådanne, derfor mener jeg også at vi hos Løgstrup netop bliver tilbudt en eksistential kristen livsførelse som kan give et svar på hvordan vi eventuel kan leve og forstå vores liv og derved formå at besidde kontingent livshistorie og førelse; *”Der er ingen anvisning i den [fordringen], ingen forskrifter, ingen moral, ingen kasuistik, intet der tager ansvaret fra mennesket ved på forhånd at løse de konflikter, fordringen stiller det i. Alle hans ord taler om den ene fordring, men ikke med et ord bryder han dens tavshed.”*^[55] Således giver Løgstrup et eventuelt svar på, hvad Habermas ikke formår i sin kritik af den liberale eugenik, nemlig at subjektet selv skal ud i verden og agere, for at finde dets eksistentielle mening med livet og ikke blot vente på at Gud former og bestemmer vores liv. Dette betyder, at vi ikke bare kan vente på, at livet kommer til os men også at vi er frie autonome væsner som har ansvar for vores egne handlinger – handlinger som vi er i stand til at udføre som frie individer og ikke gendesignet objekter som blot er blevet reduceret og instrumentaliseret af en designer, hvor livet i-sig-selv ikke har første prioritet.

VÆRK I • AFSNIT 05

Konklusion

Selv om liberal eugenik endnu ikke er en realitet så er diskussion om hvorvidt denne kan anvendes en nødvendighed. Vi har set at der blandt filosoffer og teologer er en enighed om denne diskussion må tages op således at vi kan være på forkant med den liberale eugeniske udvikling. Derfor tager bl.a. Habermas denne diskussion op fordi at noget af det værste vi kan udstille os selv for er en tilstand af menneskelig og politisk perspektivløshed, hvor der

ikke er at finde nogle argumenter og refleksioner over hvilket liv vi påføre subjektet, hvis det bliver underlagt en designers præferencer. Denne analyse har fokuseret på argumentet om fremmedbestemmelse og hvilken perspektivløshed som et subjekt vil møde, hvis det underlægges genetiske ændringer. I afsnittet *Det filosofiske perspektiv i kritikken af liberal eugenik* har vi set, at Habermas tager udgangspunkt i nødvendigheden af en filosofisk regulering af brugen af eugenikkens muligheder. Således kan vi spørge om ikke det er en krænkelse af subjektets ret til at være et frit væsen, hvis vi ændre på dets arvemasse og tillægger det ekstraordinære genetiske egenskaber. Hovedargumentet bygger sit fundament på den kantianske tanke om at mennesket i sig selv er målet og ikke blot et middel.

I afsnittet *Perspektivløshed og fremmedbestemmelse* betoner Nicholas Agar, at subjektet er i stand til at kontrollere sine gendesignede egenskaber og hertil forsøger han at forene miljø og genetik i begrebet *nurture*. Men det viser sig at Agars indgangsvinkel må belyses fra en anden side. Det som vi må have fokus på, hvorvidt vi kan tillade os at designe subjekts gener fordi, at dette vil betyde at det vil miste sine objektive rettigheder til agere som frit væsen. Det er altså ikke et spørgsmål om at koble genetik og miljø sammen men et spørgsmål om subjektets rettigheder. Ændres subjektets gener af en designer vil der ikke længere kunne være tale om at subjekt besidder en kontingent og individuel livsførelse og historie og derved kan subjekt ende i en fremmedbestemmelse som det ikke kan være etisk korrekt at tilbyde.

At lade subjektet værende indelukket i denne fremmedbestemmelse og derved også besidde en livsførelse som er perspektivløs er en fuldstændig fordrejet etisk tanke, da subjekt vil miste sin forståelse af sin egen livshistorie og derved også forståelsen af sig selv som menneske. Hvis subjekt har kendskab til en designers genetisk indgreb så vil dette betyde at subjektet vil kunne sætte spørgsmålstejn ved dets egen eksistentielle værdi grundlag og vil forstå sig selv som objekt i verden og ikke subjekt. Dette betyder at subjekt vil have essens før eksistens – det vil være et middel og ikke et mål.

Tanken om essens før eksistens kan ikke, som liberale fortalere ellers forsøger, drages parallelt til tanken om dressuropdragelse fordi at denne i-sig-selv tilbyder en frihed som liberal eugenik ikke tilbyder; vi kan altid have frie tanker i dressuropdragelsen mens i eugenikken mister vi denne fundamentale frihed. Samtidig er et liv med gendesignede egenskaber, uanset om disse er realiseret eller ej, et brud på de fundamentale rettigheder til kontingent livsførelse som subjekt besidder.

Afsnittet *Om inducering af et grundgode og livet som gave – Kan religionen give os et svar?* er et forsøg på, at sætte spørgsmålstejn ved, hvorvidt designer kan have en objektiv tilgang til indiceringen af grundgoder. Vi ser, at det som vi kan bruge eksempelvis religion til er at vise at vi ikke selv

kan designe liv med subjektive præferencer fordi, at dette er udenfor rammerne af, hvad vi som mennesker har ret til at gøre.

Men Habermas tilbyder ikke et svar på hvad eksistentielle indgangsvinkler, som eksempelvis kristendommen, kan give. Derfor kan vi hos Løgstrup læse at, i en universal etik finder vi tanken om næstekærlighed som giver et videreførende argument for hvorfor vi ikke kan krænke menneskets ret til autonomi. Livet er en gave, skabt af noget større, hvor mennesket kan finde forståelse af sig selv ved at det altid vil have noget af den andens liv i sin hånd – dette vil ikke kunne være tilfældet hvis subjekt har været underlagt genetisk design. Livet vil her ikke være en gave men en byrde.

Endelig vil jeg påpege at, i videnskabens udvikling må vi aldrig glemme subjektet og vi må have in notits, at det ikke vil give nogen mening at tale livsforbedrende teknologi, hvis der ikke samtid tages hensyn til subjekts menneskelige side. Det vil ikke give os et bedre liv, hvis vi inducere eksempelvis en matematisk egenskab således at det bliver lettere for os at bruge matematikkens videnskabelige fordele, hvis vi ikke samtidig tager hensyn til det liv og den livsførelse som subjekt skal besidde. Jeg vil uden tøven mene, at Habermas har ret i, at følger vi den liberale tendens som vi ser hos bl.a. Agar så vil vi ende i en perspektivløs verden som vil fordærve måden vi tænker om hvad det vil sige at være menneske på.

VÆRK I • AFSNIT 06

Resumé

According to Jürgen Habermas we are in need of a philosophical regulation regarding the use of genetic enhancement to one's children. It seems that we no longer can draw the line between the natural and the manufactured and that is exactly why we are in need of such a regulation. Medical science, including liberal eugenics, has left us in a position where we no longer can take anything for granted thus we are in need of debating the eugenics issue on an ethical level. In his philosophical work *on the way to liberal eugenics* Habermas sets up what ethical issues eugenic might bring us if we unconcerned make a use of its possibilities. I have kept focus on what I regard as the main thesis in this debate: the subjective right to autonomy and what issues we will have to face if liberalist like Nicholas Agar succeed in performing genetic design. I will claim that if a designer has designed ones genes he has infringed the human right to be a free and antonyms being. This will furthermore mean that the subject of who genetic design has been conducted will end up, not only being alienated in the very world it lives in, but it will also be alienated to its own self-awareness. Nicholas Agar fails to justify the use of liberal eugenics in his article *Defence of Human Enhancement*, this is very much due to the fact that Habermas' arguments simply seem stronger and much more reasonable than those of Agar himself.

However, Habermas does not clarify what it means to be human and finding an answer to that question we have to turn to Christianity which seems to come with an existentialistic answer claiming that we are in need of greater metaphysics to understand our own self-awareness and what it means to be an independent human being.

Originale noter

Noterne er flyttet fra sidefoden til en samlet sektion. Indholdet er bevaret, mens nummereringen følger denne udgave.

1. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 140
2. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 132
3. Agar, Nicholas. In Defence of Human Enhancement. Side 113
4. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 134
5. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 137
6. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 137
7. Agar, Nicholas. In Defence of Human Enhancement. Side 117
8. Agar, Nicholas. In Defence of Human Enhancement. Side 117
9. Agar, Nicholas. In Defence of Human Enhancement. Side 117
10. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 145
11. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 146
12. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 147
13. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 142
14. Løgstrup, Knud Ejler. Den Etske Fordring side 27-28
15. Hos Løgstrup er tillid en kendsgerning, hvor man udlevere sig selv. Denne leder til fordringen om, at tage vare på det andet menneskes liv. Derved sker overgangen fra kendsgerning til fordringen umiddelbart. Fordringen selv er udtalt, den er normativ idet den ikke besidder en forskrift på bestemte handlinger.
16. Hertil finder vi også påstanden om at der ikke gives en kristen etik men en universel etik hos Løgstrup. Dog vil jeg mene, at, på grund af Løgstrup sprogbrug må der være tale om, ikke nødvendigvis en kristen etik, religiøs etik som bygger dets fundament på noget større end mennesket, nemlig det faktum at livet er skabt af noget eksternt og derved skal forstås og leves som en gave.
17. Løgstrup, Knud Ejler. Den Etske Fordring
18. Dette skal ikke forstås således, at subjekt i egen selvforståelse altid vil være afhængig af Gud men at subjekt altid vil kunne forme og forstå sin egen livshistorie som værende kontingent og autonom.
19. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 152
20. Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik. Side 154

- 21.** Kant, Immanuel. Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 87
- 22.** Luther, Martin. Om Verdslig Øvrighed Side 85
- 23.** Sandel, Michael J: The Case Against Perfection; what´s wrong with designer children, bionic, and genetic engineering Side 60
- 24.** Sandel, Michael J: The Case Against Perfection; what´s wrong with designer children, bionic, and genetic engineering Side 61
- 25.** Løgstrup, Knud Ejler. Den Etiske Fordring Side 126

VÆRK II • SPECIALEFORBEREDENDE PRØVE

Autonomi og etik i sygeplejen

Projektets metode, begreber og planlagte etiske bevægelse

Genre	Specialeforberedende opgave
Originalt omfang	12 afleverede PDF-sider
Kildevalg	DOCX fra mappen Til aflevering
Redaktion	Ordlyd bevaret; noter samlet efter værket

VÆRK II • AFSNIT 01

Præsentation af speciale-projekt

Jeg vil i denne specialeforberedende prøve præsentere mit kommende speciale-projekt, som omhandler autonomi og etik i sygeplejen og konflikten mellem omsorg og respekt. Således vil jeg rent metodisk starte med Immanuel Kants autonomibegreb, hvori vi vil se, at moralloven sikrer fornuftsvæsnet intrinsisk værdi. I sygeplejen må man i kantiansk optik respektere den enkelte patients værdighed. Denne værdighed kan i visse tilfælde være problematisk, da den bevæger sig mellem autonomi og paternalisme. Jeg vil i afsnittet *Om forholdet mellem autonomi og paternalisme* opstille visse kriterier for autonomi. Disse er nødvendige i forhold til, hvorledes sygeplejer skal forholde sig til patienten; en autonom patient skal respekteres grundet dennes autonomi, men hvis en patient, som ikke lever op til autonomien minimumskriterier eller besidder et kohærent præferencesystem, så skal disse ikke behandles med henblik på pligtetikken men med henblik på konsekvenser og idealer. Dette betyder, at der i præsentationen er en gennemgående rød tråd, som består af, at sygeplejeren altid skal vise omsorg for patienten. Vi vil se, hvorledes dette omsorgs begreb udvikler sig fra pligtetikens respekt for autonomi til en mere omfattende ideal profil, som tager udgangspunkt i patienten som værende et menneske med et kohærent præferencesystem, vis værdier bør respekteres. I afsnittet *Personlig integritet og værdighed – at handle med omsorg* vil vi se, at krænker man patientens autonomi, så krænker man også dennes værdighed. Men da mennesket altid

er et mål-i-sig-selv, må vi forsøge at bevare dets værdighed. Dertil må vi bruge forskellige teoretiske modeller blandt andre; pligtetik, konsekvensetik og ideal etik.

Jeg har forsøgt at præsentere en klar struktur, som giver udtryk for mit kommende speciale-projekts indhold; dog uden at gå rent teoretisk til værks, da der i dette blot er tale om en præsentation og ikke en egentlig analyse.

VÆRK II • AFSNIT 02

Til besvarelse af spørgsmålet mellem autonomi og etik i sygeplejen vil jeg gøre brug af følgende litteratur:

Grundlæggelse af sædernes metafysik skrevet af Immanuel Kant. I det teoretiske perspektiv vil vi se, hvorledes Immanuel Kant udvikler sit frihedsbegreb, som lader sig forbinde med viljens autonomi, hvorved frihed er en egenskab ved fornuftsvæsnet. I dette finder vi den kantianske tanke om det kategoriske imperativ, hvori alle fornuftsvæsner skal behandles som værende mål-i-sig-selv.

Om Friheden skrevet af John Stuart Mill. Dette værk er centralt i tanken om mennesket som værende et frit væsen, hvori det kan, hvis det besidder blot en nævneværdig sum af fornuft, skabe sit eget liv. Mills friheds begreb er incitamentet for dannelse af eget liv; et liv som må grunde i vores autonomi og evne til selv at vælge. Denne tanke leder hen på Childress og Beauchamps værk; *Principles of biomedical ethics*, hvori jeg vil vise, at før vi kan tale om autonome valg, må vi have et minimumskriterium, som patienten skal kunne leve op til. Dette er nødvendigt i forhold til de valg, patienten ønsker at foretage i henhold til behandling og dialog med både læge og sygeplejer. Således må patienten, for at sygeplejeren kan handle med omsorg og integritet, kunne redegøre for sit kohærente præferencesystem. Til præsentation af kohærente præferencesystemer præsenteres Laura Waddell Ekstroms *Autonomy and Personal Integration*. Heri vil jeg vise, at patienten i sine valg skal kunne argumentere sine valg af livsværdier og præferencer; dette sker i kraft af dennes integrerede selv.

Af øvrigt litteratur vil jeg gøre brug af Knud Ejler Løgstrups *Den Ethiske Fordring*, hvori vi vil se, at sygeplejeren må handle med omsorg og tillid, hvilket i bedste fald kan lade sig gøre, hvis patienten er i stand til, autonomt, at redegøre for sine livsværdier og præferencer. Endelig vil jeg gøre brug af Jørgen Husteds etiske hjul fra *Etik og værdier i socialt arbejde*, som viser de etiske overvejelser en sygeplejer skal gøre sig brug af; pligt, konsekvenser og idealer.

Moralsk autonomi

Begrebet *moralsk autonomi* betyder, at mennesket som fornuftsvæsen formår at abstrahere fra egne subjektive og egocentriske formål for til gengæld at anerkende mennesket som værende besiddende af formelle principper, hvori en god og fri vilje forefindes. Denne kantianske tankegang er et vigtigt fundament for etik i sygeplejen, da den følger, at man som fornuftsvæsen står til ansvar for egne handlinger og valg. Det vil sige, at man som fornuftsvæsen forpligter sig i og med, at man i kraft af en forudsættende frihed er i stand til at bestemme, hvorledes man skal handle i en given situation. Jeg vil i det følgende skitsere det kantianske autonomibegreb for at demonstrere, hvorfor dette er det centrale punkt i henhold til autonomi og etik i sygeplejen; man skal respektere patienten som mål i sig-selv og ikke som middel.

Tesen om moralsk autonomi er funderet i Immanuel Kants kategoriske imperativ, som lyder; *"Handl kun ifølge den maksime ved hvilken du samtidig kan ville, at den bliver en almengyldig lov."*^[1] Ved tanken om autonomi fordres det, at et fornuftsvæsen, i kraft af evnen til selvbestemmelse, er i stand til selv at bestemme, hvorledes det handler og tænker i en given situation. I dette finder vi fordringen om at respektere, ikke kun sig selv, men også medmennesket som værende et autonomt fornuftsvæsen, hvilket i sygeplejen er afgørende, hvis ikke vi skal ende med paternalistiske indgreb. Derved bliver Kants kategoriske imperativ en regel, som man skal følge i kraft af, at denne er en almen gyldig regel – en regel som funderes i moralloven. Denne lov er a priori, uafhængig af alt erfaring; det vil sige, at den er en vejledning, som funderes i en agtelse for pligten. At loven er a priori betyder, at det, som får fornuftsvæsen til at foretage sine moralske valg, ikke forefindes i den empiriske verden. Derved kan fornuftsvæsenet, ved at rette sig efter moralloven, se bort fra de sin egen sanselige natur. Grundlæggende vil det sige, at fornuftsvæsenet selvfølgelig besidder naturlige tilbøjeligheder (som alle andre naturvæsner); disse naturlige behov er drivkraften for den menneskelige vilje. Viljen kommer eksempelvis til udtryk i et klart formuleret, defineret valg – når viljen er bestemt, følger handlingen. Det centrale i dette er viljen, og hvorledes moralloven kommer på tværs af denne. Dette betyder, at vi som fornuftsvæsner kan gå fra at ville naturlige tilbøjeligheder til at ville adlyde moralloven. Således kan fornuftsvæsenet frigøre sig fra sin sanselige natur. Jeg vil i dette ikke gå i nærmere teoretisk analyse, men det interessante er, hvorledes det valg, som et fornuftsvæsen foretager, forholder sig i henhold til sygeetikens pleje. Det, som vi skal have fokus på, er værdien af en handling; eksempelvis værdien af en sygeplejerskes handlen og hvilke overvejelser denne inddrager i pleje og behandling af patienten. I værket *Grundlæggelse af sædernes metafysik* giver Kant flere formuleringer af det

kategoriske imperativ, hvori det påpeges, at uanset hvor venlig, godsindig en handling af eksempelvis en eventuel patient kan være, så må vi i denne behandling ikke tale om tilbøjeligheder, uanset konsekvenserne. Behandler en sygeplejer en patient uden agtelse for pligten, så er denne sygeplejerskes handlen ikke værdifuld; *"Alt hvad der er genstand for tilbøjelighederne har kun en betinget værdi, for hvis tilbøjelighederne og de derpå funderede behov ikke eksisterede, så vil deres genstand være værdiløs^[3]."* Havde sygeplejeren handlet i henhold til loven, det vil sige truffet sine valg i henhold til denne på trods af, at denne kunne have været en lurendrejer af natur, så bliver dennes agtelse for pligten udført med hæderlighed, og der vil derfor være tale om handlen som besidder den højeste moralske karakter i kraft af, at denne ikke udføres ud fra tilfældige tilbøjeligheder men af pligt.

Det kommende speciale-projekt vil i dette gå analytisk til værks, hvori jeg vil belyse, hvorledes Kant argumenterer for denne konklusion. Vi vil se, at der er en sammenhæng mellem etik i sygeplejen og fordringen om agtelse for moralloven og tanken om den menneskelige værdighed. Pligten må for sygeplejeren i-sig-selv være et tilstrækkeligt motiv for dennes handlen. Dette skyldes, at sygeplejeren selv besidder evnen til at foretage valg i kraft af sin vilje og autonomi. Men denne har også at gøre med en patient, som er af lige karakter som plejeren selv; patienten er nemlig ofte også et fornuftsvæsen, og skal af pligt derfor behandles som sådan. Således konkluderer Kant; *"Jeg hævder da, at mennesket og i det hele taget ethvert fornuftsvæsen eksisterer som mål i sig selv, ikke blot som middel til vilkårlig for denne eller hin vilje; tværtimod må det i sine handlinger, både når de er rettede mod det selv og mod andre fornuftsvæsner, altid tillige betragtes som mål.^[3]"* Moralloven er således et udtryk for, ikke kun fornuftsvæsnets værdi, men også en fordring om at sikre denne værdi. Fornuftsvæsnet er derved af intrinsisk værdi – uafhængigt af de eventuelle konsekvenser en handling må have. Derved må man i sygeplejen respektere, at den enkelte patient besidder værdighed og er i stand til at fordr sine egne autonome love i kraft af viljen og dennes forhold til moralloven. I dette, og det gælder både sygeplejeren og patienten, gives en almen gyldig lov, som gælder begge parter; derved besidder begge et ansvar for deres handlinger og valg, heri princippet om viljens autonomi. I kantiansk forstand er begge parter, samt øvrige fornuftsvæsner i formålenes rige, forenet ved fælleslov, hvilket betyder, i behandlingshenseende, at anser vi mennesket som værende altid et mål-i-sig selv, kan vi som ideal se bort fra de menneskelige uligheder; dette er i praksis en nødvendighed, som så vidt muligt må forsøges at opretholdes, således at der ikke bliver forskelsbehandlet patienter imellem.

Således har jeg tiltænkt mig at bruge Immanuel Kant som værende den, som skaber det teoretiske grundlag for speciale-projektets autonomibegreb; hertil forefindes fordringen om at respektere fornuftsvæsnet som altid

værende et mål i-sig-selv og aldrig et middel. I moralske dilemmaer står den kantianske pligtetik ofte stærkt, da den viser, at vi som mennesker må træffe etiske valg i vores livsforløb. Men disse valg er ikke bare tilfældige; de er funderet i en agtelse for moralloven og pligten, og det er heri, at den moralske handling finder sin værdi.

VÆRK II • AFSNIT 04

Om forholdet mellem autonomi og paternalisme

Det kantianske autonomibegreb forudsætter, at fornuftsvæsenet er mål i-sig-selv i kraft af, at det er et selvbestemmende væsen, hvori det er i stand til at træffe egen handling og valg. Indenfor sygeplejen – og medicinsk etik generelt – står dette forhold i kontrast til begrebet paternalisme, som betyder formynderi. Dette betyder, at andre mennesker kan vælge ikke at respektere patientens autonomi og i stedet forvalte beslutninger for denne. Umiddelbart er paternalisme af negativ karakter, hvori den enkelte ikke besidder myndighed, og den kantianske frihed lader til ikke at være til stede. Men spørgsmålet er så, om vi altid skal respektere patientens autonomi på trods af, at dennes valg – hvis denne er i stand til at foretage sådanne – ikke stemmer overens med behandlers og sygeplejerskes foretrukne behandlingsmetode. Tænk eksempelvis på Knud Ejler Løgstrups udsagn; *”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”*⁴¹ og hvorledes dette spiller ind, når patienten er blevet rådgivet til en specifik behandling, som eventuelt kan være med til at sikre dennes helbred, men vælger ikke at lade sig behandle eksempelvis grundet religiøse årsager. Hvis vi altid holder noget af den andens liv i vore hænder, er det så ikke vores pligt at sikre denne det bedste? I dette skal vi skildre mellem at forhindre et onde og påføre et gode; ved først nævnte kan vi tale om en blød-paternalisme, hvori det vil være muligt at påvirke den berørtes adfærd og holdning samtidig med, at dennes autonomi respekteres. Jeg vil i dette argumentere for, at ikke al form for paternalisme er moralsk uforsvarligt; i denne paternalistiske form forefindes nemlig, at sygeplejeren tager ansvar for patienten og ikke fra patienten. Dette betyder, at der ikke foreligger nogen bedrevenhed og påførelse af goder. I sidstnævnte bliver paternalismen af streng karakter, hvori patientens autonomi ikke bliver taget med i behandlingsovervejelserne, og derved respekteres denne ikke som værende et frit fornuftsvæsen, hvori også dennes værdighed og integritet krænkes.

Blød-paternalisme er i min optik ikke nødvendigvis af negativ karakter; en patient kan afstå retten til selvbestemmelse, og dermed frasiges ansvaret for egen selvoprettelse, og behandler og sygeplejer bliver derved ansvarlige for patientens valg; dette er den bløde-paternalisme udtrykt i én medmenneskelig forstand, hvori patienten anerkender Løgstrups tanke, om man altid har noget af den andens liv i sine hænder (i dette anerkender patienten, at det er

behandleren, som har dennes liv i sine hænder) og derved viser ubetinget tillid til behandleren og sygeplejeren samtidig med, at disse anerkender patienten som værende mål-i-sig-selv, og derved bevares dennes integritet og værdighed. Denne form for selvbestemmelse må antages værende funderet på fornuft og indsigt; således må behandler og sygeplejer antage, at patienten lever op til et minimumskriterium for sine autonome valg. Til at belyse dette minimumskriterium vil jeg bruge James F. Childress og Tom L. Beauchamps *Principles of Biomedical Ethics*, som funderer det autonome valg på *intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse*^[5]. Således vil jeg argumentere for, at det i dette forhold må gælde, at behandler og plejer skal respektere patientens valg, hvis denne er i stand til at kunne træffe sine valg på minimumskriteriets grundlag. Derudover vil jeg argumentere for, at der i de større valg, det vil sige i valg og beslutninger, som har indflydelse på livsanskuelser og værdier, skal tilføjes et ekstra kriterium; refleksion. Dette skal kunne stemme overens med vores kohærente præferencesystem, som danner grundlag for vores integrerede selv. Til dette benyttes Laura Waddell Ekstrom, som skelner mellem patientens autonome valg og det autonome menneske, som ligger bag disse valg. Det vil sige, at vi skal fokusere på patientens autonomi og personlig integritet og ikke kun dennes valg.

Denne skildring er nødvendig, hvis vi skal være i stand til at kunne vurdere, hvornår man skal respektere en patients autonomi og dertilhørende valg, og hvornår man ikke skal; eksempelvis kan vi forestille os tilfælde, hvor paternalisme, blød som hård, er nødvendigt, hvis vi kun forholder os til den kantianske pligt etik. Det følgende eksempel viser ét dilemma, som sygeetikken ofte konfronteres med; hvem skal bestemme og hvorfor:

"Da Sigmund Freud lå for døden, havde han frygtelig smerter og fik tilbudt morfin. Imidlertid satte han værdien af et klart hoved højere end værdien af smertefrihed og takkede nej. Ud fra en almindelig betragtning ville man mene, at det bedste for Freud var smertelindring. Ud fra Freuds egen betragtning var det imidlertid ikke det bedste. Det sidste betyder, at lægen kun kunne realisere sin traditionelle værdi ved at følge Freuds egen beslutning^[6]*."*

Udgangspunktet for henholdsvis behandler og sygeplejer er at sikre patientens bedste; som værende et mål-i-sig-selv. Da der er tale om professionsetik må vi naturligvis antage, at disse er klar, over hvilke konsekvenser som kan forekomme, hvis patienten, i dette tilfælde Freud, ikke ønsker at modtage behandling. På den anden side vil speciale-projektet argumentere for, at så længe patienten lever op til minimumskriteriet for autonomi samt besidder et kohærent præferencesystem, må dennes valg og autonomi respekteres, og derved må behandler acceptere, at den berørte patient ønsker at gennemleve et sygdomsforløb uden smertelindring. På den anden side er det ikke altid tilfældet, at patienten besidder autonomi, og

derved skal dennes ønsker ikke respekteres. Denne problematik vil udgøre specialet-projektets kerneområde; vi vil se, at det umiddelbart virker intuitivt forkert at udøve paternalisme, men i visse tilfælde kan det forekomme nødvendigt. I henhold til eksempelet med Freud må vi inddrage øvrige omstændigheder for, at vi kan komme til en klargørelse af, hvorvidt den professionelle skal respektere Freuds selvbestemmelse og autonomi eller ej. Behandlerens og sygeplejerskens hovedformål er at sikre patientens bedste – og ovenstående eksempel kan forekomme som et grænseeksempel mellem at sikre patientens medicinsk bedste og sikre, at patienten bevarer sin værdighed og integritet ved at respektere dennes autonomi. Mit argument skal lyde, at behandler kan forlange af Freud, at han skal kunne argumentere for sit valg. Det vil sige, at Freuds ønske må funderes på mere end blot et enkelt udsagn. Han skal kunne give behandler en god grund for, hvorfor han ønsker ikke at modtage den anbefalede behandling. Eksempelvis kunne behandlingen kontradiktere med Freuds´ integrerede selv, og derved kunne en eventuel behandling med morfin være i et modstridende forhold med Freuds´ værdigrundlag og præferencesystem. Derved formår han at retfærdiggøre sit ønske på et rationelt grundlag. I tilfælde af at Freud ikke er i stand til at kunne give et rationelt svar, vil jeg mene, at hans valg ikke skal respekteres; dette skyldes, at han ikke giver et fornuftigt grundlag for sit valg, og vi kan derved sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt Freud foretager sit valg og ønske som et integreret og autonomt selv. Dette betyder, at besidder patienten ikke evnen til at kunne forsvare sin autonomi, så kan vi bevæge os væk fra den kantianske pligtetik og vende os mod nytteetikens konsekvens, hvorved den professionelle må handle med etisk ansvarlighed og integritet for at kunne fremme patientens selvbestemmelse.

VÆRK II · AFSNIT 05

Personlig integritet og værdighed – at handle med omsorg

Ovennævnte forhold betyder, at patientens autonomi skal respekteres, så længe denne er til stede. Anerkendelse af patientens værdighed er ofte én respekt for autonomien, da man accepterer, at patienten ikke kan udsættes for værdighedskrænkelser. Dette betyder, at man eksempelvis ikke kan nægte at behandle en patient i tilfælde af, at denne besidder andre livsanskuelser og præferencer end én selv. Krænker man patientens autonomi, krænker man også patientens værdighed. Således er der en sammenhæng mellem Kants ytring om mennesket som mål-i-sig-selv og dennes værdighed. Dette er en vigtig sammenhæng, da værdighed er i stand til at beskytte patienter, som ikke nødvendigvis er autonome; eksempelvis skal en psykisk syg patient behandles med hævde af dennes værdighed, fordi denne er et mål-i-sig-selv. Ganske vist formår patienten ikke at leve op til autonomiens minimumskriterier, som

udlagt hos Beauchamp og Childress, og derved kan denne ikke nødvendigvis foretage et autonomt valg samtidig med, at patienten måske heller ikke besidder et kohærent præferencesystem, som udlagt hos Ekstrom, men denne er stadigvæk et fornuftsvæsen, som kræver respekt i kraft af, at denne er et mål-i-sig-selv. Dette er på trods af, at denne måske ikke besidder samme mængde fornuft som et fuldt funktionelt fornuftsvæsen, men der er stadig tale om et menneske, som besidder iboende værdi. Netop derfor har både behandler og sygeplejer en pligt til at behandle sådanne patienter med værdighed og omsorg. Er tilfældet, at der ikke er nogen autonomi at respektere, så må behandler og sygeplejer vende sig væk fra pligtetikken respekt for autonomi til nytteetikken konsekvens, hvori patienten skal behandles, således at dennes selvbestemmelse fremmes, og derved kan være i stand til at skabe en tilværelse, hvori denne har en vis magt over sin egen tilstedeværelse. Dette betyder, at man i behandlingen af sådanne patienter ikke blot kan gøre brug af pligtetik og konsekvensetik; en sygeplejer må derfor også selv handle efter egne idealer, som skal virke som en slags tommelfingerregel i behandling af patienter. Det er klart, at sygeplejeren i akutte situationer ikke har tid til at overveje en kritisk situation med teoretisk etisk analyse. Derfor må plejeren i sin handling besidde etiske idealer, som denne kan begrunde sine overvejelser med. Således må sygeplejeren handle med integritet, omsorg og med dømmekraft^[7].

Integritet er et vigtigt begreb i behandlingen. Ikke kun sygeplejerens egen professionelle integritet, men også patientens personlige integritet. Sidst nævnte er absolut vigtigst i henhold til behandlingen og plejen af patienten. Integritetsprincippet henviser til det urørlige menneske, at mennesket via fornuften er mål-i-sig-selv. Integriteten er således dét, som identificerer og definerer den enkelte patient. Således kan vi vende tilbage til Laura Waddell Ekstrom kohærente præferencesystem, hvori den enkelte skaber sit eget selv og sin egen tilværelse i kraft af det integrerede selv. Dette betyder, at det, som er i spil, når en patient behandles og plejes (udover dennes helbred), er autonomi og personlig integration; *"Motivated, in part, by reflection on particular and motivated, as well, by the problem of regress for hierarchical accounts, a coherence approach to autonomy specifies that the preference on which a person acts must cohere with other of his other attitudes, in order for the act to be autonomously performed."*^[8] Således skal sygeplejeren behandle patienten med respekt for dennes værdier. Disse er ikke blot noget som kan overses, da de er en del af patientens integrerede selv, hvori værdier, præferencer, valg og ønsker har deres udspring. Sygeplejeren har en pligt til at respektere dette på samme måde, som patienten har en pligt til at kunne forsvare og begrunde sit værdisystem.

Dette betyder, at sygeplejeren må have respekt for patientens værdighed og integritet samt også respekt for de værdier, som patienten besidder i kraft

af det integrerede selv. Hertil kan vi vende tilbage til det paternalistiske problem, for i dette kan der forekomme konflikter mellem omsorg og respekt. Sygeplejeren skal ikke kun vise respekt men også omsorg, hvilket vil være et centralt emne i speciale-projektets udformning. Jeg vil forsøg at besvare dette problem, som skitseret ovenfor, med henvisning til Kant, Beauchamp og Childress samt Ekstrom og til dels Løgstrup. Dertil vil jeg forsøge at skildre paternalisme og respekten for det integrerede selv ved brug af John Stuart Mills *Om Friheden*. Mill er interessant i denne kontekst, fordi han giver plads til den enkeltes udfoldelse og selvstændighed; *"Hvis en person besidder så meget som en nævneværdig sum af sund fornuft og livserfaring, er hans egen måde at indrette sig i livet på den bedste – ikke fordi den er den bedste isoleret betragtet, men fordi den er hans egen^[9]."* Hos Kant så vi, at det centrale er pligten – det vil sige, at vi eksempelvis har pligt til at opretholde vores egen eksistens. Følger vi Mills udsagn, så kan vi eksempelvis modsvare dette eksemplificeret ved et Jehovas Vidne, som frasiger sig en blodbehandling, fordi sådanne ikke ville passe ind i dennes kohærente præferencesystem samt, at sådanne behandling, forudsat tvang, ikke vil være dennes egen måde at indrette sig i livet på. Der vil i Mills henseende ikke kunne være tale om det bedste liv, da paternalismen gør, at man ikke selv indretter dette. Og netop dette er det grundlæggende problem; hvorledes kan man behandle en patient således, at dennes liv er dets eget samtidig med, at man som professionel har pligt til at ville denne det bedste – på trods af at dette ikke nødvendigvis er patientens eget bedste? Derved opstår et dilemma for sygeplejeren; skal denne vise omsorg i form af pligt, hvori patientens autonomi ikke nødvendigvis respekteres, men man sikrer, at denne ikke forvolder skade på sig selv eller betyder omsorg, at man viser respekt for patientens egne ønsker og præferencer, som i sidste ende kan betyde, at patientens helbred forværres?

VÆRK II • AFSNIT 06

Sammenfatning

Ovennævnte er en skitsering af mit kommende speciale-projekt. Som udgangspunkt vil jeg starte med teoretisk analyse, hvor Kants autonomibegreb bliver det centrale område. Hertil skitseres øvrige centrale teorier som udlagt af henholdsvis Mill, Beauchamp og Childress samt Ekstrom. Jeg har i denne specialeforberedende prøve forsøgt at give en klar struktur over konflikten mellem sygeplejerens ansvar for at vise patienten omsorg og dertilhørende konflikt med respekten for autonomi. Vi vil se, at pligtetikken moralske autonomi er i konflikt med patientens personlige autonomi; en autonomi som skabes på grundlag af et kohærent præferencesystem. Sygeplejeren må have respekt for dette kohærente system, da den enkelte altid er et mål-i-sig-selv, hvori dennes værdighed og integritet skal behandles med omsorg. Derved vil

vi se, at der i sygeplejesektoren, og sundhedssektoren generelt er et modsætningsforhold mellem autonomi og paternalisme. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den enkelte også skal respekteres, hvis der ikke er nogen autonomi at respektere.

Specialet vil bevæge sig fra teori til praksis – eksempelvis vil der blive inddraget cases for at vise, hvorledes sygeplejeren må forholde sig til et etisk dilemma under forskellige forudsætninger. I forlængelse af de praktiske forhold vil Ekstrom samt Beauchamp og Childress bruges til at vise, hvorledes forskellige situationer kan adskille sig fra hinanden; hvis der er en autonomi at respektere, så skal denne også respekteres, men er der ikke en autonomi, så skal denne ikke respekteres. Dette betyder dog ikke, at vi kan påføre patienten hvilket som helst gode; for patienten er stadig et mål-i-sig-selv, og derved må vi forsøge at handle med respekt for dennes integritet og værdighed. Hertil vil jeg forsøge at identificere en række cases, hvorved vi vil se, at man ikke blot kan adskille pligtetikken fra nytteetikens konsekvenser. Med disse in mente må vi også belyse sygeplejerens idealer; hertil er fordringen at handle med integritet, omsorg og dømmekraft.

VÆRK II • AFSNIT 07

Litteraturliste

Childress, James F. og Tom L. Beauchamp: *Principles of Biomedical Ethics*. 3. Udgave.

Oxford University Press, 1989.

Ekstrom, Laura Waddell: *Autonomy and Personal Integration*. Fra: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Redigeret af Taylor, James Stacey. Cambridge University Press, 2005.

Husted, Jørgen: *Etik og værdier i socialt arbejde*. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag, 2009

Kant, Immanuel: *Grundlæggelse af Moralens Metafysik*. Fra: De Store Tænkere. Berlinske Forlag, København, 1979.

Løgstrup, Knud Ejler: *Den Ethiske Fordring*. 9. Oplag. Gyldendal, København, 1975.

Mill, John Stuart: *Om Friheden*. Fra: Mill om friheden; *Oversættelse og Guide* af Jørgen Husted. Philosophian, Aarhus, 2008

Originale noter

Noterne er flyttet fra sidefoden til en samlet sektion. Indholdet er bevaret, mens nummereringen følger denne udgave.

1. Kant, Immanuel. Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 78
2. Kant, Immanuel. Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 87
3. Kant, Immanuel. Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 87
4. Løgstrup, Knud Ejler: Den Etske Fordring. Side 25
5. Cildress, James F. og Beauchamp, Tom L: Principles of Biomedical Ethics. Side 69
6. Husted, Jørgen: Etik og værdier i socialt arbejde. Side 135
7. Husted, Jørgen: Etik og værdier i socialt arbejde. Side 137
8. Ekstrom, Laura Waddell: Autonomy and Personal Integration. Side 144
9. Mill, John Stuart: Om friheden. Side 90

VÆRK III • SPECIALE I FILOSOFI

Autonomi, etik og sygepleje

En filosofisk analyse og diskussion om forholdet mellem autonomi og etik i sygeplejen

Institution	Aarhus Universitet
Vejleder	Jørgen Husted
Studieordning	Kandidat/2007
Originalt omfang	74 sider · 175.824 typeenheder
Redaktion	Ordlyd bevaret; identifikator udeladt; noter samlet

VÆRK III • AFSNIT 01

Indledning

Udgangspunktet for specialet er en filosofisk analyse og diskussion om forholdet mellem autonomi og etik i sygeplejen. Analysen og diskussionen vil vise, hvilke teoretiske redskaber en sygeplejerske skal have kendskab til for at kategorisere en patients evne til at besidde egenskaben autonomi. Heri også evnen til at skelne mellem det autonome valg og den autonome person. Således forefindes to hovedpunkter i specialet; hvornår kan sygeplejersken retfærdigvis klassificere patienten som autonom eller ikke-autonom, og hvorledes skal sygeplejersken forholde sig til forholdet mellem autonomi, pleje og behandling? Vi vil se, at sygeplejersken skal være i stand til at fremme kvalitet af sine etiske overvejelser, således at beslutningsgrundlaget for sygeplejerskens overvejelser sker på et velbegrundet grundlag, hvori hun er etisk i stand til at argumentere for og imod hendes valg.

Indledningsvis præsenteres den tyske filosof Immanuel Kants autonomibegreb som grundfundamentet i sygeplejens etiske univers, det Kategoriske Imperativ. Imperativet fremstår som et moralsk ideal, hvori fornuftsvæsnet har agtelse for moralloven og pligten, heri respekten for medmennesket samt egen person. Via fornuften er den enkelte i stand til at

agere som et frit selvlovgivende væsen; det vil sige, et menneske med egenskaben autonomi. Den kantianske pligtetik defineres således som en moralsk autonomi, hvori fornuftsvæsenet, i denne optik sygeplejersken, tilsidesætter egne interesser og øvrige tilbøjeligheder for derimod at anerkende medmennesket, patienten, som et mål-i-sig-selv. Dermed sikres, at sygeplejersken, i kraft af det kantianske frihedsbegreb som forudsætter autonomi, kan erkende samt udføre moralsk værdifulde og begrundede handlinger, hvis motiv er pligten.

I afsnittet *Kant i praksis – om anvendelse af det kantianske autonomibegreb* gøres det kantianske autonomibegreb praksis anvendeligt. Dertil bruges filosofen Tom L. Beauchamps kantianske tilgang til autonomi. Ved at opstille et minimumskriterium for autonomi tilbydes sygeplejersken et redskab til at vurdere, hvorvidt en patient er i stand til at træffe autonome valg. Det skal noteres, at Beauchamps autonomibegreb begrænses i og med, at det udelukkende fokuserer på det autonome valg og ikke det autonome menneske. Dette betyder selvfølgelig også, at vi, i visse situationer, må stille os kritiske over for Beauchamps teori, da denne, i forlængelse af Kant, ikke besidder et bredt nok perspektiv i autonomiens henseende. Dette betyder, at det snævre autonomibegreb, som Beauchamp præsenterer, ikke er bredt nok i sin anvendelse; det sikrer patienten fundamentale rettigheder, såsom respekt for autonomi, men det udelader, via sin isolerende tilgang til hvert enkelt fornuftsvæsen, flere facetter i definitionen af autonomi. I afsnittet *Fra moralsk til personlig autonomi* vises, hvorledes vi bliver nødt til at skelne mellem disse to autonomibegreber således, at vi kan inddrage patientens egne værdier i pleje- og behandlingsforløbet.

I belysningen af denne problematik inddrages i analysen en case omhandlende en lungecancerpatient. Vi vil se, at denne patient ikke besidder autonomi, og at vi derfor har brug for et redskab til at assistere hende til, på sigt, at være i stand til at (gen)besidde denne egenskab. Dette redskab finder vi hos Laura Waddell Ekstrom, som præsenterer en kohærent præference teori, som tilføjer autonomibegrebet et lag, som den kantianske optik ikke inddrager; et refleksivt lag, hvorved sygeplejersken, ved brug af dette redskab, kan vurdere samt forstå patientens definition af *det gode* og derved kan tilrettelægge en eventuel pleje og behandling herefter. Dette vil sige, at patientens værdi og karaktersystem inddrages i kraft af dennes integrerede selv. Med tilføjelsen af dette ekstra lag, bliver autonomiens grundlag derved også til en bredere kompleks teori, hvorved flere facetter nødvendigvis må inddrages. Derved bliver begrebet autonomi til en facet af begrebet selvbestemmelse; en patient skal være i stand til at besidde facetterne selvudvikling, selvstyre og selvansvar samt autonomi for at besidde evnen selvbestemmelse. Dette vil sige at være i stand til at besidde magt over egen tilværelse. Er patienten ikke i stand til dette, skal sygeplejersken medvirke til,

at dennes selvbestemmelses evne, så vidt muligt, fremmes, således at patienten vil være i stand til at træffe større valg, som har indflydelse på dennes livsforløb, og derved vil være i stand til at etablere et kohærent præference system, som stemmer overens med vedkommendes integrerede selv.

I tilfælde af at patienten rent faktisk lever op til de krav, som selvbestemmelses begrebet indbefatter, kan sygeplejersken ikke retfærdiggøre at gå imod patientens ønsker, da dette vil være en krænkelse af patientens autonomi og derved også værdighed og integritet. Sådanne tilfælde belyses og diskuteres i afsnittet *Konflikten mellem den personlige autonomis begrundede valg og paternalisme*, hvor en patient - psykoanalytikeren Sigmund Freud - begrundet, hvorfor han ikke vil indtage den professionelle anbefalede medicin. Forskellen på Freud og lungecancerpatienten er, at Freud netop er i stand til at begrunde sit valg, mens lungecancerpatienten ikke kan. Derved må sygeplejersken acceptere Freuds valg, mens tilfældet med lungecancerpatienten gør, at sygeplejersken må forsøge at bidrage til, at patienten kan besidde en større grad af selvbestemmelse og derved, på sigt, være i stand til at begrunde sit valg. Inden dette er tilfældet, kan vi ikke tale om et ønske, som nødvendigvis skal respekteres.

Ekstrom repræsenterer en konsekvensbetragende etik, hvorved det netop er tilfældet, at sygeplejersken må vurdere, hvilke konsekvenser ville være bedst for patienten i henhold til et specifikt præference system, og hvorvidt sygeplejersken kan bidrage til, at patientens pleje og behandling inddrager disse, således at patienten kan bevare sin værdighed.

Problematikken ved henholdsvis pligtetik og konsekvensbetragende etik er, at de som sådanne ikke indbefatter patienten på et medmenneskeligt plan. Disse to etikker er ikke i stand til at udøve omsorg, som er en af sygeplejeetikens grundlæggende værdier. Dette medmenneskelige perspektiv inddrages i afsnittet *Om forholdet mellem autonomi og omsorg*, hvor teologen Knud Ejler Løgstrups etiske fordring bidrager med et perspektiv om medmenneskelighed, som de to øvrige teorier ikke kan inddrage. Dog må vi nødvendigvis også forholde os kritisk til omsorgsidealet i sygeplejen, hvilket diskuteres i afsnittet *Kritik af det ontologiske omsorgsideal*, hvori der argumenteres for, at vi må have objektive rammer for, hvorledes en patient skal behandles, således at vi i plejen ikke blot antager, hvad der er den korrekte pleje og behandling for patienten, men rent faktisk har et teoretisk grundlag for at vurdere og begrunde den specifikke pleje og behandling.

I afsnittet *De Sygeplejeetiske Retningslinjer – Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis*, anskuer vi forholdet mellem autonomi, etik og sygepleje i et praksisorienteret perspektiv. På baggrund af de tre teorier, vi har analyseret og diskuteret, anvender vi den Professionsetiske

Beslutningsmodel og de principper, som omhandler sygeplejerskernes praksisstandarder samt mål og værdier til at give en praksisredskab for, hvorledes sygeplejersken skal forholde sig til et specifikt etisk dilemma. Derefter følger afsnittet *Case analyse*, hvorved vi vil se, hvorledes sygeplejersken skal være i stand til at løse et etisk dilemma med de redskaber, vi har stillet til rådighed; pligt, konsekvensbetragtelse og omsorg.

Vi vil i dette se, at sygeplejersken aldrig udelukkende må tænke i etiske endimensionelle ideologiske baner; man skal nødvendigvis vurdere, hvilke valg er bedst for en mulig løsning af et etisk dilemma ved at anskue dilemmaet ud fra alle tre etiske positioner, hvilket afslutningsvis præsenteres i specialets konklusion.

VÆRK III • AFSNIT 02

Metodeovervejelse

Specialet udspringer af et ønske om at belyse de forhold, som spiller ind i forholdet mellem autonomi, etik og sygepleje.

Indledningsvis vil jeg nævne, at jeg i foråret 2012 havde fornøjelsen af at medundervise i etik på Sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College, Aarhus i samarbejde med Adjunkt, sygeplejerske, cand.mag. Thea Qvist Hjørnholm. Forløbet gav et indblik i, hvordan de sygeplejestuderende arbejder med etiske dilemmaer og problematikker. Dette har været særdeles brugbart i udarbejdelse af specialets praksisorientering, da jeg derved fik indblik, i hvilke ressourcer sygeplejersken har stillet til rådighed rent fagligt. Men i forlængelse af dette gik det op for mig, at de studerende ofte var meget endimensionelle i deres etiske tilgang; de henholdte sig forbløffende meget til begrebet omsorg og Kari Martinsens indlæsning af Knud Ejler Løgstrup i sygeplejen. Til tider forekom det, at de var villige til at tilsidesætte den enkelte patients autonomi for til gengæld at udøve en nærmest anmassende grad af omsorg. Deraf blev jeg gjort opmærksom på de studerendes manglende filosofiske redskaber til at analysere og kategorisere en patient som autonom og selvbestemmende. Specialet har således til formål at opstille sådanne redskaber, således at sygeplejersken, i praksis, vil være i stand til at anvende disse redskaber samt begrunde dem i teoretisk.

Specialets metodiske tilgang er hermeneutisk; gennem en spørgen til forholdet mellem autonomi, etik og sygepleje kan vi komme frem til en grundlæggende forståelse for dette forhold, samt hvilke redskaber vi skal bruge til at løse de eventuelle etiske dilemmaer, som kan opstå, når autonomi, etik og sygepleje betragtes og anskues i samme sfære. Tesen lyder; det enkelte autonome menneske må nødvendigvis være et mål-i-sig-selv, hvis ønsker og præferencer sygeplejersken ubetinget må respektere, så længe at patienten ikke skader andre. Men besidder patienten ikke autonomi, er der grundlag for

professionel indgriben, således at et onde, eller flere, afværges. Tilgangen til at analysere dette forhold tager udgangspunkt i den kantianske tradition, hvori mennesket, fornuftsvæsenet, altid er mål-i-sig-selv. Fremgangsmåden heraf er, i kantiansk optik, en teoretisk analyse af, hvorledes mennesket kan være i stand til at besidde egenskaben autonomi. Denne besiddelse er grundlæggende for vores forståelse af mennesket, som et væsen, hvis autonomi vi aldrig må krænke. Via Kants teoretiske tilgang til autonomi kan vi give et grundlag for det ukrænkelige autonome menneske. Men vi vil se, at jo mere vi praksisgør etik i sygeplejen, jo større bliver risikoen for krænkelse af den enkelte. Derfor har sygeplejersken brug for nogle redskaber til at vurdere, hvorvidt den enkelte patient er autonom, og i stand til at besidde magt over egen tilværelse.

Således er der en klar rød tråd mellem den kantianske pligtetik, som danner det etiske grundlag i sygeplejen til en konsekvensbetragtende etik, hvorved man har redskaber til at hjælpe patienten til at udøve selvbestemmelse. En sidste tradition, som vi må inddrage, funderes på sygeplejerskens idealkarakter og evne til at betragte og forstå patienten på et medmenneskeligt plan, således at sygeplejersken er i stand til at udøve pleje, hvis incitament er omsorg.

Jeg har valgt at bruge Immanuel Kant som grundstenen for min analyse af autonomi, etik og sygepleje, fordi Kants teoretiske argumenter giver mulighed for, at vi ubetinget kan klassificere det autonome menneske som et mål-i-sig-selv. Jeg har valgt at bruge værket *Grundlæggelse af sædernes metafysik [Grundlegung zur Metaphysik der Sitten]* (1785), fordi værkets deontologi, heraf begrebet pligtetik, via filosofisk teori, er grundlaget for moralsk autonomi. Og det er dette autonomibegreb, som er specialets grundlag. Uden dette begreb kan vi ikke tale om personlig autonomi eller et medmenneskeligt ontologisk ansvar. Dette betyder selvfølgelig ikke, at der ikke vil forekomme kritik af Kants moralske autonomi, tværtimod, men vi skal altid have in mente, at moralsk autonomi er førsteinstans for besiddelse af personlig autonomi, det vil sige selvbestemmelse.

Specialet vil metodisk bevæge sig fra teori til praksis. I dette vil vi se, hvorledes sygeplejerskens valg i den specifikke situation har behov for en teoretisk opbakning, således at denne kan begrunde sit valg i et givet etisk dilemma. Sygeplejersken må derved inddrage de tre præsenterede teorier i specialet samt de Sygeplejeetiske Retningslinjer og vurdere, hvilke principper som hun skal gøre brug af for at løse dilemmaet.

Begrebsdefinitioner

Jeg vil i det følgende præsentere en række af de begreber, som anvendes i specialet, som giver læser en forudsætning for at forstå samt bevare overblikket over begreberne, og hvorledes disse anvendes.

Det grundlæggende begreb er *autonomi*. Begrebet betegnes som det snævre autonomibegreb. Begrebet er en sammensætning af de oldgræske ord 'autos' (selv) og 'nomos' (lov); at handle autonomt betyder at være i stand til at udøve selvlovgivning. Specialet anvender begrebet i kantiansk forstand; tanken om moralsk autonomi, hvorved det autonome menneske, fornuftsvæsnet, selv erkender og fastsætter loven for sin handling. Det er en lov, som erkendes via det indre, fornuften, men skal samtidig forstås som objektiv og kategorisk. Dette skyldes, at det er en gyldig almen lov – et kategorisk imperativ. Moralsk autonomi indeholder fordringen om respekten for medmenneskets autonomi, samt sin egen, i kraft af menneskets egenskab til at tænke og handle selv. I praksisanvendeligheden af begrebet opstilles et minimumskriterium for besiddelse af autonomi som egenskab; *intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse*^[1]. Besidder den enkelte disse, betyder det, at vedkommende besidder evnen til at træffe autonome valg. Dette er dog ikke ens betydning med, at der er tale om en autonom person. Heraf forskellen på det autonome valg og den autonome person.

Begrebet personlig autonomi anvendes i specialet som et bredt og komplekst autonomibegreb. Dette begreb videreføres til Laura Ekstrøms kohærente præference system, hvorved den enkelte skal være i stand til at give reflektiv begrundelse for sine valg og værdier. Disse værdier skal stemme overens med vedkommendes integrerede selv; det vil sige autoriserede præferencer, som står i tråd med præferencer og ønsker. Det integrerede selv er således et netværk, som støtter hinanden. Processen heraf er længere sigtet og inkluderer livsanskuelser og værdier. Derved kategoriseres personlig autonomi omhandlende personer og ikke blot valg. I denne proces forefindes det faktum, at den enkelte skal være i stand til at udøve selvbestemmelse og dertilhørende facetter. In mente skal det bemærkes, at autonomi ikke er altoverskyggende i dette begreb, men er én blandt fire facetter, som skal besiddes, for at den berørte kan udøve selvbestemmelse; *selvansvarlighed, selvstyre, selvudvikling* samt *autonomi*.

Begrebet ontologisk omsorgsideal funderes på Løgstrups fænomenologiske tilgang til etikken, og hvorledes den enkelte sygeplejerske er i stand til at praktisere samt realisere sit professionelle og medmenneskelige ansvar. Dette skal forstås som en gylden middelvej, hvorved sygeplejersken

ikke må vige for meget til én af de to modpoler, da dette ville betyde, at sygeplejersken ikke praktiserer sin profession i tilfredsstillende grad.

Når begrebet paternalisme anvendes, tages der udgangspunkt, hvis ikke andet er nævnt, i *svag paternalisme*. Det vil sige afværgelse af et onde.

VÆRK III • AFSNIT 04

Det kantianske autonomibegreb

I værkert *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (1785) bearbejder den tyske filosof Immanuel Kant fundamentet for pligtetikken, hvis fordring bygges på indre pligter. De etiske og moralske valg, mennesket foretager, funderes på noget, som er uafhængig af de empiriske tilbøjeligheder. Vi skal ikke forstå Kants metafysik som af den klassiske ontologiske karakter, men som det øverste princip for al moralitet, hvis beskaffenhed er af absolut karakter; et Kategoriske Imperativ^[2].

De moralske principper, som fornuftsvæsnet foretager, er funderet på den rene tænkning. Dette vil sige, at, i fornuftsvæsnet findes, a priori, et moralsk udspring, altså en kilde, hvorfra moralloven påvirker det fornuftige menneske til at foretage moralske værdifulde valg. Qua egenskaben autonomi er vi i stand til at foretage valg og beslutninger, som bygger på vilje og overvejelse. I adlydelse af moralloven er fornuften en nødvendighed for at træffe valget. Moralen er uafhængig af vore ønsker og behov. Dette betyder, at moralen ikke finder sin værdi i konsekvensen af handlingen, da handlingen kun har værdi i kraft af, at den udføres af pligt. Det vil sige, at i valget må vi skelne mellem viljen og tilbøjelighed; viljen er så-at-sige midt imellem de moralske a priori principper og formalier, som forefindes i henhold til moralloven og de materielle a posterioriske principper, som forefindes i den ydre situations tilbøjeligheder. For at undgå at tilbøjeligheder kan forsvares som moralsk og etisk værdifulde, indfører Kant pligtbegrebet. Det kan godt tænkes, at et valg, eller en handling, træffes enten af fornuften eller tilbøjeligheden, og at disse to poler tilfældigt stemmer overens, men dette er ikke afgørende for, om valget er moralsk værdifuldt eller ej; for ingen tilbøjeligheder eller menneskelig begær efter egeninteresse, og dette er uanset, hvor medmenneskelig denne er, og uanset om konsekvenserne er berigende for det størst mulige antal væsner, så kan dette ikke gøre en handling moralsk værdifuld. Hertil er det fornuftens afgørende rolle at vurdere formen af det princip, som styrer handlingen^[3]. Fornuften handler således efter en almen gyldig handlings lov, som Kant udtrykker på følgende måde; "[jeg skal aldrig handle anderledes, end] at jeg også ville, at min maksime skal blive en almen gyldig lov^[4]." Dette kategoriske imperativ betyder, at den moralske handling, som fornuftsvæsnet foretager, må gælde som universal karakter, og derved kan man ikke handle moralsk værdifuldt, hvis man udelukkende funderer handlingen på egen

interesse og nytte. Imperativet er et moralsk ideal, hvis gyldne regel, og pligt, er respekt for medmennesket og respekt for egen person.

I respekten for sig selv og medmennesket er fornuftsvæsnet i stand til at agere som et frit og autonomt væsen i og med, at det er sit eget lovgivende væsen. Det vil sige, at det besidder egenskaben autonomi. Men hvis fornuftsvæsnet er selvlovgivende, hvorfor skal det så partout følge pligten og loven og ikke bare sine egne tilbøjeligheder, hvis det er det, som lystes, også endda selv om disse lyster og behov er til gavn for dets medmennesker? Problematikken ved dette er ifølge Kant, at der mangler sædeligt indhold i gerningen; *"...for handlingens maksime mangler det sædelige indhold, nemlig at der handles af pligt, og ikke af tilbøjelighed^[5]."* Dette betyder, at tilbøjelige handlinger, på trods af menneskeligenlige indhold, ikke besidder sædelige indhold i kraft af en agtelse for pligten, og derved kan handlingen i henhold til pligtetikken ikke indeholde moralskværdi men blot tilbøjelighed. Til gengæld kan en person, hvis karakter af natur er lunefuld og ustadig, alligevel optræde hæderligt på grund af sin agtelse for pligten moralloven, da vi kan tale om en handling, hvis karakteregenskab betragtes moralsk værdifuld, netop fordi moralen er af højeste værdi i og med, at valget ikke foretages ud fra tilfældige tilbøjeligheder, men gøres ubetinget i henhold til pligten.

Således bliver fornuftsvæsnet en del af Kants ideale *formålenes rige*. Det bliver en del af dette i kraft af, at det er i stand til at agere som et frit autonomt væsen;

"heraf følger det ubestrideligt, at ethvert fornuftsvæsen som mål i sig selv med hensyn til alle love, som det måtte være underlagt, tillige må kunne anses for at være alment lovgivende, idet det netop er dets maksimers egnethed til almengyldig lovgivning, der udmærker det som formål i sig selv; og det følges ligeledes, at dets værdighed (eller prærogativ) frem for alle blotte naturvæsner indebærer, at det altid må vælge sine maksimer ud fra opfattelsen af sig selv og alle andre fornuftsvæsner som lovgivende væsner (der derfor kaldes personer). På denne måde er en verden af fornuftsvæsner (mundus intelligibilis) muligt som et formålenes rige, og det netop i kraft af alle personers egen lovgivning som medlemmer heraf^[6]."

Dette betyder, at pligten i-sig-selv må være et tilstrækkeligt motiv for fornuftsvæsnet, når handlinger og valg skal udføres. Fornuftsvæsnet er ubetinget mål-i-sig-selv. Dette må selvfølgelig også gælde patienten på sygehuset, som skal modtage pleje. Patienten må aldrig bruges som et middel til sygeplejerskens mål, da dette ikke er i tråd med patienten som mål-i-sig-selv. Ej heller kan dette stemme overens med tanken om *formålenes rige*, da sådan en handling vil tilsidesætte den anden persons lovgivning. Lad os i forlængelse af dette se nærmere på forholdet mellem menneskets

værdighed og agtelsen for moralloven. Som nævnt må pligten i-sig-selv være tilstrækkeligt, og den er derfor også en handlingsnødvendighed i agtelsen for loven; agter vi loven, kan vi ikke handle anderledes, da alt andet vil være en handling uden moralsk værdi. Således er det eneste, som loven dikterer, det førnævnte Kategoriske Imperativ, som er den handlingsregel, som er gældende for alle fornuftsvæsner.

At have agtelse for moralloven er at have pligt for det Kategoriske Imperativ; følger vi udsagnet, kan vi rationelt erkende pligten i en given situation; grundlæggende må fornuften fortælle os, hvis den givne handling ikke kan gælde som en almen lov, må vi forkaste den. Kan handlingen til gengæld gælde som sådanne, må denne nødvendigvis være af værdifuld moralsk karakter og derved gyldig almen lov, Deraf må vi følge denne handling, da den er fordret gennem agtelse for moralloven. At handle efter moralloven er derved grundlaget for at være sin egen lovgiver; dette må grunde i et objektivt princip, som fornuften uafhængigt af tilbøjelighed erkender; *"Handl som om maksimen for din handling gennem din villen skulle blive en almengyldig naturlov^[7]."* Denne objektivitet er tvingende for viljen; det vil sige, at fornuften tvinger viljen til det objektive, hvilket er den iboende grund til, at det eksempelvis aldrig kan være tilladt at begå sig en handling, som bygger på løgn samtidig med betyder dette udsagn, at moralloven er udtryk for fornuftsvæsnets værdighed og værdi samt et grundlag for nødvendigheden at opretholde dette, da væsnet altid er formål i-sig-selv og ikke blot et middel. Deraf kan vi bevæge os mod endnu en formulering af imperativet; *"Handl således, at du altid tillige behandler menneskeheden, såvel i din egen person som i enhver anden person, som mål, aldrig blot som middel^[8]."* Princippet er et ubetinget kategorisk imperativ. I dette ytrer moralloven, at ethvert fornuftsvæsen er værdifuldt i-sig-selv, uafhængig af alt andet, inklusiv konsekvenserne. I sygeplejen betyder dette, at pligten fordrer, at alle, uanset køn, alder, højde, vægt osv., skal modtage lige behandling. At handle anderledes vil i-sig-selv ikke være nogen handling af moralskværdi, og deraf vil en handling af eksempelvis egeninteresse aldrig opfylde pligtens fordring da dette ikke vil være i henhold til pligtens imperativ.

Kants pligtetik er grundlaget for den moralske autonomi, hvori fornuftsvæsnet er i stand til at tilsidesætte egne subjektive interesser for til gengæld at være i stand til at anerkende dets medmennesker som selvlovgivende autonome væsner, som besidder værdi-i-sig-selv. Netop det, at patienten er et mål-i-sig-selv, er i sygeplejen et vigtigt fundament; det forudsætter, at både sygeplejerske og patient er i stand til at stå til ansvar for egne handlinger og valg; i kraft af frihedsbegrebet kan vi via pligten erkende den moralskværdifulde handling frem for en handling uden værdi. Dette betyder således, at både sygeplejerske og patient nødvendigvis må respektere

den anden som et mål-i-sig-selv og aldrig blot som middel. Sygeplejersken kan ikke bruge patienten i egeninteresse og vice versa, da sådan handling vil være uden moralsk værdi, da den anden ikke respekteres som et mål, men blot være blevet reduceret til et redskab, hvori den anden forsøger at opnå den egeninteresse, som forsøges opnået. Sådanne tilfælde lever unægtelig ikke op til imperativet, som fordrer den enkelte som mål-i-sig-selv samtidig med, at pligten ikke er motivet for sådanne handling; deraf bliver værdikarakteren forkastet, og maksimen kan nødvendigvis ikke gælde som en gyldig almen lov. Derved må sygeplejersken af nødvendighed rette sig efter den a priori morallov, som er uafhængig af al erfaring; moralloven er det grundlag, hvorpå sygeplejersken kan finde et absolut vejledningsgrundlag i sin handling. Dette betyder, at sygeplejersken, af pligt, nødvendigvis må tilsidesætte egne subjektive interesser, som drives af naturlige tilbøjeligheder. I situationen er vedkommende i stand til, via viljen, at formulere et klart defineret valg, deraf handling. Moralloven er den uerfarende genstand, som gør det muligt, for at sygeplejersken kan frigøre sig fra sine naturlige tilbøjeligheder, grundet agtelse for moralloven. Og følger sygeplejersken loven, så er handlingen af princip én værdifuld moralsk handling. Således er fornuftsvæsnet af intrinsisk værdi, og da loven er almen gyldig, gælder dette princip også patienten; sygeplejersken kan derfor aldrig, hvis patienten er autonom, udføre og underkaste patienten paternalisme og derved sikre pligtetikken, at patienten bevarer sin autonomi, samt værdighed.

Grundlaget for Kant er et rationalistisk og humanistisk syn, som påbyder, at man altid skal respektere den anden som et mål-i-sig-selv, og derved skal man respektere dertilhørende autonomi. Derved er det i sygeplejen altafgørende, at viljen er selvlovgivende og autonom, uafhængig af genstande – er dette tilfældet så må udfaldet ubestrideligt være det Kategoriske Imperativ. Hvis sygeplejersken eksempelvis lyver over for patienten, så er dette i modstrid med moralloven, og derved er den løgnfulde ytring ikke af moralsk værdi. Således har sygeplejersken ikke anvendt sin nødvendige fornuft, og derved kan hun ikke erkende imperativet.

Derved kan vi konkludere, at moralloven er en fordring om at sikre fornuftsvæsnets værdi. Samtidig er det kantianske fornuftsvæsen af intrinsisk værdi, da det er i stand til at agere som selvlovgivende karakter, hvis valg er af moralsk værdighed, da disse funderes på agtelse for moralloven. Det er uafhængigt af tilbøjeligheder og konsekvenser, dvs. det altid er mål-i-sig-selv aldrig et middel. Netop dette er for etik i sygeplejen et vigtigt fundament; man kan ikke påføre det autonome fornuftsvæsen paternalistisk tvang, da dette ville være en krænkelse af dets værdighed og implicitte autonomi. I behandlings- og plejehenseende må sygeplejersken altid anerkende patienten som en del af det kantianske *formålenes rige*, hvori både patient og

sygeplejerske er forenet ved fælleslov, hvor begge parter altid er mål-i-sig-selv. I praksis er dette en nødvendighed, således at alle mennesker behandles lige.

Spørgsmålet er så, hvornår et fornuftsvæsen i praksis er autonomt? Kant giver et teoretisk grundlag for, hvornår vi er selvlovgivende væsner, hvis gerninger og handlinger er af moralsk værdi, og hvornår de ikke er. Men når man som sygeplejerske står i en situation, hvori man skal vurdere, hvorvidt patienten er autonom eller ej, så lader den rene kantianske tænkning ikke være en umiddelbar anvendt indikator for, hvornår patienten kan vurderes som autonom eller ej. Dette er teorien ganske enkelt for kompliceret til. Vi må derfor bevæge os fra den teoretiske Kant til én mere specifik anvendt kantiansk etik, som kan give os svaret på, hvornår en patient kan betragtes som autonom, og hvornår patienten ikke kan.

VÆRK III • AFSNIT 05

Kant i praksis – om anvendelse af det kantianske autonomibegreb

At respektere en patients autonomi er at give plads til patienten som et selvlovgivende subjekt. Giver sygeplejersken ikke plads til, at patienten kan foretage valg grundet i egne værdier og livsanskuelser, krænkes patienten, da denne, som alle andre fornuftsvæsner, er uerstattelig. Men det er ikke altid tilfældet, at patienten rent faktisk lever op til Kants ideal om autonomi. Spørgsmålet er således, hvornår og hvordan vi kan vurdere, hvorvidt en patient foretager autonome valg eller ej? At foretage sådanne vurderinger er vigtigt for sygeplejersken, hvis hun skal leve op til fordringen om at behandle sit medmenneske med respekt og værdighed; foretager sygeplejersken et forkert skøn, det vil sige, vurderer hun, at patienten ikke handler autonomt uvidende om, at vedkommende rent faktisk handler således, så krænker sygeplejersken det uerstattelige mål-i-sig-selv ved at underlægge det tvang, og derved lider patientens autonomi alvorlig krænkelser.

Det er sygeplejerskens pligt, *i sit arbejde at anvende fagligt skøn, kritisk stillingtagen mod og omtanke*^[9] samt *arbejde for at patienten bevarer sin værdighed og integritet*^[10]. Således skal sygeplejersken handle i henhold til professionen og til patienten. Derved har sygeplejersken et ansvar for at udvise professionalisme i sine skøn samt sørge for, at patienten bevarer sin værdighed – også på trods af at der er tale om en patient, som ikke længere besidder, eller måske aldrig har haft, egenskaben autonomi. Jeg vil i det følgende give et svar på, hvordan sygeplejersken kan anvende det kantianske autonomibegreb i praksis, således at hun er i stand til at vurdere, hvornår en patient handler autonomt, og hvornår vedkommende ikke gør, og derved skal autonomien ikke respekteres, da egenskaben ikke er til stede.

En sygeplejerske, som arbejder med sindslidende personer, er ofte udsat for, at patienterne udviser anormal adfærd; i behandlings- og plejeprocessen er det sygeplejerens opgave at pleje og forebygge de lidelser, som patienten er udsat for. Da sådanne patienter til tider kan forekomme at være personer, som foretager autonome valg, kan det være svært at skelne, hvornår et valg rent faktisk er autonomt, og hvornår det ikke er. En psykisk syg kan virke rationel i sine ytringer; vedkommende kan udtrykke præferencer, værdier, livsanskuelser osv. Det vil være forkert at kategorisere den sindslidendes valg som altid ikke-autonomt; ytrer patienten, at han gerne vil have et bestemt slags aftenmåltid frem for et andet, og grundlaget dertil er rationelt, så kan sygeplejersken ikke blankt afvise dette ønske, da det umiddelbart lyder som et begrundet ønske. Sådant patient, på trods af at vedkommende er indlagt grundet psykisk ustabilitet, kan i givende situationer foretage autonome valg – derved ikke sagt at patienten er en autonom person. Det er i situationer som disse, at det er vanskeligt for sygeplejersken at vurdere, hvornår patienten ytrer et autonomt valg, og hvornår denne ikke gør. Dertil må sygeplejersken give et professionelt skøn samtidig med, at patienten bliver behandlet med respekt. Således må sygeplejersken vurdere, hvorvidt patientens valg er foretaget på autonomiens minimumskriterium; *intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse*^[11]. Disse kriterier er det fundament, som Tom L. Beauchamp angiver som grundlaget for det autonome valg. Når en sygeplejerske vurderer, om patientens valg er autonomt eller ej, kan minimumskriteriet anvendes som en kalkule, hvori sygeplejersken kan træffe et professionelt skøn; patientens valg skal respekteres, hvis og kun hvis, at der er tale om et autonomt valg – er tilfældet, at valget ikke lever op til minimumskriteriet, så skal patientens autonomi ikke respekteres, men han skal stadig behandles med respekt og værdighed. Der er fra sygeplejerskens side således tale om et kompetent skøn af, hvorvidt patienten er i stand til at udøve autonomi; således må sygeplejersken vurdere, hvorvidt patientens valg er autonomt eller ej. Således bliver minimumskriterierne *intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse* grundlaget for, hvornår patienten ikke kan være i stand til at indgå eksempelvis et informeret samtykke. Er patienten ikke i stand til at handle autonomt, vil det indgå i et til flere af følgende udsagn:

- *Inability to evidence a preference or choice*
- *Inability to understand one's situation or relevant similar situations*
- *Inability to understand disclosed information*
- *Inability to give a reason*
- *Inability to give a rational reason (although some supporting reasons may be given)*
- *Inability to give risk/benefit related reasons (although some rational supporting reasons may be given)*
- *Inability to reach a reasonable decision (as judged, e.g., by a reasonable person standard*^[12]

Den ikke-autonome patient kan klassificeres under et eller flere af ovenstående punkter; en patient som besidder evne til at formidle præferencer og valg samt sågar at være i stand til at formulere relevant information, er ikke nødvendigvis nok til, at vi kan kategorisere vedkommende som autonom, for er den berørte ikke i stand til at opfylde minimumskriteriet, så kan vi ikke betragte vedkommende som autonom. Dette skyldes, at hver enkelt af de tre punkter; *intention*, *forståelse* og *fri af kontrollerende indflydelse*, alle er nødvendige, men ikke tilstrækkelige hver især. En patient kan ikke foretage et autonomt valg, hvis denne ikke opfylder alle minimumskriterier for autonomi. Det er åbenlyst, at hvis patienten besidder *forståelse* og *intention*, men ikke kan se sig fri af *kontrollerende indflydelse*, indre som ydre, så kan vedkommendes valg ikke betragtes som autonomt; tvinges patienten til at gøre handling-X, så er det klart, at denne handling ikke er autonom, da patienten ikke er fri til at foretage sit eget ønskede valg – dette gælder også i tilfælde af interne omstændigheder, hvor vedkommende ikke kan se sig fri af kontrollerende indflydelse. Patienten skal give et rationelt grundlag for sit valg. Er patienten ikke i stand til at gøre sådanne, så kan valget ikke klassificeres som autonomt. De syv punkter ovenfor er således et udtryk for, og en indikator af, hvorledes patienten er i stand til at leve op til autonomiens minimumskriterium. Punkterne er derved en måde, hvorpå sygeplejersken kan vurdere patientens evner og kompetencer, hvis grundlag er autonomiens minimumskriterier.

Lad os belyse minimumskriterierne for autonomi lidt nærmere. Begrebet *forståelse* er ikke et ubetinget begrebet; begrebet kan gradbøjes, modsat de to øvrige kriterier; "*An account of understanding that required an extremely high level of understanding would be oppressive if made a condition of autonomy*"^[3]. Vi kan ikke forvente, at patienten kan besidde en fuld ud forståelse for situationen, der til er begrebet ganske enkelt for bredt. Dette betyder dog ikke, at patienten, hvis vedkommende vurderes til at besidde egenskaben autonomi, kan se sig fri for ikke at skulle redegøre for en basal forståelse. Hvis patienten vælger X frem for Y, må dette nødvendigvis funderes på en basal forståelse af valget. Patienten må således vide noget om, hvad valget af X betyder frem for valget af Y, men at patienten ikke har den fulde forståelse er ikke nok i-sig-selv til at kategorisere vedkommende som ikke-autonom. At patienten ikke kan redegøre fuldt ud for sit valg af X er ganske enkelt forståeligt; hvis patienten bliver spurgt; *hvorfor valgte du at uddanne dig til skolelærer?* så virker det ganske enkelt absurd, at patienten fyldestgørende skal redegøre for alle facetter af sit valg. Til gengæld kan et valg uden basal forståelse ikke klassificeres som af autonomkarakter; sådanne valg vil ikke leve op til autonomiens krav og patienten vil således i sin forklaring af valget ikke være i stand til at redegøre for valget og derved kan sygeplejersken vurdere, at patientens valg ikke er autonomt.

Den intentionelle handling må ligesom forståelse være hensigtsmæssig begrundet, men må samtidig være af fuld intention og kan derved ikke gradbøjes; *"For an act to be intentional, it must correspond to the actor's conception of the act in question"*^[4]. Hvis sygeplejersken skal vurdere, om patientens valg er autonomt må, der være kontinuerlig sammenhæng mellem patientens eventuelle formodninger, tanker og ønsker i patientens intention. Dette betyder, at begrebet ikke kan gradbøjes, og der vil altid være en sammenhæng mellem handlingens autonomi og intentionen. Hvis X har intention om at gå til højre men faktisk går til venstre, så er dette grundlag nok til at vurdere, at patientens ikke lever op til autonomiens krav. Ydermere skal patientens ønske om at gå til højre frem for venstre bakkes op af forståelsen for, hvad det vil sige at gå til højre. At have intention om at gå til højre men går til venstre er et tegn på, at patienten hverken har den basale grundforståelse for at vælge højre frem for venstre og samtidig ikke er i stand til at patientens præferencer stemmer overens med intentionen. Er dette tilfældet er patienten ikke autonom i henhold til Beauchamps minimumskriterium for autonomi.

Det sidste forhold, som må tages i betragtning, er ikke så abstrakt som de to øvrige. Skal et autonomt valg foretages, må det funderes på, at patienten kan se sig fri af kontrollerende indflydelse; dette gælder både interne og eksterne konflikter. En patient som lider af tvangstanker er genstand for ufrivilligt at lade sig distrahere af uønskede tanker, som er i stand til at kontrollere vedkommendes liv i så en høj grad, at det har indflydelse på patientens livskvalitet. Når disse uønskede tanker finder sted, kan patienten ikke se sig fri fra at vedkommendes liv er kontrolleret af interne omstændigheder, som gør, at patienten ikke er i stand til at styre sit liv. Er dette tilfældet, kan vi ikke kategorisere patienten som autonom. Det vil sige, at de valg som patienten foretager, mens tvangstankerne finder sted, ikke er af autonomkarakter, og derved kan vi ikke respektere patientens autonomi i situationen, da der ikke er nogen autonomi at respektere. Modsat indre tvang og indflydelse er ydre omstændigheder mere tilgængelige at vurdere; *"Coercion, as we define it, occurs when one person intentionally uses a credible severe threat of harm or force to control another"*^[5]. Er denne form for tvang tilfældet, er det åbenlyst, at personen, som underlægger den anden tvang, ikke behandler personen som et fornuftsvæsen og derved som mål-i-sig-selv i kantiansk forstand, men til gengæld reducerer den anden til et middel til egne formål.

Intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse er autonomiens grundvilkår. I daglig praksis kan disse tre begreber og kriterier bruges af sygeplejersken til at vurdere, hvorvidt patientens valg eller ønske er autonomt. Disse principper følger Kants frihed og autonomibegreb; er patienten, det vil sige fornuftsvæsenet, autonomt, så er vedkommende i sin ret til at agere som

selvlovgivende væsen, og sygeplejersken må respektere patientens autonomi og værdighed, ubetinget. Dette betyder, at sygeplejersken må, uanset egen overbevisning, respektere patientens autonome valg, da patienten, i kraft af dets fornuftsmæssighed, altid er et mål-i-sig-selv. Lad os belyse dette forhold nærmere ved en case omhandlende en lungecancerpatient som vi kan kategorisere som borderline-autonom^[6];

VÆRK III • AFSNIT 06

Case

”Patienten fik for 6 måneder siden konstateret lungecancer. Hun kom i øjeblikkelig behandling med kemoterapi, men i forbindelse med kontrol CT efter behandlingen, blev det konstateret, at der nu var metastaser til binyrerne og til skelettet. Grundet problemer med smertebehandling fik patienten bevilliget en korttidsplads i hendes hjem-kommune.

Under flere samtaler på hospitalet har patienten og hendes datter nægtet at høre på, hvor syg hun er og at der beklageligvis ikke findes en kurativ behandling. Patienten har endvidere ikke villet høre tale om, hun skal terminalerklæres. Hun er dog blevet terminalerklæret, men vil ikke acceptere dette.

Patientens tilstand forværres dag for dag, og hun har ulidelige smerter. Hun bliver tilset af det palliative team, men griner af dem og de behandlingstilbud, de har i forhold til en sufficient smertebehandling, og ofte ender samtalerne med, at hun smider dem ud af sin stue på korttidspladsen. Hendes daglige kontakt består af kontakt til to sygeplejersker, som forsøger at hjælpe hende så godt som muligt – hun ønsker ikke hjælp fra andre. De to sygeplejersker har passet mange døende og er således klædt godt på fagligt^[7].”

Den pligtetiske sygeplejerske står nu i følgende dilemma; patientens tilstand forværres fra dag til dag. Ydermere vil patienten ikke acceptere det faktum, at vedkommende er døende. I dette forefindes to dilemmaer; 1) patientens smerte vil lindres, hvis vedkommende tager imod tilbuddet om den rette smertebehandling, således at hun ikke vil lide unødigt og 2) Patienten skal behandles med værdighed og respekt, hvilket ikke er muligt, hvis vedkommendes autonomi krænktes. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorvidt patienten besidder autonomi, eller om sygeplejersken kan vurdere, at patienten ikke gør og derved kan retfærdiggøre et paternalistisk indgreb. I henhold til den Professionsetiske Beslutningsmodel indebærer pligtetikken at sygeplejersken skal tage forbehold til følgende principper;

- Respektere autonomi
- Behandle retfærdigt

- *Undgå skade*^[18]

At respektere patientens autonomi betyder at respektere patientens individualitet og værdighed. Dette er grundlæggende, da den autonome patient altid er et mål-i-sig-selv. Netop dette, at patienten er mål-i-sig-selv, betyder også, at patienten skal behandles retfærdigt; det giver ikke nogen mening at forskelsbehandle patienter, da sådanne handlinger vil modsætte sig det Kategoriske Imperativ. Patienten vil være et middel og ikke et mål, og derved vil sådanne handling være uden moralsk værdi. At undgå skade vil sige at forhindre, at patienten lider unødigt. Det lader sig være fysisk og psykisk smerte samt ikke at forvolde skade på patientens værdighed. I henhold til de Sygeplejeetiske Retningslinjer 2010 skal sygeplejersken *"medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information, der gives, skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt patientens livssituation"*^[19]. Lad os nu analysere den viden vi har om patienten nærmere og hvorledes sygeplejersken skal forholde sig til denne viden. De to grundlægende informationer vi har er; at patienten samt hendes datter ikke vil anerkende det faktum, at patienten er dødelig syg, og at der ikke findes nogen kurativ behandling^[20]. Dertil må det noteres, at patientens tilstand forværres fra dag til dag. Det som vi må spørge os selv om, i denne komplekse situation er, hvorvidt patienten har levet op til det minimumskriterium for autonomi, som påpeges af Beauchamp. Vi kan således spørge os selv følgende tre spørgsmål; Har patienten basal forståelse for sin situation? Hvad er patientens intention i valget om ikke at ville terminalerklæres samt kan patienten se sig fri fra kontrollerende indflydelse? Min påstand skal lyde, at der er indicier, som peger på, at patienten ikke er klar over, eller rent psykologisk ikke vil indse, situationens definitive omstændigheder. Vi kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor patienten vælger ikke at ville acceptere sin terminalerklæring samt ikke at acceptere, samt anerkende, det palliative team som står rådighed. Det er klart, at forståelse for situationen kan gradbøjes; vi kan ikke forvente, at patienten besidder ligeså meget viden om sin lungecancer som lægen og sygeplejersken. Forståelse for situationen er gradbøjelig, men da patienten, så vidt vides, ikke er i stand til at forklare, hvorfor hun ikke ønsker den tilbudte behandling, men blot griner åbenlyst af dem og ikke er i stand til at give en rationel begrundelse for sit valg, tyder på, at patienten ikke besidder en basal og nødvendig forståelse af situationen. Patientens intention er klar og velformuleret; hun ønsker ikke at modtage behandling. Men, hvis patienten ikke besidder basal forståelse for situationen, så virker det til, at intentionen ikke stemmer overens med det kontinuerlige forhold, som skal være tilstede i patientens formodninger, tanker og ønsker; for hvis patienten ikke har forståelse for situationen, hvordan kan vi så overhovedet tro, at patientens intention beror på et rationelt grundlag? Dette lader ikke til at være tilfældet. Endelig må vi spørge om, hvorvidt patienten kan se sig fri af kontrollerende indflydelse? I dette vil jeg

mene, at de psykologiske forhold er vigtige. I dette tilfælde lader det til, at patienten befinder sig i en virkelighed, som egentlig ikke er til. Der lader til at være nogle indre faktorer, som forhindrer patienten i at indse sin situation, måske frygt for døden osv.

Således kan vi ved brug af Beauchamps minimumskriterium for autonomi vurdere, at denne patient ikke besidder egenskaben, og derved er der ingen autonomi at respektere. Spørgsmålet er, hvad vi i pligtetisk henseende bør gøre ved sådanne patienter? Vi har konkluderet, at der er grund til at skønne, at patienten ikke handler rationelt og autonomt; der kan stilles tvivl ved, hvorvidt hun er i stand til selv at træffe et valg, som har afgørende betydning for hendes behandling og pleje. Pligtetikken fordrer, at vi må respektere et autonomt valg, men da der i dette tilfælde ikke er tale om autonomi, må vi i stedet vurdere, at patienten skal undgå yderlig skade. I dette tilfælde er der tale om at undgå yderlig indirekte skade, hvilket vil forekomme, hvis ikke et palliative team inddrages til at yde smertelindrende behandling samt hindre, at patientens værdighed krænkes. Dog skal patienten behandles retfærdigt; der må ikke forskelsbehandles. Det vil sige, at patienten ikke må tilsidesættes eller rangeres lavere end andre patienter, også selv om patienterne er i stand til at foretage et autonomt valg modsat lungecancerpatienten.

Vi kan retfærdiggøre et paternalistisk indgreb, da vi har grundlag for at skønne, at patienten ikke er i stand til at foretage autonome valg. Dog må vi skelne mellem indgreb, hvori vi forhindrer, at patienten forvoldes yderlig skade og indgreb, hvori vi forudsætter en bedrevidenhed. Spørgsmålet er, hvorledes vi skal forholde os til brugen af paternalistisk indgriben i henhold til pligtetikken og Kants Kategoriske Imperativ? Vi har retfærdiggjort muligheden for indgriben, da der ikke er nogen autonomi at respektere, men dette betyder ikke, at vi kan bruge patienten til de formål, vi nu engang ønsker. Når patienten påtvinges palliative behandling, er spørgsmålet, hvorvidt påtvinges patienten denne brug, fordi institutionen har behov for at frigive nogle midler for at modtage yderlig økonomisk støtte, så er sindelaget forkert; derved bliver handlingen i kantiansk forstand af manglende moralsk værdi, fordi patienten bruges som middel, ikke mål. Men patienten må nødvendigvis påtvinges paternalisme, når et onde skal forhindres, hvis vedkommende ikke længere selv er i stand til at foretage nødvendige autonome valg, som kan forhindre yderlig lidelse – dette er ikke at påtvinge patienten et gode, men at forhindre et onde. Derved kan et paternalistisk indgreb retfærdiggøres.

Vi må dog påpege, at en case som denne med lungecancerpatienten kan være tvetydig; man kan argumentere for, at patienten rent faktisk er autonom, og derved kan man, ifølge pligtetikken, under ingen omstændigheder krænke hendes autonomi, da patienten er et mål-i-sig-selv og ikke et middel for de professionelles ønsker og behov. Dog kan vi grundlæggende vurdere, at det

kantianske autonomibegreb er en egenskab, som man enten besidder eller ikke gør; man skal redegøre for sine valg, eksemplificeret ved brug af Beauchamp, for at besidde autonomi. I den pligtetiske analyse af lungecancerpatienten må vi fokusere på, hvorvidt patienten er i stand til at have forståelse og intention og se sig fri af kontrollerende indflydelse, når vedkommende træffer sit valg. Vi må således vurdere, hvorvidt patienten er i stand til at give udtryk for egne præferencer, at forstå den information som læger og sygeplejersker har formidlet, og hvorvidt patienten i forlængelse af dette er i stand til at forstå sin egen relevante situation. Endelig skal patienten være i stand til at forstå, hvad konsekvenserne af en eventuel fravælgelse af behandling har af betydning for hendes relevante sygdomsforløb og situation. Er patienten i stand til dette, så er vedkommende i stand til at leve op til disse kriterier og derved i stand til at besidde moralsk autonomi; heri er der ikke tale om tilfældige valg vurderet ud fra tilbøjeligheder men valg, som er funderet i en agtelse for moralloven og pligten; derved bliver valget en moralsk handling, som finder værdi i kraft af, at det må gælde som en gyldig almen lov – som et kategorisk imperativ.

VÆRK III • AFSNIT 07

Fra moralsk til personlig autonomi

Det etiske indhold i Kants filosofi er agtelsen for moralloven og menneskets ubetingede værdighed. Moralloven er kendetegnet ved sin indre værdi, hvori fornuften, via autonomi, indser, at pligten i sig selv må være tilstrækkelig motiv for at agte og adlyde moralloven. Moralloven påbyder, at vores handlinger skal gøre sig gældende som gyldig almen lov. Ved at følge denne lov kan vi rationelt tænke os til, hvad vores pligt er. I dette skal den enkelte være i stand til at reflektere og benytte sig af sin egen forstand. Men det er åbenlyst, at dette i sig selv ikke er nok. Ganske vidst sikrer det kantianske autonomibegreb fornuftsvæsnet en række rettigheder i kraft af det Kategoriske Imperativ, men det siger ikke noget konkret om det enkelte menneske; hvem er personen bag? Hvilke livsanskuelser og værdier har den berørte? og så videre. Vi har derfor behov for et autonomibegreb, som siger noget om det enkelte menneske. Dette er nødvendigt i sygeplejen, da dette giver et grundlag for at yde en patient-tilpasset pleje og behandling af hver enkelt patient. Skal sygeplejersken være i stand til at afgøre, om patienten i helhed er autonom, så kræver det mere end blot at analysere de valg, som vedkommende foretager. Det kantianske autonomibegreb siger ikke, hvorledes sygeplejersken skal forholde sig til patientens personlige autonomi; i mødet med den anden kan sygeplejersken, ved pligtetikken, ikke finde noget svar, andet end hun nødvendigvis må respektere patientens autonomi og værdighed. Men patienten er et menneske, som også har en baggrund, livserfaring og værdier, som ikke kan medbetragtes i kantiansk perspektiv.

Der mangler et grundlag, hvori sygeplejersken kan tage udgangspunkt i pleje og behandling af patienten. Hvis patienten, i kantiansk optik, er autonom, og vedkommende ønsker X frem for Y, så kan dette ønske ikke tilsidesættes, da dette vil være at krænke patienten. Ganske vidst kan sygeplejersken antage, at dette ønske er et autonomt valg, men hun kan ikke vide, hvorvidt patientens ønske stemmer overens med valg af værdier og livsanskuelser. Er patienten et Jehovas vidne, som i behandlingen og plejen ytrer, at vedkommende gerne vil modtage blod, så kan dette valg være autonomt, men der forekommer en kontradiktion mellem patientens autonome valg og patienten som autonom person i sådanne tilfælde. Hertil må sygeplejersken stille sig kritisk, og hun har derfor behov for et bredere redskab end dét som tilbydes ved Beauchamps minimumskriterium for autonomi. At besidde personlig autonomi betyder at være i stand til at vælge værdier og større valg, som har indflydelse på det liv, man nu engang vælger at leve. Der skal være en rationel forbindelse mellem disse, hvilket åbenlyst ikke kan være tilfældet med Jehovas vidne patienten, da der er modstridende forhold mellem vedkommendes autonome valg og personen som et autonomt individ med livsindhold og anskuelser, som vedkommende selv har valgt.

Ovenstående eksempel er måske af sjælden karakter, men det viser, hvorfor sygeplejersken skal have et redskab til at forbinde det autonome valg med den autonome person. Sygeplejersken har, i pligtetikken henseende, pligt til at respektere patientens autonomi og behandle vedkommende retfærdigt. Dette fordres via moralsk autonomi, som opstiller, via Kants autonomibegreb, disse principper, og sygeplejersken har pligt til at leve op til disse principper. Men på den anden side skal sygeplejersken også bidrage til, at patienten kan besidde evnen til selvbestemmelse. Og det er netop ved denne overgang, at vi har brug for endnu en teori, som kan gøre, at vi kan gå fra moralsk autonomi til personlig autonomi, hvori sygeplejersken skal vurdere patientens valg af værdier og inddrage disse i plejen, således at patienten kan få de bedst mulige forudsætninger i sit sygdomsforløb. For at være i stand til dette skal sygeplejersken have et indblik i patientens kohærente præferencesystem, hvor hun kan kategorisere patienten som autonom og ikke kun valget.

Filosoffen Laura Waddell Ekstrom kan give sygeplejersken redskabet til dette. Jeg har valgt at kategorisere Ekstroms position som konsekvensbetragende. Dette gør jeg, da hendes kohærensteori bruges til at klargøre, hvorledes sygeplejersken kan vurdere patientens evne til selvbestemmelse og i visse tilfælde må vurdere, hvilken behandling og pleje, der vil være den bedste med henblik på at fremme patientens selvbestemmelse^[21].

Ved brug af begrebet tilføjer Ekstrom den filosofiske autonomidiskussion et nyt begreb; præference. Ved brug af præferencer kan den enkelte, det vil

sige patienten, udtrykke en kritisk vurdering af, hvad vedkommendes definition af det gode er. Dette betyder en kritisk stillingstagen i henhold til de valg og værdier, patienten har valgt i sit liv. Dette kan være et ønske eller ønsket om at have et ønske – men det som kendetegner præferencebegrebet er ikke, hvad det som sådan er rettet imod men den proces, hvorigennem præferencen er blevet til. Ved kritisk stillingstagen til valg af værdier vælger det enkelte autonome menneske selv sine værdier – deraf personlig autonomi. At vælge en værdi eller præference kan ikke være autonom, hvis dette valg ikke har været under kritisk evaluering af den berørte person selv. Det afgørende ved dette er, at det er personen selv, som har valgt at vælge denne præference. Den moralske autonomi kan ikke vælge X frem for Y, da valget allerede er forhåndsbesluttet. Men ved brug af personlig autonomi kan man vælge X, da dette vil passe ind i egen definition af det gode og personens helhedsbillede således, at dette stemmer overens med vedkommendes personlige autonomi.

Det som kendetegner dette valg af præference er, at der er tale om sammenhæng mellem det ønskede valg og den person, som valget begrundes i. Valget grunder derved i en langt bredere autonomi forståelse, da der er tale om et personligt karaktersystem, hvori sygeplejersken skal være i stand til at vurdere, hvorvidt patientens valg stemmer overens med patientens personlige autonomi og kohærente præference system. I introduktionen til essay samlingen *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy* beskriver James Stacey Taylor brugbarheden af Ekstroms teori på følgende måde;

“...by bashing her conherentist analysis of autonomy on the insight that if a person is to be autonomous with respect to a preference, that preference must originate from that person’s self in a particular, objective way^[22].”

Det er på denne måde, vi skal forstå Ekstrom og forholdet mellem personlig autonomi og selvbestemmelse, når vi i det følgende afsnit belyser forholdet herimellem; sygeplejersken skal være i stand til at vurdere patientens autonomi i henhold til et længere sigtede perspektiv end blot det autonome valg. For at yde bedst mulig pleje og behandling skal hun have indsigt i, hvem den enkelte patient er for at være i stand til eventuelt at bidrage til at fremme denne patients evne til selvbestemmelse. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis vi blot bruger Beauchamps minimumskriterium, da det at udøve autonome valg i sig selv er nok til at blive kategoriseret som autonom i praksishenseende. I det følgende afsnit vil vi se, hvorledes sygeplejerskens indsigt i patientens personlige autonomi gør, hvis denne er til stede, at hun har et redskab til at bidrage til at patientens selvbestemmelse fremmes.

Selvbestemmelse og personlig autonomi – et konsekvensbetragtende perspektiv

I henhold til Kant er en person autonom, hvis vedkommende kan pålægge sig selv at leve efter moralloven. Det vil sige at være i stand til at træffe valg, hvis grundlag udelukkende er funderet på rationalitet uden indflydelse af tilbøjeligheder. Men spørgsmålet er, om dette kantianske autonomibegreb ikke er for begrænset? Og dertil må vi spørge, om ikke Kant, både i teori og i praksis, som anvendt ved Beauchamp, forudsætter, at vi vælger og træffer vores moralske og autonome valg på baggrund af en allerede på forhånd givet faktor, som gør, at vi ikke medtænker de eksterne omstændigheder, som spiller ind, når vi skal foretage et autonomt valg? Den kantianske teori har allerede forudbestemt, hvad der er rigtigt og forkert uden at tage hensyn til de eksterne begrænsninger, som vi, som sociale væsner, altid er underlagt. Det vil sige, at den moralske autonomi, som er udgangspunktet for Kants moralteori, ikke inddrager hverken sociale, psykologiske eller sågar biologiske faktorer, som nødvendigvis må inddrages, hvis vi skal vurdere, om en person er autonom eller ej. Det kantianske autonomibegreb kan forekomme for begrænset, når vi skal tale om det autonome menneske. Hertil er det vigtigt at have in mente, at vi må skelne mellem det autonome valg og den autonome person. Beauchamp belyste, hvorledes vi kan kategorisere en persons valg som autonomt, hvis vedkommende levede op til autonomiens minimumskriterium. Men derved kan vi ikke udelukkende bruge Beauchamps kantianisme til at vurdere, om en person er autonom. For hvis vi skal vurdere, om personen, ikke valget, er autonomt, må vi have en bredere forståelse af begrebet autonomi. Således må vi bevæge os væk fra tanken om mennesket som et isoleret subjekt for derimod at tænke det ind i et større sammenhæng, hvori det ikke ser sig begrænset til udelukkende at handle efter forudsatte moralske forpligtelser. Vi må skelne mellem det kantianske autonomibegreb og et bredere selvbestemmelsesbegreb, hvori der gives plads til det enkelte menneskes livssyn og livsforståelse. Med dette in mente vil vi se, at autonomi ikke er et begreb, som kan stå selvstændigt; det bliver reduceret til én blandt flere facetter af et bredt selvbestemmelsesbegreb.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer henviser til at; *”Sygeplejersken skal respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge selvbestemmelsesretten^[23].”* samt at *”Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet^[24].”* men før sygeplejersken kan medvirke til, at disse kriterier bliver opfyldt, kræver det, at patienten er i stand til at besidde en acceptabel og fyldestgørende kontrol over sit eget liv. Det vil sige at være i stand til leve og agere i sit liv på sådanne måde, at man har forståelse for de valg, man foretager i livet. Her tænkes ikke på almindelige

dagligdagsbeslutninger men valg, som har en betydelig indvirkning på det liv, man nu engang har valgt at leve. Før dette er muligt, må og skal patienten stadig leve op til autonomiens minimumskriterium, men vi må nødvendigvis tilføje et ekstra kriterium; et refleksiv selv hvis valg er meningsfyldte og kohærente og derved foretaget i egenskaben af at være en autonom person.

Det kan dog forekomme problematisk at vurdere, hvornår sygeplejersken skal *respektere patientens valg*, samt hvornår det giver mening at tale om, hvorledes en patient kan bevare sin *værdighed og integritet*. Laura Waddel Ekstrom udarbejder i sit essay *Autonomy and Personal Integration en kohærensteori*, som giver et svar på, hvornår vi kan betragte den enkelte patient og det enkelte menneske som autonom. Ekstroms tilføjer, at der nødvendigvis må være et refleksivt lag i autonomien; et lag som grundlæggende er skabt af jeget selv. Således skriver Ekstrom;

”Motivated, in part, by reflection on particular and motivated, as well, by the problem of regress for hierarchical accounts, a coherence approach to autonomy specifies that the preference on which a person acts must cohere with other of his other attitudes, in order for the act to be autonomously performed.”^[as]

For at vurdere en patients evne til selvbestemmelse, må vi inddrage det refleksive lag, som ikke er til stede hverken hos Kant eller i Beauchamps praksisanvendelse af autonomibegrebet. Denne ekstra tilføjelse gør, at vi må se på personen og ikke valget, når en patient skal vurderes som autonom; dertil må vi bruge begrebet præference. Dette begreb skal ikke forstås i almen forstand, men som et ønske, hvori en kritisk vurdering har fundet sted; herfra bevæger vi os fra et ønske, eller ønsket om at have et ønske, til selve processen. Hvis en patient ytrer, at vedkommende ikke ønsker behandling, eksempelvis grundet religiøs overbevisning, skal sygeplejersken vurdere, hvorvidt dette ønske passer ind i patientens livsanskuelser og præferencer. I sådanne ytring findes patientens egen forestilling om *det gode*; hvilket vil sige patientens subjektive forståelse af, hvad der er *det gode* og sande og ikke nødvendigvis, hvad den videnskabelige definition af *det gode* er. Dette betyder, at anvender vi Ekstrom i etik i sygeplejen, kan vi redegøre for, hvorfor eksempelvis en patient, som lider rent eksistentielt, ikke kan betragtes som autonom; opfylder patientens ønske ikke det subjektive kriterium for forståelsen af *det gode*, hvori vores handlinger skal skabes, giver dette ønske ikke nogen mening, og derfor må sygeplejersken gribe ind ved paternalisme, således at patienten ikke træffer et valg, som er funderet i den eksistentielle lidelse, men derimod forsøge at hjælpe patienten til at lindre sin lidelse – det vil sige at afværge et onde. Dette kan lade sig gøre ved, at sygeplejersken vurderer patientens livsanskuelser og præferencer og derved kan træffe et valg om, hvilken behandlings- og plejeform denne specifikke patient har behov for. Det vil sige, at sygeplejersken skal vurdere patientens karaktersystem og identitet, og

hvilke præferencer disse består i. Heri er præferencer de ønsker, som patienten har truffet på baggrund af refleksiv og kritisk vurdering i sin søgen efter det subjektive gode. Dermed bliver patientens karaktersystem det grundlag, som konstituerer dennes selv. Dette må sygeplejersken have in mente, når hun skal leve op til kravet om at respektere patientens integritet og værdighed; sygeplejersken skal vurdere patientens evne til at træffe valg, som er forenelige med patientens egne værdier (derved skelnen mellem det autonome valg og den autonome person), som forefindes i patientens integrerede selv. Dette kræver, at patienten selv skal være i stand til at redegøre for sin selvbestemmelse, hvori vedkommende skal begrunde sine valg i et værdisystem, hvori patienten har sine overbevisninger og præferencer. Det vil sige, at foretager patienten et valg, som har indflydelse på vedkommendes livskvalitet og anskuelse, så må patienten foretage dette på baggrund af egne præferencer – det er patientens dybere selv, som accepterer og redegør for dette valg, altså noget som er integreret i selvet. Derved kan den professionelle sygeplejerske, i vurdering af patientens autonomi og selvbestemmelse, kræve, at patienten lever op til følgende tre punkter;

- *Has undergone critical evaluation with respect to his conception of the good*
- *Was uncoercively formed*
- *Coheres with his other acceptance and preferences states*^[26]

Opfylder patienten disse kriterier, så kan vedkommende give et sammenhængende forhold af sine præferencer og værdier, og derved er der kohærens mellem patientens eget værdisystem og grundlag samt patientens integrerede selv; *"On the coherence account, a preference P is personally authorized for a person at a time(or counts as 'truly her own' or is a representative of her 'real self') if and only if the preference coheres with her character system at that time*^[27]*."* Ved dette giver det mening at tale om et bredere autonomibegreb – et begreb som danner grundlag for patientens selvbestemmelse. Dette betyder således også, at patienten skal leve op til det brede krav om autonomi, som vi finder i selvbestemmelsesbegrebet. Og for at sygeplejersken kan leve op til Sygeplejeetisk Råds retningslinjer om at behandle og arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet samt vurdere, hvorvidt patienten er i stand til at handle, således at vedkommende kan gøre krav på, og fravælge, selvbestemmelsesretten, må sygeplejersken samt øvrige professionelle have en formodning og antagelse af patientens kohærente præferencer og værdier, således at man kan opnå bedst mulig behandling og pleje, hvorved værdighed og integritet bevares; *"A third-person perspective, as well, may be mistaken concerning whether an attitude is part of someone's real self, depending on the extent of one's knowledge of the other's character. That is, one must have sufficient knowledge concerning about another's collection of evaluatively formed*

attitudes, in order to know if a given preference coheres with them^[28].” Analyserer vi lungecancerpatienten i kohærensteoriens optik, vil behandlingen og plejen af patienten være fokuseret på et andet felt, end hvis vi udelukkende gør brug af Kants autonomibegreb praktiseret af Beauchamp. Ved brug af Ekstrom kan vi fokusere på konsekvenserne af behandlingen; antager vi en patient, som ikke besidder autonomi, men til gengæld besidder en hvis grad af selvbestemmelse, eksempelvis lungecancerpatienten, hvis psykiske tilstand gør, at hun ikke er i stand til at træffe autonome valg i det specifikke sygdomsforløb, kan vi arbejde på at fremme patientens selvbestemmelse og derved bidrage til, at hun på sigt vil være i stand til at besidde et bedre råderum over egen tilværelse. Det er klart, at patientens ustabilitet gør, at hun måske ikke helt formår at overskue konsekvenserne af et givet valg, men dermed ikke sagt, at hun ikke kan (med)bestemme over sit eget valg; ved at fremme selvbestemmelse hos patienten fordres der til en medvirkende af udvikling, som sigter efter, at patienten på et tidspunkt vil være i stand til at udføre et autonomt valg, som passer ind i hendes selvbestemmelsesforløb; det vil sige passer ind i det integrerede selv, og derved kan der sættes lighedstegn mellem patientens valg og præferencer, således at der er tale om et kohærent forløb, som stemmer overens med patientens værdier, livsanskuelser og integrerede selv. At fremme selvbestemmelse er således en konsekvensbetragtende position, hvori man vurderer konsekvenserne af behandlingen og plejen, og man medinddrager patienten for at vurdere, hvad der er bedst for vedkommende. At fremme selvbestemmelse er således en beregnende kalkule mellem autonomi, hvori den enkelte er i stand til at vælge selv, og paternalisme, hvori eksempelvis formynderisk omsorg kan forekomme^[29].

Med dette in mente kan vi bruge Ekstroms teori til at vurdere, hvorvidt en person er autonom. Er der sammenhæng mellem patientens ønsker og præferencer, og stemmer disse overens med personens værensslægtskab, så må patienten kategoriseres som autonom i kraft af, at disse stemmer overens med personens integrerede selv. Men i praksis er dette således også en kompleks teori, fordi der skal medtages et langt bredere perspektiv end ved det kantianske minimumskriterium for autonomi. Men dette brede perspektiv er nødvendigt, hvis sygeplejersken skal være i stand til at vurdere patientens evne til selvbestemmelse samt besiddelse af autonomi. I vurderingen af lungecancerpatienten kan vi ikke nøjes med at vurdere *intention, forståelse* samt *fri af kontrollerende omstændigheder*; vi må således også se på, hvem personen bag patienten er, og hvad baggrunden er, for at hun ikke vil terminalerklæres og derved ikke vil erkende den sidste fase af sygdomsforløbet. Patienten har valgt ikke at lade sig terminalerklære – dette har dog medført et paternalistisk indgreb fra de ansvarshavendes side, hvorved patienten modvilligt er blevet terminalerklæret – patientens valg, hvis de professionelle skal respektere dette, skal funderes på det kantianske

minimumskriterium. Derudover kan vi stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt patientens valg stemmer overens med vedkommendes komplekse værdisystem og præferencer. Sygeplejersken må spørge indtil, hvorvidt patientens valg går i spænd med øvrige præferencer, som er grundlaget for patientens personkarakter og livsanskuelser. I henhold til Ekstroms teori skal lungecancerpatientens valg stemme overens med hendes integrerede selv; dette selv skal således give accept for at foretage dette valg. Dette betyder, at patienten skal redegøre for samt være i stand til at bakke op om sit ønske om ikke at lade sig terminalerklæres. Patientens autonomi er således at finde i valget af præferencer og helhedsbilledet heraf – ikke i det enkelte valg. Lungecancerpatienten skal godkende og acceptere sine ønsker af sit selv. Dette skal sygeplejersken og øvrige professionelle have in mente, når de skal varetage behandling og pleje af sådanne patient.

Grundlæggende giver Ekstroms teori sygeplejersken mulighed for at behandle en patient med værdighed og integritet og samtidig vurdere, hvorvidt patienten er i stand til at besidde retten til selvbestemmelse. Vi kan i tilfælde af lungecancerpatienten sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt patienten har basal forståelse for sit valg samt kan se sig fri af kontrollerende psykologiske omstændigheder. Dertil kan vi tilføje, at patienten (samt hendes datter) ikke er i stand til at bearbejde den tilgængelige information, hun er blevet informeret om af de professionelle i tilstrækkelig grad, samt at patienten ikke er i stand til at argumentere for sit valg om ikke at ville terminalerklæres samt ikke at redegøre for sin afvisning af det palliative team. Der er således grundlæggende faktorer, som gør, at sygeplejersken kan vurdere, at patienten ikke er autonom. Og for at ville patienten det bedst mulige, må sygeplejersken herefter arbejde på, at patienten stadig kan bevare sin værdighed og integritet. Derfor må vi igen bevæge os tilbage til selvbestemmelsesbegrebet og anskue, hvad der er bedst for patienten. For at finde ud af dette, må sygeplejersken vurdere patienten med et udgangspunkt i kohærensteorien, hvori hun vil bidrage til, at patienten, forudsat muligheden for det, kan, som tidligere nævnt, bruge en beregnende kalkule i forholdet mellem autonomi og paternalisme og derved fremme patientens selvbestemmelse; *"Sygeplejersken skal medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information, der gives, skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt livssituation"*^[30]. Først nævnte kan ikke lade sig gøre, da vi har vurderet, at patienten ikke er autonom. Opgaven lyder nu på at fremme patientens selvbestemmelsesevne; dertil må vi se på den sidste del af §2.2, hvori sygeplejersken skal være i stand til at tilpasse patientens ønsker og behov. I dette tilfælde vil det ikke give nogen mening at tilpasse patientens ønske om ikke at samarbejde med det palliative team, da dette vil betyde, at sygeplejersken ikke vil være i stand til at leve op til fordringen om at lindre lidelse. Men derved ikke sagt, at sygeplejersken ikke kan leve op til fordringen

om at tilpasse patientens behov samt livssituation; derved skal sygeplejersken endnu en gang mobilisere sit fokus på konsekvensen af, hvad det vil sige at fremme patientens selvbestemmelse; sygeplejersken må dertil vurdere patientens kohærente præferencer og livsanskuelser for derefter at forsøge at behjælpe patienten med at besidde, empower og forstå flere facetter af begrebet selvbestemmelse.

Det første, sygeplejersken skal have in mente, er vurdering af patientens *selvansvarlighed*, og hvorvidt vedkommende er i stand til at vedligeholde denne facet. At udøve selvansvarlighed vil sige at være i stand til at danne egne mål og handleplaner samt det faktum at være i stand til at virkeliggøre disse^[31]. Således bliver selvansvarlighed et spørgsmål om at leve op til det ansvar, man har over for sig selv og derved respektere sig selv. I dette forefindes spørgsmålet om at vælge; de fleste mennesker er i stand til at vælge, nogle mere end andre, og i dette ligger det eksistentielle incitament, som driver mennesket; at foretage valg fordi man har et ansvar for sig selv og det faktum, at man umiddelbart er bedrevidende angående, hvad der er bedst for egen person. Samtidig kan man vælge ikke at vælge; det vil eksempelvis sige at fravælge egen selvbestemmelsesret; er patienten bevidst om, hvad det vil sige at fravælge sig dette, så er dette at have ansvar for sig selv velvidende, at den berørte ikke umiddelbart selv kan vurdere eller efterleve, hvad der er bedst, og derved vælger vedkommende at frasige sig retten til selv at vælge. I denne fravælgelse bevarer patienten således sin selvansvarlighed, da vedkommende autonomt vælger at fravælge sig retten til selv at bestemme; derved bevarer patienten således sin værdighed, da patienten, grundet valget, forbliver et mål-i-sig-selv, et menneskeligt subjekt, og ikke reduceret til et objekt, som tilfældet vil være, hvis sygeplejersken vælger ikke at inddrage den autonome patients ret til at fravælge sig selvbestemmelsesretten og derved begå formynderi mod patienten.

I tilfælde af at patienten ikke er bevidst om sin selvansvarlighed, det vil sige, hvis patienten ikke selv er i stand til at vælge eller vælge ikke at vælge, lever patienten ikke op til autonomiens minimumskriterium, da dette indikerer, at vedkommende ikke har basal forståelse for situationen. Derudover kan vi stille spørgsmålstegn ved kriterierne intention og fri af kontrollerende omstændigheder. Dette er problematisk i kantiansk forstand, da dette betyder, at der i patientens foretagende vil være tale om naturlige tilbøjeligheder og derved tilfældigheder; man lever således ikke op til fornuftens kriterium, hvori den enkelte er i stand til at foretage værdifulde valg og beslutninger. Dette betyder således også, at patienten heller ikke kan udøve selvbestemmelse, da vedkommende ikke er i stand til at vælge sine valg, hvilket fører til, at denne ej heller er i stand til at udøve selvbestemmelsesbegrebets anden facet; *selustyre*.

At udøve selvstyre vil sige at være bevidst om egne mål og værdier. Den enkelte må selv vælge sine valg, inklusiv værdier, idealer, projekter og det faktum at være i stand til at etablere relationer til andre mennesker^[32]. I forlængelse af Ekstrom er det via selvstyre, at man skaber sig selv, via valg af værdier og præferencer. Derved bliver vedkommende, som er i stand til at udøve selvstyre, i stand til at begrunde sine værdier og valg. Derved sammenhængen med selvansvarlighed da præferencevalg skal give mening med det ansvar, man har over for sig selv og sin identitet. Man bliver således til et bestemt individ med bestemte livsanskuelser og indhold, og derved besidder man grunde for at vælge værdi-x frem for værdi-y, da det at vælge en handling eller værdi, som ikke er kompatible med ens integrerede selv, det vil sige ens kohærente præference system, vil være at svigte sine idealer og værdier og derved svigte sig selv. For at undgå disse præferencekontradiktioner kræver det netop at besidde, samt forstå, de muligheder et eventuelt præference valg har på de værdier og forpligtelser, som man har skabt i sit livsforløb. Dette fører til den sidste facet i evnen til selvbestemmelse; at være i stand til at besidde evnen til *selvudvikling*.

Selvudvikling er evnen til at indrette sit liv efter specifikke mål og værdier; *"Selvudvikling er den proces, hvorigennem man når frem til en vis afklaring af sine mål og værdier – af hvad man finder værd at være, værd at gøre og værd at opnå i livet. Den er kompleks (forskelligartede relationer og aktiviteter) og livslang"*^[33]. At processen er livslang betyder også, at for at udøve selvbestemmelse skal man være i stand til, via proces, at komme frem til ens egne værdier og præferencer; det vil sige både at være i stand til at realisere, så vidt muligt, den handling det kræver at opnå et mål og have en forståelse og afklaring for, hvorvidt disse mål og værdier passer ind i ens kohærente præferencer. Men da processen er udspændt over længere tid, en livsproces, så kræver det, at man har indsigt og forståelse af egne værdier, mulige valgmuligheder og derved at indrette sit liv efter forskellige omstændigheder. Rammes en person eksempelvis af alvorlig sygdom, så kan dette, både direkte og indirekte, ændre personens familieforhold, og man må derfor også være i stand til at forstå sig selv, samt sin familie, underlagt disse nye og uventede omstændigheder – derefter må man forholde sig til sin sygdom og de familiemæssige omstændigheder efter ens præferencesystem og finde ud af, hvilke handlinger og gøren er autoriserede præferencer (det integrerede selv).

Disse tre facetter for selvbestemmelse inkluderer også autonomi. Men i og med at vi skal forstå den enkelte patient som en del af et større sammenhæng, eksempelvis familie, så forbliver autonomi på lige fod med de øvrige facetter og er derved ikke hævet over disse. Facetterne hænger holistisk sammen og kan ikke blive anskuet rent isoleret set.

I henhold til etik i sygeplejen er det, må vi notere os, at sygeplejersken har et ansvar for at fremme patientens selvbestemmelse samt at lindre patientens lidelse; men for at være i stand til dette, må sygeplejersken forstå, og sætte sig ind i, patientens definition af det gode, på trods af dette måske adskiller sig fra, hvad sygeplejersken selv anser som det gode. Og så længe at patienten er i stand til at argumentere og udøve selvbestemmelse, så må sygeplejersken nødvendigvis respektere patientens ønske og definition af det individuelle gode.

Lad os endnu engang spørge om hvorvidt patienten er autonom? Som indikeret tidligere lader det sig være ganske sikkert, at vedkommende ikke er en autonom person, som er i stand til at udøve selvbestemmelse. Dette skyldes, som nævnt, at vi kan stille spørgsmålstejn ved, hvorvidt der er en sammenhæng mellem patientens ønsker og integrerede selv. Dette forhold kan ydermere udpensles i patientens manglende evne til at besidde selvansvarlighed – da patienten nægter at høre tale om sin kritiske tilstand, beskadiges hendes evne til at danne realistiske mål og handleplaner, hvilket betyder, at patienten ikke er bevidst over egne mål og værdier og derved ej heller er i stand til at udøve selvstyre. Således kan patienten heller ikke være i stand til at udføre selvudvikling, da hendes manglende valg af modtagelse af behandling fra det palliative team gør, at selvudviklingen obstrueres, da vi må antage, at patientens manglende evne til at foretage begrundet valg gør, at dette ikke stemmer overens med hendes specifikke mål og værdier. Grundlæggende kan vi vurdere, at patienten hverken er autonom eller i stand til at udøve selvbestemmelse. Derfor må sygeplejersken, for at bevare patientens værdighed og integritet, hjælpe til med at fremme patientens selvbestemmelse, det vil sige at agere som et hjælpemiddel for patienten, hvorved hun i sidste ende gerne skulle være i stand til at træffe sine egne valg – valg som lever op til Ekstroms teori om et integreret selv; at træffe reflektive valg begrundet gennem kritisk vurdering og begrundelse. Dertil må anvendes en konsekvensbetragtende utilitaristisk etik, som kan medvirke til at foreskrive en etik, vis målsætning, i denne henseende, at regulere patientens adfærd og forståelse evne; at hjælpe patienten til at forstå sin situation og derved træffe egne valg på baggrund af en velbegrundet og professionel informations formidling, hvorved patienten, i sidste ende, skal være i stand til at indgå informeret samtykke. For at begrunde sådanne samtykke, hvorved patientens bedste er et absolut mål, bliver det konsekvensbetragtende princip således til et spørgsmål om, hvorvidt den professionelle kan skabe et grundlag for, at patienten kan opnå størst mulig lykke. Dette princip er lig Ekstroms princip om det gode for den enkelte. Den engelske filosof John Stuart Mill beskrev i værket *Utilitarisme* fra 1863 den utilitaristiske doktrin på følgende måde; *”Den utilitaristiske doktrin er, at som mål er lykke ønskværdigt, og det eneste ønskværdige – alt andet er kun ønskelig som middel til et mål”*^[34]. Dette adskiller sig markant fra Kants morallov, da det konsekvensbetragtende

princip forebygges på konsekvensen, hvorved motivet eller sågar den enkelte handling i sig selv er irrelevant. Formålet er rent teleologisk; i dette tilfælde at fremme patientens evne til at udøve selvbestemmelse. At fremme lungercancerpatientens selvbestemmelse vil sige at respektere hendes kohærente præferencer og integrerede selv. Og det eneste som kan retfærdiggøre og bevise, hvad der er bedst for lungecancerpatienten, er det faktum, at hun rent faktisk ønsker det. Men da patienten i Ekstroms autonomidefinering ikke er autonom, da hun ikke har et sammenhængende kohærent system, må den professionelle foretage sin handling på et rationelt og begrundet grundlag, hvorved hun inddrager patientens livsanskuelser (de anskuelse og præferencer som sygeplejersken vurderer, at patienten har haft før fornægtelsen af de kritiske omstændigheder) således, at patienten kan behandles med værdighed og integritet. En mulig anvendelsesmodel hvorved vi, muligvis, kan fremme patientens selvbestemmelse, og derved undgå en direkte brug af paternalisme er at gøre brug af *Voksen-ung-modellen*, som kan agere bistand til patienter, som er moralske demoraliserede og ikke i stand til at besidde en selvbestemmelse evne; *”Det er mennesker, der på den ene side formår at træffe egne valg, men hvis værdier, holdninger og ikke mindst evne til selv er så mangelfuld, at valgene ofte skader både deres egen og andres menneskers bedste interesse og velværd^[5].”* Jeg vurderer, at denne model kan bevirke en positiv effekt på lungecancerpatienten, da hun stadig er fungerende som mennesket – forstået på den måde, at det lader til, at hun stadig kan træffe valg og være autonom, så længe at det gælder facetter, som ikke berører hendes sygdomsforløb. At patientens værdier, holdninger og manglende evne til at forstå den kritiske situation gør således, at ikke mindst patienten selv, men også andre personer lider skade, eksempelvis datteren, som heller ikke er autonom, da det ikke at træffe – eller overveje – et valg gør, at både patienten og de berørte parter interesser og velfærd ikke imødekommes. Ved *Voksen-ung-modellen* kan sygeplejersken medvirke til, at patienten på sigt kan træffe egne valg, og derved lever den professionelle også op til fordringen fra De Sygeplejeetiske Retningslinier §2.2 om at *medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe et valg*. Denne information bliver gennem *Voksen-ung-modellen* mulig at videregive til patienten, hvilket sker på et grundlag, hvorved informationen er tilpasset den enkelte patient og dennes definition af det gode. Lykkedes dette, kan vi således tale om, at sygeplejersken, via pædagogik, langsomt, men sikkert, giver patienten et ansvar i og for behandlingen. Der er således tale om en videregivelse af ansvar, hvorved sygeplejersken kan vurdere, via Ekstroms teori, hvornår patienten er i stand til at fremme egen selvbestemmelse og derved være i stand til at træffe et autonomt og begrundet valg. Således er der også tale om brugen af det konsekvensbetragende princip om størst mulig lykke; i dette tilfælde for den enkelte patient, hvorved sygeplejersken ikke begår paternalistisk formynderi, da denne ’overdrager’

lungetcancerpatientens autonomi og selvbestemmelse på et teleologisk og sikkert grundlag, hvorved der tages ansvar for patienten på en værdig og integreret måde.

Lykkedes Voksen-ung-modellen kan vi også begynde at tale om den Professionsetiske Beslutningsmodels øvrige konsekvens kriterier; at forebygge negativ sundhed, det vil sige at forebygge sygelighed, og lindre lidelse. At forebygge negativ sundhed lader i dette aspekt sig være umuligt, da kræften er på et meget kritisk stadie, hvor man er klar over, at døden er den eneste udvej. Derfor giver det ingen mening at belyse dette kriterium, da dette ej heller kontradikterer med nogle af de øvrige punkter i hverken konsekvensetikken eller pligtetikken. Til gengæld lader det til, at fordringen om at lindre lidelse ikke er opfyldt. I belysningen af dette må vi skelne mellem forskellige former for lidelse; den umiddelbare fysiske lidelse hvor patienten lider af en kropslig udfoldelses begrænsning, hvori det kan forekomme besværligt at få hverdagslivet til at fungere på lige fod med ens øvrige medmennesker. Derudover kan en patient lide af psykisk lidelse. Eksempelvis en nervøs lidelse eller andre lidelser, hvis symptomer findes i gradbøjelig forstand i alle mennesker, såsom tvangstanker, nedsat humør, alkohol forbrug osv. Men først når disse symptomer har indvirkning på patientens helbredstilstand og sociale evner, kan vi tale om en psykisk sygdom. Dette indikerer selvfølgelig også, at overgangen fra normalitet til sygdom er glidende, og derfor kan defineringen af dette ofte forekomme som en vævende grænse. Mest interessant i denne case er defineringen af patientens eksistentielle lidelse; i denne lidelsesform må vi se på mennesket og hvorledes, det udspiller sig i og forholder sig til verden. I dette finder vi, at lungetcancerpatienten sandsynligvis lider af én angst for døden. Angst kan vi kategorisere som et grundvilkår for mennesket – og angst bliver særlig evident i forhold til døden, da dette er den absolutte negligerende af menneskeligheden. Og netop det faktum, at patienten ikke vil erkende, at hendes tilstedeværelse er ved at svinde hen, gør, at patienten fornægter sygdomsmæssige omstændigheder, hvilket resulterer i en tilstand af eksistential lidelse. Derfor bliver det at fremme patientens selvbestemmelse også til det middel, som skal bidrage til at forbedre patientens eksistentielle tilstand; for kan selvbestemmelsen fremmes via Voksen-ung-modellen, så kan patienten også gradvist få en forståelse af sin sygdom efterfulgt af en kohærent præference, som kan begrunde, hvorfor patienten eksempelvis kan se det gavnligt at gøre brug af det palliative team. Derved kan den fysiske smerte til dels reduceres, men måske endnu vigtigere på dette stadie kan den eksistentielle lidelse reduceres, og patienten kan få skærpet sin angst og frygt for døden, begrunde sine valg via professionel information, og måske vigtigst; fremme magten over egen tilværelse.

Konflikten mellem den personlige autonomis begrundede valg og paternalisme

Casen med lungecancerpatienten viser, at patienten hverken besidder autonomi i snæver forstand og ej heller besidder det brede selvbestemmelsesbegreb, personlig autonomi. Efterfølgende har vi set, hvorledes vi kan gøre brug af at fremme patientens selvbestemmelse således, at vedkommende er i stand til besidde magt over egen tilværelse med mere. Men hvad skal den professionelle sygeplejerske gøre med en patient, som fuldt ud lever op til det reflektive autonomi begreb, som Ekstrom opstiller, samt besidder evnen til at have magt over egen tilværelse, men alligevel vælger ikke at modtage den behandling, og dertilhørende pleje, som de professionelle anbefaler? Lad os se nærmere på sådan et tilfælde;

”Da Sigmund Freud lå for døden, havde han frygtelige smerter og fik tilbudt morfin. Imidlertid satte han værdien af et klart hoved højere end værdien af smertefrihed og takkede nej^[36].”

Denne korte beskrivelse af psykoanalytikeren Sigmund Freuds sidste tid virker umiddelbart ikke som et tilfælde med konfliktinteresse; ved Kant har vi set, at en autonom person aldrig må krænkes, da dette kontradikterer med ytringen om mennesket som mål-i-sig-selv. I dette tilfælde står dette dog i konflikt til den tidligere belyste paragraf i De Sygeplejeetiske Retningslinjer, hvori der står, at *sygeplejersken skal medvirke til at lindre lidelse og bistå en værdig død* samtidig med, at sygeplejersken skal respektere patientens ret til selvbestemmelse. Dertil har vi nu identificeret de etiske principper, som lader sig være i konflikt. Ydermere må vi spørge, hvem de berørte parter er; hertil er Freud selv, i skikkelse af en lidende patient samt, må vi antage, en sygeplejerske. Spørgsmålet er nu, hvilke muligheder sygeplejersken har i behandlingen og plejen af Freud; skal hun vælge at bruge paternalistisk tvang, hvorved Freud underlægges pressen, således at han modvilligt indtager morfin og derved lindres hans (fysiske) lidelse? Eller skal sygeplejersken respektere Freuds autonomi samt ret til selvbestemmelse? Dertil må vi spørge; kan vi antage at Freud er autonom samt i stand til at yde selvbestemmelse, når han træffer dette valg? I modsætning til lungecancerpatienten begrundet Freud netop sit valg, og derved bliver hans grundlag klart; valget skyldes et ønske om at have *et klart hoved*. Således lader det til, at Freud er velovervejet; han lever op til autonomiens minimumskriterier og er i stand til at yde selvansvarlighed, hvorved han danner sig et mål og sætter en handleplan derefter – i dette tilfælde er det målet om *et klart hoved*. I forlængelse af dette er Freud således også i stand til at udøve selvstyre, da han er bevidst om sit ønskede mål og værdien deraf. I forlængelse af dette udøver Freud således også selvudvikling, da han gennem en proces, evaluerer egne værdier, hvorved

han når frem til afklaring af sine mål og værdier, og han vælger således dette som en del af det liv, han ønsker at leve. Han retfærdiggør og begrundet sit valg; et valg hvis fundament er et kohærent præference system, hvori Freud selv er i stand til at vurdere, hvad der er de bedste konsekvenser for hans valg, og derved hvad der er hans egen individuelle definition af et ønsket gode. Sygeplejersken, som ønsker at modstride sig Freuds ønske, går således imod tanken om det enkeltes menneskes ret til at leve og udfolde sit eget liv. Tænk eksempelvis på John Stuart Mills ytring om at ens eget liv og evnen til at leve dette er den bedste; *"Hvis en person besidder så meget som blot en nævneværdig sum af sund fornuft og livserfaring, er hans egen måde at indrette sig i livet på den bedste – ikke fordi den er bedst isoleret betragtet, men fordi den er hans egen"*^[37]. Derved kan vi ikke retfærdiggøre brugen af paternalisme i dette tilfælde, da Freud besidder personlig autonomi og træffer sit valg, på hvad vi må antage, velinformerede principper og har forståelse for disse.

Sygeplejersken må respektere Freuds valg, da dette valg er begrundet samt at han er klar over konsekvenserne. Derved kan sygeplejersken ikke retfærdiggøre pression og må derfor acceptere, at Freud vælger et valg, som ud fra et professionelt synspunkt, måske kan anses for at være forkert, eller i hvert fald mindre godt. I dette er der tale om et frihedsprincip, som man ikke retfærdigt kan bryde, hverken ved pligt eller konsekvensbetragende etik. Den konsekvensbetragende sygeplejerske vil måske forsøge sig at gøre brug af et argument, som lyder på, at Freud ikke er selvbestemmende, og derved må vi forsøge at fremme hans selvbestemmelse. Men som vist er dette ikke tilfældet, da Freud fuldt ud lever op til autonomiens minimumskriterier, Ekstroms kohærensteori samt, og i forlængelse af dette, personlig autonomi. Der er ved dette tale om en patient, som har fuldt ud magt over egen selvbestemmelse, er klar over konsekvenserne af sit valg, hvilket han vurderer skal vægtes som en værdi af højere karakter end værdien af at lindre lidelse.

Spørgsmålet er dog, hvorvidt der nødvendigvis må tilføjes endnu et kriterium i forholdet mellem autonomi og etik i sygeplejen? Dertil må vi bevæge os hen mod begrebet omsorg, og hvorledes dette skal ydes i sygeplejen, og om dette begreb kan give os et bredere og mere fyldestgørende perspektiv på behandlingen og plejen, samt forståelsen, af den berørte patient.

VÆRK III • AFSNIT 10

Om forholdet mellem autonomi og omsorg

Lad os vende tilbage til lungecancerpatienten som ikke lader til at være samarbejdsvillig med det professionelle personale. Vi konkluderede tidligere, at patienten ikke var i stand til at træffe et autonomt valg, fordi hun umiddelbart ikke levede op til Beauchamps minimumskriterium for autonomi.

Spørgsmålet er; hvorledes skal man behandle og pleje sådan en patient? Skal man påføre vedkommende paternalisme og i så fald, i hvilken grad skal den udøves? Pligtetikken lader ikke til at svare på dette spørgsmål og for at finde et svar, må vi bevæge os væk fra pligtetikken absolutte sfære samt den individuelle konsekvensbetragtende etik og anerkende, at andre perspektiver er nødvendige for at pleje patienten med omhu og omsorg. Begrebet sygepleje betyder, at vi rent essentielt har at gøre med en praksis, hvori en patient plejes. Det centrale fundament i dette er *pleje*, hvilket etymologisk betyder *at bære omsorg for*^[38]. At bære omsorg betyder i sygepleje institutionel praksis, at man har et ansvar over for den anden, altså patienten. Det centrale er således at se og opfatte patienten som et menneske og ikke blot en pligt. Den konsekvensbetragtende teori præsenteret ved Ekstrom gav os mulighed for at betragte patienten som et individ med et bredere autonomibegreb i form af selvbestemmelse. I forlængelse af det findes et ontologisk perspektiv, som nødvendigvis må inddrages i patient forholdet. Et perspektiv som hverken kantianeren eller den konsekvensbetragtende etikker kan redegøre for.

Lungecancerpatienten er ikke kun en patient, men også et menneske – et menneske der må vises omsorg for, således at hun kan få den bedste mulige pleje. Knud Ejler Løgstrup skrev i sit værk *Den etiske fordring* fra 1956 at; *”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd*^[39].” I dette er det den mellem menneskelige anvisning, som er afgørende; fordringens tavshed medfører, at det er op til den enkelte selv at finde ud af, hvad der er godt for den anden. Sygeplejersken må i tilfældet med lungecancerpatienten forsøge at etablere en livsudfoldelse af den andens tilstedeværen. Dette vil grundlæggende sige, at sygeplejeren må tage ansvar for patienten og ikke fra patienten. Eksempelvis skal sygeplejersken også inddrage de psykologiske forhold, som spiller ind i forhold til lungecancerpatienten, hendes datter samt valg. Således bliver det etiske forhold udvidet; ved pligtetikken var der kun tale om forholdet mellem patienten og de professionelle, men i og med, at *den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd*, så må også datteren identificeres i dilemmaet. Der er således konflikt mellem patientens autonomi og personalets professionelle evne til at vurdere, hvad der er bedst for denne samt det faktum, at moderen ikke vil sige farvel til sine pårørende. Efter patientens død vil der muligvis opstå en situation, hvori de pårørende ikke føler, at de fik afsluttet sygdomsforløbet på en værdig måde, da de ikke fik sagt farvel til patienten. Således er det ikke kun datteren, men også de øvrige familiemedlemmer, kollegaer, venner osv. som til en hvis grad må inddrages i forløbet. Ganske vidst ved den professionelle sygeplejerske bedst – umiddelbart – men de personer, som er inddraget i dilemmaet gør, at også værdier er inddraget; derfor er det vigtigt for sygeplejersken at rumme situationen og gribe ind på det rigtige tidspunkt. På den anden side skal det involverede personale være opmærksom på, at patienten har ret til at frasige

sig informationen. Dog kan man ved brug af autonomiens minimumskriterium samt Vokens-ung-modellen argumentere for, hvorvidt dette overhovedet giver mening, hvis patienten ikke er autonom. Sygeplejersken balancerer således mellem at have ansvar og påtage sig ansvar; den professionelle står til ansvar for at udføre sin profession bedst muligt samtidig med, at hun må påtage sig ansvar for patienten; *"Ansvaret for den anden kan aldrig bestå i at overtage hans eget ansvar"*^[40]. Men netop fordi patienten ikke fuldt ud er i stand til at tage ansvar, må sygeplejersken hjælpe patienten med at udføre sit eget ansvar. Man kan forestille sig, at dialog med lungecancerpatienten vil medføre, at hun kan være i stand til bedre at indse og forstå sin situation. Dette inkluderer inddragelse af patientens præference system og livsanskuelser - og ved at hjælpe til med at patienten er i stand til at yde selvbestemmelse kan man medvirke til, via omsorg, at patienten modtager bedst mulig behandling. Således lever sygeplejersken op til, at denne rent faktisk har et ansvar og ikke blot påtager sig et ansvar, da hun via sit ansvar tager patienten metaforisk i hånden og forsøger at hjælpe hende på rette kurs ved hjælp af omsorg og ikke af pligt. Derved udvikles udviklingen af patientens selvbestemmelse i form af Voksen-ung-modellen samtidig med, at der nu bliver sat konkret handlen på forholdet mellem sygeplejersken og patienten; at udøve, i praksis, konsekvensbetragtende etik, som dog går skridtet videre og vurderer, at grundlaget for udøvelsen er omsorg og ikke udelukkende det faktum, at patientens selvbestemmelses evne skal udvikles i én bestemt retning. Nu bliver flere perspektiver mulige. Ikke kun i teori men også i praksis. Dertil kræver det, at sygeplejersken selv lever op til og udvikler et ideal, som hun skal leve op til for at bevare sin egen værdighed og integritet i henhold til hendes profession.

I det følgende vil vi se, hvorledes Løgstrups etik danner et grundlag for den sygeplejeetiske ideal etik.

Grundlæggende kan vi sige, at Løgstrups etik kan være med til at forstå samt give et handlingsgrundlag for de eventuelle etiske dilemmaer, sygeplejersken ofte befinder sig i. Dog skal Løgstrups ontologiske etik i denne kontekst ikke læses adskilt fra Kants pligtetik, da den kantianske tese om fornuftsvæsnets absolutte værdi er den grundlæggende i henhold til respekten for patientens autonomi. Dog afviger Løgstrup fra Kants etik på et område; fornuftsvæsnet, altså menneskets, uafhængighed.

Der må, ifølge Løgstrup, inddrages et dualistisk forhold, interdependens, mellem de implicerede parter; vi kan ikke se på mennesket, autonomt eller ej, som en isoleret, selvskabende, genstand, hvilket Kant giver udtryk for i sin etik. Af samme grund kan pligtetikken ikke stå alene i den sygeplejeetiske kontekst, da sådan ideologisk og endimensionel livsforståelse kan føre til stærk paternalisme;

”Den [livsforståelse] kan stivne til en ideologi og for den enkelte blive en simpelthen absolut størrelse. Jo mere det sker, desto mere bliver den enkelte forholdet til andre mennesker en anledning til anmasselse og eventuel overgreb^[41].”

Således må patientens livsforståelse inddrages i behandlingen, da andet vil være en bedrevidenhed, hvori man kan tiltvinge patienten uønsket anmasselse, hvorved man eksempelvis, indirekte, presser patienten til at foretage et valg, som vedkommende ikke ønsker. Derved må sygeplejersken anerkende, at i mødet med patienten opstår etikken, og derfor kan den professionelle ikke blot påtvinge patienten egne principper og regler. Konsekvensen af dette er, at sygeplejersken, i den etiske konflikt, kan genkende tidligere forhold i situationen; det vil sige at have et grundlag for at overføre tidligere erfaringer fra lignende situationer til den specifikke situation^[42]. I konflikten med lungecancerpatienten og hendes datter må sygeplejersken vurdere de ontologiske grundvilkår, som finder sted i situationen – vedkommende må forestille sig selv i patientens sted og træffe sit valg begrundet i professionelt samt medmenneskelig henseende og (med)forståelse; fordi både patienten og den professionelle på menneskeligplan er afhængige af hinanden. I sin belysning af dette i værket *Løgstrup og Sygeplejen* udtrykker Kari Martinsen forholdet således; *”Vi kommer hinanden ved, og det er ikke noget, vi vælger, og ikke noget, vi kan argumentere for. Selv når vi er mest suveræne og selvstændighed, er vores styrke og uafhængighed fundamentalt set en afhængighed af andre^[43].”* Patienten må anses som et menneske med værdighed og integritet, som ikke kan krænkes; vedkommende er afhængig af sygeplejersken, lægen osv. på samme måde, som de er, i én eller anden grad, er afhængige af patienten. Den professionelle kan ikke blot foretage et rent naturvidenskabeligt valg på vegne af patienten, da sådanne valg ikke inddrager de ontologiske perspektiver, hvori blandt andet omsorg findes. Og da den professionelle og patienten *kommer hinanden ved*, kan man ikke undlade at inddrage de medmenneskelige perspektiver i behandlingen og plejen af patienten.

De medmenneskelige perspektiver kommer til udtryk, ifølge Løgstrup, ved de suveræne livsytringer; udgangspunktet er, at etikken kommer til udtryk i føretiske suveræne livsytringer; tillid, barmhjertighed, medfølelse mm^[44]. Derved kan vi tale om noget, som er bestemt på forhånd. Det vil sige; de suveræne og spontane livsytringer er bestemt, før vi har bestemt dem; *”I fordringens ensidighed kommer det til udtryk, at vi modtager livet i tillid til det at prisgive os til det^[45].”* Dette betyder, at vi står til ansvar for vores handlinger, fordi livet er os skænket – heri tanken om fordringens ensidighed. Løgstrups etik er, på trods af tanken om livets skænkethed og ensidighed, åben for selvudfoldelse og ansvar; etikken er spontan. Den forefindes i situationen via de suveræne livsytringer. Dette er i klar kontrast til Kants etik,

hvori etikken allerede på forhånd er forudbestemt af universalgyldige principper. Etikens spontanitet er begrundet i en spontan godhed; etikken vokser frem i situationen, da der allerede på forhånd er noget betydnings- og værdifuldt på spil; noget som vi ikke selv er med til at skabe og forme. Etikken er ikke blot en standard, som vi skal forsøge at leve op til, men vi må tage den i vores hånd og så vidt muligt forsøge at leve op til vores etiske ansvar; at vi altid har at gøre med det andet menneske, og at vi skylder det bedste grundet livets skænkethed. Det vil sige, at fra tilliden og kendsgerningen udspringer fordringen om, at vi som mennesker skal tage vare for hinandens liv. I sygeplejen kommer dette til udtryk ved eksempelvis tillid. Sygeplejersken vil altid stå over for kendsgerningens interdependens. Den tavse fordring er uudtalt, og sygeplejersken skal være i stand til at træffe et valg begrundet i omsorg samt professionalism. Der må således inddrages en subjektiv livsforståelse, som er grundlagt gennem sygeplejerskens tidligere erfaringer samt en naturlig forståelse af, hvad der er det bedste for patienten. Sygeplejersken og patienten er forbundet med hinanden, og i omsorgen findes den føretiske suveræne livsytring *tillid*; en sygeplejerske og patient, som ikke besidder et interdependens tillidsforhold, vil ikke være i stand til at aktualisere det faktum, at de til en vis grad er forbundet med hinanden i situationen, og derved bliver omsorgsbegrebet reduceret til ikke-værende i og med, at den professionelle og patienten ikke møder og anerkender hinanden i et tillidsforhold men et mistillidsforhold. Det vil ikke være muligt at leve op til fordringens radikalitet, hvori den enkelte skal forsøge at tage den andens liv i sin hånd og ville vedkommende det bedste. Dette kan ikke være muligt, hvis et mistillidsforhold er det grundlæggende frem for et tillidsforhold; ”*Uanset hvor stort eller ringe udvortes set det er, der skal gøres, er fordringen radikal, fordi den enkelte ifølge sagens natur ikke af nogen anden, men kun af sin egen uselvskhed kan få at vide, hvad der tjener den anden bedst*”^[46]. Dette skyldes, i min optik, at i mistillidsforholdet kommer eget subjekt før det andet subjekt; man begrundet sine valg og handlinger i en egocentrisk tendens, hvori den anden tilsidesættes for egeninteresse, hvilket betyder, at man ikke kan være i stand til at opfylde de suveræne livsytringers krav, fordi der således ikke kan være tale om en spontanitet. Ej heller kan sådanne suveræne livsytringer være anonyme. Følger sygeplejersken til gengæld Løgstrups tanke om livsytringen, bliver hun i stand til at handle i og med, at der i situationen forlanges noget af sygeplejersken; nemlig omsorg. Én omsorg som ikke kan komme til udtryk, hvis sygeplejersken og patientens forhold er baseret på mistillid. Tilliden er således det, som giver sygeplejersken grund til at handle. Men modsat den kantianske etik, hvori der allerede på forhånd er tale om absolut princip, hvori den enkelte nødvendigvis skal følge pligten for at handle af moralskværdifuld karakter, kan vi ved Løgstrup forlange mere end dét; at sygeplejersken viser omsorg grundet fordringen. Og på trods af, at den ensidige fordring er skabt, henleder den til, at sygeplejersken må udøve en

handling i erkendelse af, hvad vedkommende skylder det andet menneske, altså patienten. Kari Martinsen udtrykker dette forhold således; *"Jeg svigter noget vigtigt i mig selv, når jeg svigter mit ansvar for den andens ve og vel^[47]."* Den professionelle må nødvendigvis leve op til sit ansvar – et etisk ansvar som både inkluderer patienten samt sygeplejersken selv.

Problematikken ved de spontane livsytringer er dog det faktum, at vi ikke altid handler spontant; vi kan ikke altid spontant vise den anden umiddelbare tillid og barmhjertighed. Dette betyder, at for at leve op til fordringens ensidighed, kan vi så vidt muligt forsøge at efterleve den^[48]. Bliver vi selviske i vore handlinger, møder vi den anden med mistillid før tillid, så fejler vi i vore livsforståelse, fordi vi ikke erkender den kendsgerning, at livet er os skænket, og vi kan ikke blot forlange fordringen påført vore egeninteresse via den anden, da dette er en ophævelse af fordringens ensidighed. At vi ikke altid er i stand til at handle spontant efter livsytringerne betyder, at vi har brug for en vejledende regel, således at vi er i stand til at erkende, hvorledes vi skal handle. Det vil sige, at vi har behov for en regel som kommer efter spontaniteten;

"Fordringen er blandt andet formuleret i den gyldne regel: Alt hvad du vil at de andre skal gøre mod dig, skal du gøre imod dem. Den er alt andet end en lunken regel om at gøre gengæld. [...] Den er tværtimod en regel for brugen af vor fantasi. Den forlanger, at vi skal fantasere os til, hvordan vi vil ønske der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted – for så aktuelt at handle imod den anden på den måde^[49]."

I sygeplejeetisk henseende betyder dette, at den professionelle må bruge sin fantasi til at sætte sig i patientens situation. Eksempelvis, at sygeplejersken kan forstå den førnævnte patient med lungecancer og hendes datter på sådanne måde, at hun får langt større og mere eksistentiel indblik i lungecancerpatientens situation, end hvis sygeplejersken nøgternt ville vælge kun at inddrage den kantianske pligtetik, hvori hun rent professionelt kan give en vurdering af, hvorvidt patienten er autonom, og hvilken beslutning vil være bedst for patienten, men ikke vil være i stand til at give en vurdering af patientens eksistentielle eksistens og værdighed. For nok kan Beauchamp give et grundlag for, hvorvidt patienten er autonom eller ej, men han vil ikke være i stand til at vise lungecancerpatienten omsorg, da han ikke kan gøre brug af det redskab, som Løgstrup præsenterer i sin filosofi; at tænke sig selv ind i den andens situation samt eksistentielle ve og vel. Bruger vi Løgstrup til dette, bliver sygeplejersken netop opmærksom på sit ansvarsområde på sådanne måde, at vi kan tænke hende ind i et ideal karakter, hvori patienten, altså den anden, bliver vendt mod sygeplejersken (jeget) og derved forenes disse to på et holistisk eksistentielt niveau, som ikke kommer til udtryk i kantianismen. Derved kan sygeplejersken handle ud fra idealer, som tilbyder, at sygeplejersken er i stand til at handle med omsorg, hvilket betyder, at hun kan

tage ansvar for sine valg med etisk ansvarlighed samt integritet^[50]. Men i og med at der i dette er tale om karakter-idealer, må sygeplejersken, ved hjælp af sin erfaring, fantasi og indsigt, selv drage egen konklusion om, hvilken form for omsorg, der skal vises og udøves for eksempelvis lungecancerpatienten og hendes datter. I henhold til Løgstrup er fantasien i stand til at skabe rum for sygeplejerskens skønmæssighedstagen i situationen, og det er således fantasien, som skaber rum til disse overvejelser samt begrundelse for sygeplejerskens handling^[51].

Skønmæssighedstagen gør, at sygeplejersken kan indleve sig i den berørte patients tilstand. Ikke kun naturvidenskabeligt, men også ontologisk. Derved bliver idealet for sygeplejersken ikke kun at tage hensyn til patienten, men også at tage hensyn på sådanne måde, at hun berører patienten på eksistentiel vis. Sygeplejerskens rolle bliver at idealisere sine karaktertræk, sine dyder, således, at de er medvirkende til, at både sygeplejersken selv, samt patienten, fungerer godt som menneske. Det vil sige, at sygeplejeren i situationen skal vurdere situationens middelvej og derved undgå at underdrive situationen samt overdrivelse af situationen. Jeg vil påpege, at for lidt omsorg i situationen betyder, at sygeplejersken udviser ligegyldighed og måske endda hensynsløshed over for patienten, mens for meget omsorg betyder, at sygeplejersken omklammer patienten på sådanne måde, at patienten ikke er i stand til at tage vare for sig selv. Man kan sige, at selvfølgelig har sygeplejersken en pligt til at sikre patientens bedste, men hun må ikke binde sig til den rene deontologiske struktur, da sygeplejersken således nok vil have pligt til at udføre sin gerning, men hun vil ikke nødvendigvis være forpligtet til at ville det bedste for den enkelte patient. Dette gør, at ved pligtetikken lader det til, at sygeplejersken i situationen ofte kan ende i en situation, eksempelvis ved spørgsmålet om lungecancerpatientens autonomi og valg, hvor hun tager ansvar fra patienten og ikke for patienten. Vurderer pligtetikeren, at den vedrørte patient ikke er autonom, så gives der ikke noget svar på, hvordan sygeplejersken skal varetage sin forpligtelse over for patienten, da hun ganske vidst lever op til sin pligt, men derved fraskrives også det faktum, at der bør tages ansvar for patientens eget bedste - ikke fra patienten - og til et objektivt bedste. Til gengæld kan vi sige, at Løgstrups etik ej heller tilbyder nogen direkte specifik løsning til det etiske dilemma, som den professionelle møder i givende tilfælde. Dog gives der et fingerpeg om, hvor en eventuel løsning findes; ved brug af skøn og vurdering af den specifikke situation skal sygeplejersken vurdere beskaffenheden heraf og derefter tage stilling til, hvad der er bedst for patienten og eventuelt vedkommendes pårørende.

I behandlingen af lungecancerpatienten kan vi i forlængelse af denne skildring spørge, hvilken behandling og pleje er bedst for patienten? Den pligtetiske, hvori vi udelukkende forholder os til at respektere patientens autonomi (hvis denne er til stede), undgå skade samt at behandle patienten

retfærdigt, altså som et mål-i-sig-selv som gør, at vi i dette specifikke tilfælde ikke er i stand til at forstå den berørte patients eksistentielle tilstand – den pligtetiske sygeplejerske er nemlig ikke i stand til at se sig selv i patientens sted, fordi hun nøgternt handler ud fra de førnævnte principper og derved ser sig blind for øvrige behandlings muligheder. Indbefatter sygeplejersken til gengæld idealetik, og ikke nødvendigvis udelukker pligtetikken, eller den konsekvensbetragtende etik, kan vi, hvis vi følger Løgstrups ontologiske perspektiv, give et grundlag for, at sygeplejersken kan værne og ikke mindst fremme patientens bedste, hvori det måske vigtigste fundament i sygeplejen indgår; et medmenneskeligt ansvar, hvori der er plads til forståelse for, og af, patientens situation. Derved lever sygeplejersken op til både det professionsetiske krav om at *”...erkende og vedkende sig det etiske faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger^[52]”* samt *”...arbejde for at patienten bevarer sin værdighed og integritet^[53]”*. Den professionelle erkender det faglige ansvar ved at forstå patientens sygdomsforløb fra et professionelt perspektiv – derved værnes der om de faglige omstændigheder. Derudover kan vedkommende værne om det personlige ansvar, hun har over for den enkelte patient. Dette må forekomme i professionelt henseende, men i og med, at der gøres brug af egne skøn og vurderinger i situationen, åbner sygeplejersken op for et bredere perspektiv, som gør, at sygeplejersken ikke kun sikrer forholdet mellem sygeplejersken og professionen, men også sikrer at leve op til de retningslinjer, som er forskrevet mellem sygeplejersken og patienten. At sikre sammenspillet mellem disse poler er at handle med professionel integritet, hvorved den professionelle anerkender det faglige samt etiske ansvar, vedkommende har over for sygeplejepraksissen. Denne skildring mellem sygeplejeetikken er ikke ny; allerede for cirka 2400 år siden åbnede den græske mastodont filosof Platon op for spørgsmålet om en nødvendighed af en idealtilgang funderet i den enkelte karakters professionelle målsætning og gerning; har vi ikke det nødvendige ideal etiske perspektiv med, kan den professionelle praksis ikke leve op til sit eget ideal. Platon stiller således spørgsmålet; hvilke værdier skal kendetegne sygeplejen – derved hvilke holdninger og principper den professionelle (sygeplejerske, læge osv) skal repræsentere^[54]. Platon skildrer i det følgende mellem den frie og den ufrie læge. I denne analyses optik skal den ufrie læge anses som repræsentant for en endimensionel etik, hvori der ikke gives plads til omsorg, idealer samt øvrige perspektiver, mens den frie læge repræsenterer den professionelle, som giver plads til et eksistentielt og karakterpræget syn på patienten og sygdomsforløbet^[55];

”Den frie læge derimod behandler i reglen de frie menneskers sygdomme og tager sig af dem, og han undersøger dem fra grunden og systematisk og forhandler med patienten selv og hans venner, og derved lærer han også selv noget af de syge, og desuden lærer han selve patienten noget, så godt han da kan, og han giver ham ikke nogen ordination, før han mere eller mindre har

fået hans samtykke dertil, og når han så ved stadigt at anvende gode ord har fået patienten gjort føjelig, forsøger han at skaffe ham fuldstændig helbredelse. Skal vi så foretrække, at en læge anvender den ene eller den anden helbredelsesmetode? ^[56]

I og med den frie læge, eller sygeplejerske, formår at sætte sig ind i patientens livsforståelse og situation, anerkender den professionelle patienten som et individ, som har valgt at vælge sit eget liv. Det vil sige, at patienten anerkendes som det specifikke individ, som det nu engang er – som et mål-i-sig-selv. Dette kan både den kantianske pligtetik og Løgstrups ontologiske etik blive enige om. Lad os antage, at lungecancerpatienten lever op til de førnævnte opstillede krav for autonomi; *intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse* som blev opstillet af Beauchamp. Grundlaget for dette er det kantianske Kategoriske Imperativ, hvori den enkelte besidder evnen til at bakke op om én objektiv gyldig moral regel. Hvis patienten ikke lever op til dette, så krænker vedkommende sig selv og sin værdighed. Problemet er, at der derfor ikke bliver plads til et menneskeligt ideal om personlig autonomi, men kun moralsk autonomi. Den ufrie læge, som anser patienten som én blandt mange, formår ikke at medtage den enkelte patient, men kun kategorisere patienten som én blandt mange. Patienten må og skal altid behandles som mål-i-sig-selv, som pligtetikken fordrer, men dette må nødvendigvis også betyde, at den enkelte netop ikke kan behandles på måden, som den ufrie læge praktiserer. Den frie læge, og sygeplejerske, formår til gengæld at komme ud over denne problematik ved at anerkende, at patienten, i kraft af sin personlige autonomi, det vil sige selvbestemmelse, formår at træffe valg, som begrundes i idealer og livsanskuelser. Derved kan den frie læge og sygeplejerske behandle og pleje lungecancer patienten på sådanne måde, at hun ikke kun yder klinisk behandling af patienten, men også formår at vise omsorg, respekt og forståelse for patientens situation ved inddragelse af patientens integrerede selv og dertilhørende præference system. Det vil sige, at den professionelle ikke kun bekymrer sig om selve det faktum, at patienten har lungecancer, og hvorledes dette specifikt kan behandles, men også det faktum, at hun rent faktisk har nogle livsanskuelser og værdier, som der må værnes om. Derved anses patienten, som sandsynligvis fra et lægeligt synspunkt træffer et dårligt valg, stadig som autonom, hvis ønsker man nødvendigvis må respektere, så længe at hun er autonom, og derved må man anerkende hendes valg. Således bliver patienten betragtet som et ganske unikt individ, som har skabt sig et liv på egne værdier og grundlag – værdier og grundlag som står til grunde for patientens beslutning. Således kan vi konkludere, at den frie læge og sygeplejerske kan vise omsorg i og med, at de forstår og anerkender patientens liv i et større holistisk sammenhæng ^[57].

Kritik af det ontologiske omsorgsideal

Det skal ikke stå til diskussion, at Løgstrups etik giver grundlag for, at omsorg er en nødvendighed i sygeplejens etiske univers. Den frie læge – og sygeplejerske – er i stand til at forstå patienten; ikke kun sygdommens patologiske anatomi, men også den lidelse, som sygdom kan forvolde den berørte patient og omgangskreds. Men dermed ikke sagt, at omsorg er den grundlæggende faktor i forholdet mellem patienten og den udøvede etik i sygeplejen; jeg vil i det følgende for argumentere, at det ontologiske omsorgsideals mangler et grundlæggende fundament, som gør, at dette perspektiv ikke kan positioneres på lige fod med hverken det kantianske autonomibegreb og pligten, som heraf følger, eller det konsekvensbetragende etiske grundlag, hvori selvbestemmelsens brede autonomibegreb har sit udspring.

Det første kritiske spørgsmål vi kan rette mod det ontologiske omsorgsideal er, hvorledes, hvis vi '*blot*' skal anvende skønmæssighedstagen i situationen, kan vi undgå at handle vilkårligt; det vil sige at handle efter de naturlige tilbøjeligheder? Må der ikke nødvendigvis være en højere kategorisk instans, som sikrer, at vi netop ikke blot handler efter antagelser men efter en gyldig almen lov, det Kategoriske Imperativ. Problematikken for omsorgsidealet er, at vi, ifølge Løgstrup, skal bruge fantasien til at sætte os i den andens sted. Men dette betyder også, at de valg vi foretager, ikke kan være moralsk værdifulde, fordi begrundelsen er foretaget i vores antagelser, meninger, holdninger osv. Begrebsmæssigt kan vi således kategorisere dette under det filosofiske begreb *doxa*, hvor sygeplejersken blot antager sin position og holdning for at være begrundet i en viden om patienten. Dette er dog rent illusion, da positionen mangler det epistemiske indhold, som gør, at man kan sikre patienten det bedste. Dette indhold finder vi netop ved Kants Kategoriske Imperativ, som er i stand til at beskytte patienten mod paternalistisk formynderi og omsorgsmæssig omklamrenhed. Den kritiske ideal og omsorgsetikker vil sandsynligvis sætte spørgsmålstejn ved, hvorvidt det Kategoriske Imperativ altid skal følges, da der kan opstå situationer, hvor dette ikke lader til at være tilstrækkeligt. Hertil må svaret lyde, at sygeplejersken har et ansvar over for patienten, hvilket ikke står til diskussion, men lever patienten op til de kriterier, som udgør autonomiens minimumskriterium, så kan man ikke retfærdiggøre, at patientens rettighed krænktes, da sådanne krænkelse netop vil være at påføre patienten et uønsket gode, og derved bliver den omklamrende omsorg til et uønsket paternalistisk indgreb – på trods af at patienten rationelt har argumenteret for, at vedkommende ikke ønsker dette. Derved modstrider sådanne sygeplejerske tanken om patientens, og det enkelte menneskes, ret til autonomi, da man

ikke anerkender patientens evne til at tænke og handle selv, og derved respekteres fordringen om respekt for autonomien ikke. Den negligeres til gengæld til ikke eksisterende, og patienten bliver reduceret til et middel og ikke et mål.

Ydermere kan vi stille os kritiske i forhold til, hvorvidt det ontologiske omsorgsideal kan sikre patientens ret til informeret samtykke. Hvorledes kan denne etiske position sikre et aftaleforhold, hvor patienten får de oplysninger, som er nødvendige for at træffe et velinformeret valg? Antager man blot, hvad der er bedst for patienten ved at forestille sig at være i patientens sted, som vi må, som belyst tidligere, *fantasere os til, hvordan vi vil ønske der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted*, men kritikken her af skal lyde, at dette ikke er nok til at retfærdiggøre antagelsen af, at patienten har modtaget de informationer, vedkommende skal bruge samt at patientens valg respekteres. Derimod kan den konsekvensbetragtende etik sikre patienten samtykke på et velbegrundet grundlag, da etikken, som tidligere vist, opstiller krav til patienten samt sygeplejersken. Patienten skal træffe refleksive valg begrundet gennem kritisk evaluering, af hvad vedkommendes individuelle forståelse af det gode er, og dette skal nødvendigvis stemme overens med patientens valg af præferencer. Ved hjælp af dette kan patienten udøve en acceptable sum af selvbestemmelse, således at valget må respekteres. Dette sker i kraft af, at patienten har forståelse for sin situation og har overvejet og kan begrunde, sine valg. I forlængelse af dette skal sygeplejersken sørge for, at patienten modtager den korrekte information, således at patientens valg træffes på et sikkert grundlag. Patienten beskyttes således ved indhentet informeret samtykke i kraft af sin egen evne til at forstå situationen og sine præferencer samt sygeplejerskens professionelle videregivelse af information. Derved sikres patientens selvbestemmelsesret samt retten til frasigelse på et sikkert teoretisk grundlag. Dette grundlag adskiller sig markant fra det ontologiske perspektiv, hvori vi ikke kan vide os sikre på patientens ønske, men blot antage, hvad der er bedst for vedkommende.

Kritikken af det ontologiske ideal og omsorg skal dog ikke forstås som en udelukkelse af anvendelse af omsorg i sygeplejen. Tværtimod. Men den skal sikre, at sygeplejersken ikke formynder paternalisme eller omklamrende omsorg over for patienten og derved tilsidesætter patientens rettigheder, behov osv. for en bedrevenhed af, hvad der ville være bedst for patienten. Derudover sikre den kantianske etik at det enkelte menneske altid behandles med værdighed og som mål-i-sig-selv. Dette er nødvendigt for at institutioner og praksisser i dagligdagen ikke lader normer blive til værdi. For bliver doxa-normer, det vil sige, normer som man antager for at være korrekte uden sikkert grundlag, hverdagspraksis, så kan de principper, som henholdsvis pligtetikken og den konsekvensbetragtende etik sikre, blive nedgraderet i forhold til det ontologiske omsorgs perspektiv i den hierarkiske struktur. I

tilfælde af sådanne hierarkisk strukturdegradering kan vi forestille os en praksis, hvorved eksempelvis omklamrende behandling af patienten bliver dagligdag, og derved vil behandlingen og plejen af patienten blive skæmmet af misologi, hvorved kun den blotte antagelse af, hvad der er korrekt for patienten, og ikke den begrundede, vil blive det førende princip, hvorpå sygeplejersken foretager sine valg. Og foretages behandlingen og plejen af patienten uden nogen fornuftmæssig indsigt, så krænker dette, ubetinget, både patienten og sygeplejersken. Patienten krænkes, da vedkommende ikke gives plads til at udfolde sine egne ønsker og behov – i kraft af at autonomien og selvbestemmelsen ikke inddrages i en omklamrende omsorgs pleje – og sygeplejersken krænker sig selv, fordi hun ikke lever op til sin professionelle professions krav.

VÆRK III • AFSNIT 12

De Sygeplejeetiske Retningslinjer – Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis

Vi har på nuværende tidspunkt analyseret og diskuteret tre etiske positioner, som giver den professionelle sygeplejerske mulighed for at begrunde sine valg og handlinger i henhold til vurderingen af, hvorvidt en patient er autonom eller ej, samt hvorvidt den autonomes valg altid skal respekteres, eller om der kan forekomme tilfælde, hvor dette princip må underkendes. Sygeplejerskens profession gør, at hun i sin dagligdag ofte møder etiske spørgsmål, som kommer til udtryk ved mødet mellem patienter, kollegaer, institutionspraksis osv. Netop derfor er det også nødvendigt for sygeplejersken at vurdere sine etiske valg og handlinger, fordi disse valg ofte vil være i konflikt med de øvrige berørtes vurderinger og eventuelle handlinger. Principperne, som analysen har anvendt, er brugbare til dette, da de giver sygeplejersken et grundlag for at argumentere for sine etiske vurderinger. Det vil sige, at der er en klar rød tråd mellem sygeplejerskens praksisstandarder, som er at forefinde ved de Sygeplejeetiske Retningslinjer og de principper, som står til grundlag for disse. Principperne er grundlæggende fæstnet i de mål og værdier, som identificerer sygeplejerskens ansvarsområde. Disse omhandler; *”Det enkelte menneskes værdighed, værdien af medmenneskeligt ansvar og omsorg samt værdien af professionel integritet^[58].”* Dette er således de grundlæggende professionelle værdier i sygeplejen, men for at udøve dem, må sygeplejersken følge de principper, som gør dette muligt.

Det, som vi skal være opmærksomme på, er, at principperne kan, i visse situationer, være modstridende og konfliktfulde; eksempelvis kan det pligtetiske princip om at respektere autonomi være i et konfliktforhold med

det konsekvensbetragtende princip om at lindre lidelse. Derudover kan principper indbyrdes obstruere for hinanden. Eksempelvis kan det konsekvensbetragtende princip om at forebygge negativ sundhed være i konflikt med princippet om at lindre lidelse. Dette betyder, at den Professionsetiske Beslutningsmodel, som vi har anvendt analysen igennem, ikke kan anvendes som en facitliste, hvori det ubetingede korrekte svar altid vil være at finde. Beslutningsmodellen er et redskab til at manøvrere gennem de etiske konflikter, som sygeplejersken møder i sit professionelle erhverv. Med denne beslutningsmodel bliver den professionelle i stand til at argumentere for sin etiske beslutningstagen, og position og derved kan sygeplejersken retfærdigvis leve op til den grundlæggende værdi af professionel integritet, hvorved den professionelle tager ansvar for sin handling.

Analysen igennem har vi taget udgangspunkt i det filosofiske begreb autonomi, og hvorledes den professionelle sygeplejerske skal være i stand til at vurdere og forholde sig til, hvorvidt en patient er autonom, og hvorledes hun kan pleje og behandle patienten med værdighed og integritet. Vi har bevæget os fra filosofisk teori til en praksisorienteret anvendelse af autonomi og etik i sygeplejen. I dette findes dog to problematikker; spørgsmålet om pleje omhandler ikke altid, måske nærmest langtfra, spørgsmålet om, hvorvidt en patient er autonom eller ej og dernæst, at sygeplejersken i sit erhverv ikke har tidsmæssige ressourcer til at bearbejde patientens sygdomsforløb og forhold på et rent filosofiteoretisk grundlag. For at løse disse problematikker må sygeplejersken vurdere, hvilken værdi hun vægter højest i den konkrete situation; at Freud vælger ikke at ville modtage morfin, er et eksempel på dette. Den professionelle vurderer, at den korrekte behandling og pleje af Freud er ikke at lindre hans lidelse men at sikre, at han er i stand til at tænke klart på trods af ulidelige smerter. Det vil sige, at værdien af respekt for autonomi vurderes til at være af højere karakter end princippet om at lindre lidelse. I teori har vi anvendt Kant og Ekstrom til at komme frem til dette resultat. Men sygeplejersken har ikke disse muligheder, men skal stadig være i stand til at redegøre for sine etiske valg. Dertil kan den professionelle anvende Den Professionsetiske Beslutningsmodel, hvori den professionelle kan bevæge sig fra et etisk dilemma til det konkrete valg samt handling. Hertil opstilles følgende punkter som fokuserer på handlinger der;

- *Respektere klientens autonomi*
- *Ikke volder skader, modvirker eller hindrer skade*
- *Fremmer klientens bedste interesse*
- *Behandler klienten retfærdigt og fremmer bestemte fordelinger*
- *Overholder love, professionsetik mv.*^[59]

Disse punkter skal altid medtænkes, når man skal forsøge at løse et etisk dilemma i henhold til etik i sygeplejen. Indledningsvis skal dilemmaet

præciseres; i dette skal sygeplejersken identificere de etiske principper, som er relevante for den etiske konflikt. Indlæser vi den Professionsetiske Beslutningsmodel i dette, betyder det, at vi skal identificere de konkrete formuleringer af relevante principper. Eksempelvis en konflikt mellem Respekt for autonomi og princippet om at lindre lidelse. Efterfølgende skal også de berørte parter noteres; familie, venner, institutionen mm – det vil sige de parter, som berøres af det etiske valg. I forlængelse af dette må den professionelle også være i stand til at vurdere de realistiske valgmuligheder.

Analysen og diskussionen igennem har vi understreget nødvendigheden af at begrunde valg og handlinger; dette skyldes, at vi skal være i stand til at prioritere værdier på et rationelt grundlag og være i stand til at skelne værdierne fra hinanden. Man må i behandlingen og plejen opstille et hierarkisk system, hvori man vurderer, hvilken værdi er af højeste karakter og hvilke er mindre nødvendige i denne specifikke behandling. Er der stadig tvivl, om hvilke værdier som er af højest karakter, må en dybere etisk analyse påbegyndes. I denne etiske analyse skal den professionelle identificere valgmuligheder og give etiske grunde for at vælge mulighed-X frem for mulighed-Y^[60]. Næste skridt er afvejning, hvori grundene, både for og imod, alle tages i betragtning for derefter at vælge det valg, som er mest forsvarligt. Endelig skal sygeplejersken rådføre sig med andre; det vil sige at fremlægge sine vurderinger for andre, således at hun eventuelt kan få råd og vejledning af andre professionelle. Efterfølgende foretages det endelige valg; hvori sygeplejersken, i så fald denne procedure er fulgt, gerne skulle være i stand til at træffe et etisk korrekt og værdifuldt valg.

De Sygeplejeetiske Retningslinjers grundlag er at sætte værdien af det enkelte menneske i centrum – dog uden at forglemme, at dette unikke menneske lever i sammenhæng med sine omgivelser. Der er således tale om tillid til og respekt for det enkelte menneskes valg og ønsker. Og det er i denne sammenhæng at retningslinjerne bistår som en assistance til, at sygeplejersken kan udvikle og udøve sygepleje mod et menneske, som netop har behov for sådanne pleje. Ved hjælp af retningslinjerne medvirkes der til, at etiske diskussioner samt overvejelser belyses. Dertil er retningslinjerne i stand til at begrunde sygeplejerskens etiske valg samt i forlængelse af dette bidrage til fremme af sygeplejerskens dømmekraft i situationen, hvorved den faglige professionalisme udvikles^[61]. De Sygeplejeetiske Retningslinjer er ikke kun omhandlende forholdet mellem sygeplejersken og patienten, men også mellem sygeplejersken og professionen samt sygeplejersken og samfundet. Dog understreges det, at De Sygeplejeetiske Retningslinjer ikke er prioriteret i noget hierarkisk værdisystem; dette betyder, at vi ikke kategorisk kan konkludere, at en paragraf i retningslinjerne er mere værd end én anden. For at vurdere, hvilken der er af højest værdi i det enkelte etiske dilemma, kræver det en mere uddybende begrundelse af sygeplejersken.

Afslutningsvis kan vi konkludere, at sygeplejerskens ansvarsområde grundlæggende består af fire facetter; *fremme sundhed, forebygge sygdom, genoprette sundhed og lindre lidelse*. Derudover sætter sygeplejerskens praksis hende i forhold til; *profession, patienten, medarbejder og samfundet* samt de fire grundværdier; *Værdien af det enkelte menneskes værdighed, værdien af omsorg, værdien af sundhed samt værdien af professionel integritet*^[62].

VÆRK III • AFSNIT 13

Case analyse

Vi har nu analyseret og diskuteret os frem til, hvilke kriterier lungecancerpatienten skal besidde for at blive kategoriseret som autonom. Hertil må vi skelne mellem det autonome valg og det autonome menneske. De Sygeplejeetiske Retningslinjer understreger, at patienten har ret til selvbestemmelse og derved også retten til at frasige sig denne. Men retningslinjerne giver ikke noget svar på, ej heller assistance til, hvornår patienten er autonom og selvbestemmende. Via den moralske autonomis fordring om respekten for menneskets værdighed kan vi sikre, at patienten ikke krænkes eller lignende. Men i tilfældet med lungecancerpatienten lader det til, at patienten ikke umiddelbart lever op til de krav, som det kantianske autonomi begreb forlanger af fornuftsvæsnen. Derfor må vi belyse patientens forhold under andre betingelser. Som tidligere nævnt lader det til, at patienten fungerer, til en hvis grad, i hverdagen, hvilket betyder, at hun også er i stand til at træffe autonome valg. Dog ikke når det kommer til afgørende valg for hendes sygdomsforløb og de beslutninger, som nødvendigvis må træffes. Her lader det til, at hun fornægter de omstændigheder, hun er underlagt i forløbet og ikke er i stand til at træffe et autonomt valg og således heller ikke i stand til at besidde acceptable grad af selvbestemmelse, når afgørende valg skal træffes.

Spørgsmålet er nu, hvorledes sygeplejersken skal håndtere et dilemma som dette i praksis? Hertil må hun gøre brug af de tre etiske teorier, som vi løbende har analyseret og diskuteret specialet igennem. Derudover skal hun inddrage de Sygeplejeetiske Retningslinjer, som giver sygeplejersken et mere praksisorienteret grundlag for sit valg af behandling og pleje vedrørende lungecancerpatienten.

VÆRK III • AFSNIT 14

Identifikation

Lad os indledningsvis gå systematisk til værks med casen og identificere de etiske principper, som er relevante for dilemmaet. Det første, vi må spørge om, findes i pligtetikens sfære; er patienten autonom? Beauchamp opstillede,

i kantiansk optik, et minimumskriterium for autonomi; *intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse*. I dette skal sygeplejersken vurdere, hvorvidt patienten lever op til minimumskriteriet ved at analysere patientens evne til at besidde autonomi, hvilket vil blive belyst i den *etiske analyse*. Men det er klart, at der allerede på nuværende tidspunkt er forhold, som gør det svært for sygeplejersken at få svar på det konkrete spørgsmål om, hvorvidt patienten er autonom. Det lader det til, at hun i valget ikke er autonom, men omvendt har vi belyst, at lungecancerpatienten, når valget ikke omhandler hendes sygdomsforløb, er i stand til at fungere i hverdagspraksis, så vidt muligt med lungecancer in mente, og derved kan det forekomme problematisk at kategorisere hende som ikke-autonom. I forlængelse af denne problematik må sygeplejersken derfor inddrage det konsekvensbetragende perspektiv. Dette perspektiv inddrages med henblik på at hjælpe patienten til at fremme hendes selvbestemmelsesevne således, at patienten på sigt kan være i stand til at træffe et valg, som begrundes i hendes værdier og livsanskuelser. Det vil sige, et valg som udspringer fra hendes præferencesystem. Er lungecancerpatienten ikke i stand til dette, kan det medføre, at hun foretager et valg, som ikke er autonomt, og derved krænker hun sin egen værdighed, hvilket sygeplejersken vil være medvirkende til, da hun ikke vil leve op til praksisstandarden, som omhandler, at patienten netop bevarer sin værdighed og integritet.

Vi kan på nuværende tidspunkt i proceduren opstille de praksisstandarder, som sygeplejersken skal inddrage i sine overvejelser angående pleje og behandling af lungecancerpatienten.

- *Sygeplejersken skal respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge selvbestemmelsesretten (§2.3).*
- *Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet (§2.4).*

Vi har nu identificeret de etiske principper, som er relevant for det etiske dilemma; sygeplejersken skal vurdere, hvorvidt patientens valg er autonomt, hvilket kan stå i konflikt med princippet om at behandle patienten med værdighed og integritet. Af redskaber kan sygeplejersken benytte sig af pligtetikken fordring om at respektere patientens autonomi, eller hun kan forsøge at bidrage til, at patientens selvbestemmelse fremmes. Dette kræver dog, at patientens ønskede valg tilsidesættes, således at sygeplejersken kan benytte sig af det konsekvensbetragende princip om at fremme selvbestemmelse.

Efterfølgende skal de berørte parter, det vil sige de parter, som berøres af den valgte behandling og pleje, identificeres. Her er der tale om lungecancerpatienten selv, hendes datter, to sygeplejersker samt det palliative team. Dog vil jeg understrege, at da fokus i analysen er på forholdet mellem

autonomi og sygepleje, vil kun de facetter, som er relevante for dette forhold, inddrages. Af professionsetiske principper inddrages det pligtetiske facet; respekt for autonomi mens vi i det konsekvensbetragtende perspektiv inddrager fremme selvbestemmelse.

Spørgsmålet er nu, hvilke realistiske muligheder sygeplejerskerne har at vælge imellem; de kan vælge at vurdere lungecancerpatienten som autonom og derved respektere patientens ret til autonomi, hvori de af pligt ikke kan krænke vedkommende, da dette ikke blot vil være manglende respekt for hendes autonomi, men også en krænkelse af hendes værdighed, da patientens ønske ikke stemmer overens med den professionelle vurdering. Dette betyder, at den positive effekt af paternalistisk indgriben er, at patientens lidelse kan lindres, hvilket er et konsekvensbetragtende princip, som er værdifuldt i denne henseende, da kvinden, på sigt i forløbet, sandsynligvis kan blive i stand til at træffe et rationelt og velbegrundet valg. Den negative konsekvens ved indgriben er, at patienten sandsynligvis vil føle sig stærkt krænket, da hendes valg og ønsker ikke imødekommes af sygeplejerskerne. Men vurderes kvinden til at være autonom, bliver den positive konsekvens heraf, at hun er i sin frie ret til at træffe sit eget valg og derved selv tage ansvar for konsekvensen af sit valg. Hun kan således ikke terminalerklæres, medmindre at hun har indgået et samtykke, hvori hun vælger at frasige sig selvbestemmelsesretten. Og for at hun kan være i stand til dette, kræver det, at hun er autonom.

Vi har nu identificeret de forhold, som gør sig gældende i den omhandlende beslutningsproces. I det følgende vil vi analysere og diskutere de etiske forhold, som gør sig gældende i forhold til denne case og vise, hvorledes de to sygeplejersker skal være i stand til at begrunde sine faglige valg på et nødvendigt etisk grundlag.

VÆRK III • AFSNIT 15

Etisk analyse

Det etiske dilemma for sygeplejerskerne opstår ved, hvorvidt de skal respektere lungecancerpatientens valg, eller om de skal forsøge at påbegynde en proces, hvori patientens autonomi over en periode tilsidesættes for til gengæld på sigt at være i stand til at træffe et velbegrundet valg. Vi har i analysen og diskussionen vurderet, at patienten ikke er autonom, da hun ikke lever op til Beauchamps kantianske minimumskriterium for autonomi. På den anden side har vi at gøre med en kvinde, som tilsyneladende fungerer; der er ikke noget, som tyder på, at hun ikke kan tage vare på sig selv, så længe denne varetagelse ikke omhandler valg, som har at gøre med hendes sygdomsforløb. Ydermere bekræftes dette ved datterens tilstedeværelse. Datterens tilstedeværelse og de informationer vi har om hende udtrykker heller ikke nogen former for umiddelbare tegn på manglende funktionalitet rent

adfærdsmæssigt, bortset fra benægtelsen af nødvendigheden af terminalerklæring af hendes mor.

Sygeplejerskerne står nu med to valgmuligheder; 1) at kategorisere patienten som autonom, da der ikke er noget som tyder på, at hun, umiddelbart, ikke er i stand til at træffe valg eller 2) vælge at analysere og vurdere patienten på et rationelt og begrundet grundlag, hvor de belyser de opstillede kriterier, som autonomien begrundes i. Første valgmulighed kan ikke retfærdiggøres; for vurderer sygeplejerskerne ikke patienten, lever de ikke op til det professionsetiske ansvar, at *"...erkende og vedkende sig det etiske faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger"*^[63]. Vurderer sygeplejerskerne, at lungecancerpatienten er autonom og derved i stand til at træffe et rationelt valg, kan man argumentere for at de allerede besidder en på forhåndstaget beslutning i henhold til, hvad der er bedst for lungecancerpatienten; at respektere hendes valg og ønsker. Men gør de dette, handler de ikke professionelt, fordi de vælger netop ikke at handle, da de endnu ikke har analyseret patientens autonomiforhold. Dette betyder, at sygeplejerskerne ikke har agtelse for pligten i og med, at de i tilfælde af ikke at have analyseret patienten, ikke lever op til de professionelle standarder, som forventes af dem.

Men sygeplejerskerne skal leve op til kravet om faglig og personlig ansvar for deres etiske valg og handlinger. Det vil sige professionelt at vurdere patienten og stille spørgsmålet; er patienten bevidst om sit valg? Er hendes valg om ikke at ville terminalerklæres et valg, som er truffet på et rationelt og autonomt grundlag, eller er der tale om en fornægtelse af situationen, hvor valget ikke begrundes, men udelukkende er et udtryk for tilbøjeligheder? For at finde svar på dette, kan vi spørge, om kvinden lever op til Beauchamps minimumskriterium, og om hun derved er bevidst om sit valg eller ej. De to ansvarshavende sygeplejersker skal vurdere, hvorvidt lungecancerpatienten besidder basal forståelse for hendes situation; er hun klar over, at den situation, hun *vælger* at sætte sig selv i, betyder, at hun udsættes for ulidelige smerter? Smerter som sandsynligvis ville reduceres betydeligt, hvis hun lod sig benytte af muligheden af et palliativ team. Patienten skal være klar over konsekvensen af dette valg. Dertil lader det, at hun ikke begrunder sit valg på samme måde, som eksempelvis Freud gjorde det, da han valgte ikke at modtage morfin. I forlængelse af dette skal hun også besidde en fuld intention, hvori der er kontinuerlig sammenhæng mellem de tanker og ønsker, hun gør sig i henhold til hendes intention. Derudover skal kvinden se sig fri fra kontrollerende omstændigheder. I vurderingen af patientens valg lader det til, at hun ikke lever op til autonomiens minimumskriterium; vi kan stille spørgsmålstejn ved, hvorvidt hun har forståelse for situationen, hvilket det lader til, hun ikke har, da hun ikke vil høre på, hvad de ansvarlige har at tilbyde og afviser, ubegrundet, deres behandlings- og pleje tilbud. Derved kan

vi i pligtetisk henseende konkludere, at kvinden ikke er autonom. Det skal dog noteres, at under den pligtetiske facit - *behandle retfærdigt* - skal man stadig behandle kvinden efter de behov, som hun nu engang har. Sygeplejerskerne kan ikke retfærdiggøre en indgriben, hvorved de allerede på forhånd besidder en masse antagelser om, hvad patienten har behov for. Behandlingen og plejen skal derfor tilpasses den enkelte patient. Således kan et indgreb retfærdiggøres, men sygeplejerskerne skal stadig respektere patientens værdighed og integritet. Dog lader det til, at dette ikke kan lade sig gøre udelukkende ved brug af pligtetikken principper. Derfor bliver kvindens evne til selvbestemmelse omdrejningspunktet for pleje og behandlingen. Ved at konkludere patienten som ikke-autonom kan sygeplejerskerne ophæve den konflikt, som opstod mellem praksisstandarderne §2.3 og §2.4 angående henholdsvis at respektere kvindens autonomi og ret til selvbestemmelse samt at sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet. Derved er sygeplejerskerne i stand til at erkende samt at vedkende sig det etiske ansvar, de besidder i kraft af deres profession samtidig med, at de har formået at anvende en kritiskstillingstagen i henhold til deres profession samt mod og ikke mindst omtanke. Dog er det etiske dilemma ikke løst; sygeplejerskerne har endnu ikke handlet og ageret i situationen, men blot analyseret den. Her bliver Ekstroms kohærensteori aktuel for behandlingen og plejen af patienten. Patienten skal, for at vi kan kategorisere hende som et autonomt individ med dertilhørende personlig autonomi, være i stand til besidde acceptable og fyldestgørende kontrol over det liv, som hun ønsker at leve. Dertil må sygeplejerskerne sørge for, via en pædagogisk tilgang, langsomt men sikkert, overlade patientens selvbestemmelse til den berørte part. Dette vil sige, at der er tale om en længere sigtet proces, hvor sygeplejersken kan være i stand til, at patienten kan bevare sin værdighed og integritet samtidig med, at sygeplejersken selv tager det etiske ansvar, hun har i kraft af sin profession ved at bidrage til fremme af patientens selvbestemmelse. Her er det sygeplejerskernes etiske opgave at vurdere patientens evne til at besidde alle fire facetter selvbestemmelsesbegrebet.

Det er dog værd at bemærke, at pligtetikken samt den konsekvensbetragende etik umiddelbart kan komme til at virke som kolde og kyniske etikker, hvor sygeplejerskerne ikke besidder andet end ligegyldighed overfor lungecancerpatienten. Pligtetikeren respekterer kun patientens autonomi i kraft af, at dette er hendes pligt, og den konsekvensbetragtende etik vurderer kun, hvad der er bedst for patienten ved at vurdere, hvilke konsekvenser som er bedst for patienten - selvfølgelig med vedkommendes præferencer og livsanskuelser inkluderet i betragtningen. Derfor må sygeplejerskerne inddrage et sidste perspektiv i bestræbelsen efter at opnå den bedste behandling og pleje. Dette er det ontologiske omsorgs perspektiv. Sygeplejerskerne kan her vælge, ikke kun i kraft af deres profession eller professionalismisme, men i kraft af deres egenskab som

mennesker, som besidder tilstedeværen, at anse patienten som et medmenneske på lige fod med dem selv. Mennesket, patient eller ej, kan ikke anskues som en isoleret genstand, men som et medmenneske, som er til stede blandt andre. Den frie sygeplejerske formår at leve op til dette; formår at inddrage de pligter og konsekvenser patienten. Gør sygeplejerskerne dette, formår de at undvige fra den ufrie sygeplejerskes stivende ideologi, hvori patienten altid nok er af absolut størrelse, men derved også altid i et distanceret forhold til sygeplejersken og øvrige professionelle, og det er her, at den hårfine grænse mellem pleje og omsorg let kan overskrides, og paternalisme bliver det overgreb, som sygeplejersken tyer til. Et overgreb som nødvendigvis altid skal undgås grundet den enkeltes ubetingede værdighed; et mål-i-sig-selv. Dermed ikke sagt at et paternalistisk indgreb overfor lungecancerpatienten ikke kan retfærdiggøres. Dette valg bliver netop retfærdiggjort i og med, at sygeplejerskerne tager det etiske ansvar i deres hånd og vurderer på et rationelt grundlag, at lungecancerpatienten ikke er autonom. Men de påtvinger ikke kvinden en bedrevidenhed, men derimod påtager de sig det ansvar, de har for patienten – et ansvar som ikke vil have været muligt, hvis de blot undlod at handle og derved antage, at lungecancerpatienten var autonom. Dette ville være en ubegrundet antagelse, som ikke er nogen patient værdig. Det professionelle, samt medmenneskelige, ansvar, betyder at sygeplejerskerne skal, for at være i stand til at medvirke til at lungecancerpatienten modtager tilpasset information i henhold til hendes livssituation, inddrage patientens kohærente præferencesystem i behandlingen og plejen.

Denne etiske ansvarlighed, som omsorg og idealer grundlægger, er bindeleddet mellem autonomi, etik og sygepleje. Men den er samtidig også en grænse, som ikke må overskrides uden begrundelse; dette skyldes, at professionen kræver en begrundelse for valget. Sygeplejersken skal altid begrunde sit valg af etiske værdier. Analysen af lungecancerpatienten understreger vigtigheden af dette; autonomi skal altid respekteres så længe, at patienten besidder egenskaben, men gør patienten ikke dette, må sygeplejersken tilsidesætte dette til fordel for princippet om værdighed og integritet. Sygeplejersken møder ustandseligt etiske konflikter og skal forholde sig til patienternes autonomi mm. Derfor skal sygeplejersken altid afveje sine grunde for derefter at tage i betragtning, hvilken der er mest forsvarlig at vælge. Herefter skal hun søge rådføring, hvor den etiske analyse præsenteres, og sygeplejersken skal være åben for råd og kritik fra sine kollegaer og medmennesker. Afslutningsvis træffes det etiske valg; et valg, hvor mennesket altid skal være et mål, aldrig et middel.

Konklusion

Specialet har belyst, hvilke forhold som gør sig gældende i henhold til autonomi, etik og sygepleje. Vi har analyseret og diskuteret, hvilke teoretiske baggrunde som danner grundlag for, at sygeplejersken kan løse etiske dilemmaer. Udgangspunktet har været autonomi; hvilke teoretiske baggrunde ligger bag dette begreb, og hvilke redskaber skal en sygeplejerske bruge for at vurdere, hvorvidt en patient er autonom. Specialet har taget sit udgangspunkt i et stærkt teoretisk fundament, i form af pligtetikken, og forsøgt at gøre etikken til en anvendelig praksis. Således har vi bevæget os fra pligtetik via konsekvensbetragtende etik til et ontologisk omsorgs ideal. Den praktiske anvendelse har vist, at vi via etiske teorier kan opstille en beslutningsmodel, hvorved sygeplejersken har mulighed for at opstille en række principper, som går i tråd med sygeplejefprofessionens praksisstandarder samt mål og værdier. I casen, omhandlende lungecancerpatienten og hendes autonomi samt selvbestemmelsesforhold, så vi den praktiske anvendelse af de etiske teorier, og hvordan de kan danne grundlag og begrundelse for sygeplejerskens evne til at foretage et etisk begrundet valg. Dog har vi samtidig set, at sygeplejersken ikke må gøre sin position til endimensionel, rent etisk, da dette kan resultere i, at sygeplejersken ser sig blind på øvrige etiske valgmuligheder.

Jeg har i specialet analyseret og diskuteret grundlaget for autonomi, og jeg har argumenteret for, at patienten altid skal behandles som et mål-i-sig-selv, både når patienten besidder autonomi, og når patienten ikke gør. Besidder patienten egenskaben, skal autonomien altid respekteres. Besidder patienten derimod ikke autonomi, skal vi nødvendigvis stadig behandle patienten som et mål-i-sig-selv. Dog inkluderer dette, at sygeplejersken skal hjælpe patienten med at besidde magt over egen tilværelse ved at fremme patientens evne til selvbestemmelse og de facetter, som hører herunder.

Det teoretiske grundlag for specialet har taget udgangspunkt i Immanuel Kants autonomibegreb. Dette begreb er et rent moralsk begreb, hvori fornuftsvæsenet har et objektivt a priori grundlag, som giver etikken et absolut udgangspunkt i og med, at det beskytter det enkelte menneske mod overgreb i kraft af, at fornuftsvæsenet altid er mål-i-sig-selv. Dette sikrer, at sygeplejersken altid har et sikkert fundament, som er hævet over antagelserne. Netop antagelser kan ikke bruges som grundlag for etik i sygeplejen, fordi de ikke besidder et sikkert epistemisk grundlag, og vi kan ved anvendelse af antagelse frygte, at etikken funderes i doxa. Dette betyder derfor, at vi i kantiansk optik må skelne mellem de moralske a priori principper samt formalier, som findes i moralloven og de *a posterioriske*, som findes i antagelsens tilbøjeligheder. En handling, som grundles i sidst nævnte, kan ikke

besidde moralsk værdi og kan derfor ikke betragtes som værdifuld i kantiansk perspektiv. Herved bliver fornuften en afgørende faktor i kantiansk optik, fordi den sikrer, at sygeplejersken handler efter en gyldig almen lov. Dette er grundfundamentet for al sygepleje, fordi det sikrer, at hvert enkelt unikt fornuftsvæsen altid og ubetinget sikres sin autonomi.

Analysen har dog vist, at Kants moralske autonomi umiddelbart er svært tilgængelig i praksis. Derfor har vi ved brug af Beauchamp opstillet et minimumskriterium for autonomi, som inkluderer *intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse*. Dette gør, at sygeplejersken besidder et praksisanvendeligt redskab til at vurdere, hvorvidt patienten er i stand til at foretage autonome valg. Således har analysen argumenteret for, at der ikke kun opstilles krav til sygeplejersken og hendes profession, men også at patienten er i stand til at opfylde kriterier, således at vi kan tale om en autonomi, som nødvendigvis skal respekteres. I forlængelse af det praksisanvendelige autonomibegreb opstillede vi casen med lungecancerpatienten, hvor vi diskuterede, hvorvidt den berørte kvinde var autonom eller ej. I sine overvejelser af dette skal sygeplejersken ikke kun forholde sig til spørgsmålet om autonomi, men også til principperne om at behandle patienten retfærdigt og undgå skade. Hertil skal sygeplejersken medvirke, til at patienten modtager og forstår den information, som formidles i henhold til De Sygeplejeetiske Retningslinjer §2.2 samt den information, som patienten modtager, tilpasses patientens livssituation. Beauchamps minimumskriterium kan begrunde, hvorfor patienten ikke er autonom, og at vi derfor har behov for en svag paternalisme; ikke en påførelse af et gode, men en afværgelse af et onde. Men vi må dog påpege, at hvorledes vi skal være i stand til at afværge et onde, kan pligtetikken ikke svare på. Den henholder sig udelukkende til pligten og deraf også en kritik af etikken. Den beskytter og sikrer patientens rettigheder, men den er ikke i stand til at tilbyde en facet, hvor vi kan hjælpe patienten, da dette vil være et konsekvensbetragende perspektiv. Men i henhold til pligtetikken kan der ved denne facet ikke være tale om etisk handlen af værdifuld moralsk karakter, fordi vi bevæger os væk fra fornuften og pligten og i stedet fokuserer på konsekvensen. Men i og med moralen ikke kan finde værdi i konsekvensen af handlingen, kan pligtetikken ikke assistere patienten i henhold til fremme af selvbestemmelse.

Således har vi i analysen diskuteret behovet for en autonomi definition, som ikke begrundes på et kategorisk grundlag, hvor vi kun kan vurdere, om det enkelte valg er autonomt og ikke den specifikke person. Det er nødvendigt for, at sygeplejersken kan medvirke til, at patienten er i stand til at udøve selvbestemmelse og dertilhørende facetter. Men som vi har diskuteret, kan det forekomme problematisk for sygeplejersken at skulle respektere patientens valg og ret til selvbestemmelse, hvis hun ikke har noget grundlag for at vurdere patientens evne til at besidde selvbestemmelse samt at være i stand til

at bevare patientens værdighed og integritet uden noget kendskab til vedkommendes livsanskuelser. For at løse dilemmaet mellem disse konflikter har vi anvendt Laura Waddell Ekstroms kohærente præference teori omhandlende det integrerede selv. At være i stand til at vurdere en patients evne til selvbestemmelse betyder, at vi må inddrage et refleksivt lag, som ikke er til stede hos hverken Kant eller Beauchamp. Dette er nødvendigt for, at sygeplejersken kan få forståelse af patientens definition af *det gode*, således at en eventuel behandling og pleje kan tilrettelæggelse efter patientens subjektive vurdering. Patientens karaktersystem, hvori dets integrerede selv og valg af præference findes, må sygeplejersken have med i sin vurdering, når patienten skal bedømmes som autonom eller ej. I dette bliver det også muligt for sygeplejersken at pleje og behandle patienten med værdighed, fordi vedkommende livsanskuelser og præferencer medindtages i overvejelserne, når behandlings- og plejeprocessen igangsættes. Dette betyder selvfølgelig også, at Ekstroms autonomibegreb bliver et mere komplekst begreb end det kantianske, da det omhandler et langt bredere perspektiv end Beauchamps minimumskriterium.

Ved pleje og behandling af lungecancerpatienten giver Ekstroms teori sygeplejersken mulighed for at bevare patientens værdighed og integritet, men den kan også svare på, hvorvidt patienten er i stand til at besidde selvbestemmelse. Kan sygeplejersken være med til at fremme patientens selvbestemmelse, så kan hun tilpasse de informationer, som patienten har krav på i henhold til De Sygeplejeetiske Retningslinjer, hvorved hun *medvirker til, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information, der gives, skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt livssituation* jf. §2.2. Dette betyder, at patienten skal være i stand til at besidde de facetter, som selvbestemmelsesbegrebet indbefatter; autonomi, selvansvarlighed, selvstyre og selvudvikling. Besidder patienten disse facetter, skal sygeplejersken nødvendigvis altid respektere patientens præferencer og dertilhørende valg og ønsker. Besidder patienten til gengæld ikke den ønskede grad af selvbestemmelse, kan vi argumentere for anvendelse af Voksen-ung-modellen, som giver sygeplejersken mulighed for en konkret medvirken til patientens udvikling i henhold til selvbestemmelse og derved sikre medvirken til, at patienten modtager og forstår den information, som er nødvendig for patienten for at træffe valg.

Tilfældet med lungecancerpatienten viser, at patienten ikke besidder tilstrækkelig grad af selvbestemmelse i henhold til patientens sygdomsforløb og derved må Voksen-ung-modellen tages i brug. Men vi kan også forestille os situationer, hvor en autonom patient som besidder fuld evne til selvbestemmelse, ikke ønsker den foreslåede behandling. Dette så vi ved eksemplet med Freud, i afsnittet *Konflikten mellem den personlige autonomis*

begrundede valg og paternalisme, hvor Freud ikke ønskede at modtage morfin, da han ønskede et klart hoved. Ved sådanne begrundede tilfælde kan sygeplejersken ikke retfærdiggøre et uønsket indgreb, da hvert enkelt autonomt menneske har ret til at leve det liv, som dette menneske ønsker, så længe at det ikke skader andre. Og modsat lungecancerpatienten giver Freud begrundelse for, hvorfor han ikke ønsker behandling, og derved er der lighedstegn mellem hans integrerede selv og det ønskede valg; Freud har forstået de informationer, sygeplejersken har givet, men ønsker samtidig at bevare sin værdighed og integritet; dette vurderer han til kun at kan lade sig gøre ved ikke at modtage morfin. Sådanne ønsker og valg må ikke krænkes, hvis sygeplejersken ønsker at leve op til De Sygeplejeetiske Retningslinjer fordring om bevarelse af værdighed og integritet.

Men det er klart, at i forholdet mellem etik i sygeplejen og autonomi har begrebet omsorg en afgørende rolle, da den tilbyder en nærvær, som hverken den moralske eller personlige autonomi er i stand til. Ved brug af Løgstrup har vi konkluderet, at lungecancerpatienten er mere end blot en patient; hun er også et menneske på lige fod med læger og sygeplejersker. Herved får de professionelle et medmenneskeligt ansvar, som ikke er til stede i hverken pligtetikken eller den konsekvensbetragende etik. Med dette ansvar har vi vurderet, at sygeplejersken må tage ansvar for patienten og ikke fra patienten, som tilfældet ganske givet let kan ske ved de øvrige teorier. Derved skal sygeplejersken, i det etiske dilemma, bl.a. også inddrage lungecancerpatientens datter i forløbet og øvrige berørte parter, således at man også kan få begges værdier og holdninger i spil, når hun gør sine overvejelser. Filosofen Kari Martinsen, som skriver Knud Ejler Løgstrups etik ind i sygeplejen, vurderer, at via fantasien kan sygeplejersken sætte sig i og forstå patientens sted og derved have indblik i et mere eksistentielt perspektiv på det etiske dilemma i henhold til lungecancerpatienten. Således må sygeplejersken bruge en skønmæssighedstagen for at vurdere dette. Men den ontologiske omsorgsetik må vi nødvendigvis kritisere, hvilket vi gjorde i afsnittet *Kritik af det ontologiske omsorgsideal*, fordi vi kan risikere at miste det faste grundlag som pligtetikken, samt den konsekvensbetragende etik, gav os, og derved kan behandlingen og plejen af patienten risikere at ende i en misologi, hvorved vi forkert antager, hvad der er bedst for den enkelte patient.

I afsnittet *De Sygeplejeetiske Retningslinjer – Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis* har vi bevæget os ind på en mere praksisorienteret anskuelse af forholdet mellem autonomi, etik og sygepleje. Her har vi indskrevet de principper, som vi har udarbejdet ind i forløbet omhandlede sygeplejerskernes praksisstandarder (De Sygeplejeetiske Retningslinjer) samt mål og værdier. Derved har vi været i stand til, via Professionsetiske Beslutningsmodel, at opsætte punkter, som skal med-indtænkes, når et etisk dilemma skal løses. Heriblandt at respektere

patientens autonomi og fremme interesse mm. Sygeplejersken skulle derved gerne være i stand til at begrunde sine valg i henhold til et etisk dilemma ved brug af de tre opstillede teorier samt udøve etisk refleksion, hvilket beslutningsmodellen er et redskab til. Derved kan sygeplejersken leve op til sine fire ansvars områder samt sætte hende i forhold til; *profession, patienten, medarbejder og samfundet* samt de fire grundværdier; *Værdien af det enkelte menneskes værdighed, værdien af omsorg, værdien af sundhed samt værdien af professionel integritet*.

Med disse redskaber har vi bevæget os fra filosofisk teori til praksisanvendelighed i sygeplejen. Derved skulle sygeplejersken gerne være i stand til at løse etiske dilemmaer. Anvendelsen af de brugbare redskaber kom til orde i det afsluttende afsnit *Case analyse*, hvor de to sygeplejersker skulle forholde sig til lungecancerpatientens evne til autonomi, og hvorledes konflikten mellem de nævnte praksisstandarder løses; via analyse blev lungecancerpatienten vurderet til ikke at besidde autonomi eller tilstrækkelighedsgrad af selvbestemmelse.

Indledningsvis identificerede vi casen; hvilke etiske principper har været relevant for dilemmaet? Hvilke handlemuligheder var mulige i henhold til pligtetikken, den konsekvensbetragtende etik og omsorgsetikken. Derefter påbegyndte vi den etiske analyse, hvor vi konkluderede, at lungecancerpatienten ikke var autonom, og at hun ikke var i stand til at besidde magt over egen tilværelse vedrørende hendes sygdomsforløb; hun besad således ikke en tilfredsstillende grad af selvbestemmelse.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at sygeplejersken altid skal anskue et etisk dilemma fra alle tre etiske teorier; man må aldrig forsøge at løse sådanne dilemmaer med endimensionel etisk tilgang, da sådanne ensrettet livsforståelse er førsteinstans for skærpelse af det enkelte specifikke menneske. Men når det så er sagt, så vil jeg mene, at mennesket, ubetinget, altid er det ubestridte mål-i-sig-selv, hvilket pligtetikken også fordrer. Dette betyder dog ikke, at pligtetikken er hierarkisk mere værd end henholdsvis den konsekvensbetragtende etik og den ontologiske omsorgs etik, men det betyder, at i og med at mennesket altid er mål-i-sig-selv, skal autonomi altid respekteres, fordi man ikke retfærdigvis kan krænke autonomien. Dette speciale har forsøgt at vise, hvor nødvendigt autonomi er i henhold til behandling og pleje af patienten; den autonome patient er i stand til at besidde moralsk autonomi samt personlig autonomi. Det vil sige, at vedkommende kan give udtryk for egne værdier og præferencer, og derved kan patientens værdighed og integritet altid bevares, så længe autonomien ikke krænkes. Mere besværligt bliver det, når en patient ikke besidder autonomi eller besidder en manglende evne til selvbestemmelse. Netop selvbestemmelse er et nøglebegreb, da sygeplejersken skal medvirke til at fremme selvbestemmelse hos patienten så vidt muligt. Netop her ser vi, hvorfor

pligtetikken ikke kan stå alene som eneste anvendelige etik i sygeplejen; den kan ikke sige noget om menneskets præferencer og personlige autonomi, men forholder sig kun til objektiv moralske autonomi. Dette perspektiv er nemlig også en nødvendighed, da selvbestemmelsesretten sikrer patientens ret til at sige fra, hvis patienten ikke ønsker den foreslåede behandling. Men mere vigtigt sikre den konsekvensbetragtende etik, at patienten, hvis vedkommende besidder selvbestemmelse, kan indgå informeret samtykke. Dette samtykke er fundamentalt i henhold til patienten og institutionen, da patientens samtykke skal gives på baggrund af tilstrækkelig og fyldestgørende information, hvorved sygeplejersken har pligt til, at patienten forstår disse. Deraf nødvendigheden af selvbestemmelse. Det er klart, at der forekommer eksempler, hvor patienten er inhabil i så kraftigt en grad, at selvbestemmelsesbegrebet ikke kan komme til realisering. Men ved patienter, hvor tilfældet er, at de ikke kan varetage egne interesser, men på sigt eventuelt ville være i stand til dette, bliver det at bidrage til, at patienten kan fremme og besidde magt over egen tilværelse, nødvendigt således at man kan varetage patientens interesser på samhörig vis og på sigt sikre, at vedkommende selv ville være i stand til at besidde evnen.

Mennesket er altid et mål-i-sig-selv, og derved skal autonomien altid respekteres, så længe at der er en autonomi at respektere, men er autonomien ikke tilstede, skal mennesket stadig behandles ligeværdigt og med værdighed; som mål, aldrig som middel.

VÆRK III • AFSNIT 17

Engelsk resumé / English resume

This thesis raises an issue on the relation between autonomy, ethics and nursing. It is a philosophical analysis and discussion which emphasizes the need for categorizing the individual as an unique autonomous being whose right and autonomy must not be violated.

According to Immanuel Kant's deontological moral theory, only rational beings are able to possess the capacity of autonomy. Kant argues that the fundamental principle of our moral duties is a categorical imperative. In nursing ethics this is the key fundament of ethics because it exercises the nurses will in a specific way in which the nurse only can act according to duty. This prevents that the treatment of a patient is not being founded on the random act or emotion. However, the Kantian deontology can only define the autonomous choice and not the autonomous person. Deontology might prevent violation of the patient's autonomy, but it does not offer any indication on how to treat a patient who does not possess the capacity of autonomy. Therefore nursing ethics needs yet another philosophical theory in the search for such for a wider treatment perspective. In addition the thesis has argued that the Kantian concept of autonomy might be too narrow. This is despite the fact that Tom L. Beauchamp tried to set up a practical use of Kant's concept of autonomy. This practical use required the patient to be able to possess *understanding*, *intention* and *free will*. By the use of Laura Waddell Ekstrom's complex autonomy theory we have been able to add an extra layer in the discussion on what it takes to be an autonomous person. Ekstrom offers a conception of a coherentist theory of autonomy in which we have to understand the beings self and its values before the nurse can start the treatment of the patient. This means that the nurse now has a treatment-model, in which the nurse is able to help the patient to possess self governance or at least help the patient in the direction of this specific aim. In the case of the woman being diagnosed with a severe lung cancer, the thesis emphasized the need of this philosophical tool.

Deontology and the consequence calculation ethics, represented by Ekstrom, is not enough. We also need a theory which represents nursing ethics more specifically. In this we have argued that sometime the nurses need a merely phenomenological and humane view on the patients. In addition to this Knud Ejler Løgstrup has been used in a way to include the human understanding of the specific patient.

By using these three ethical theories the nurse now has a tool to solve the ethical dilemmas she confronts everyday whilst at work. However, the nurse also has to include the nursing ethics' practical standard formula which can be found in the nursing-ethical guidelines. By using these tools the nurse should be able to categorize a patient as being autonomous or non-

autonomous. But no matter the outcome – the nurse must per definition treat the patient with integrity and respect.

VÆRK III • AFSNIT 18

Litteraturliste

Beauchamp, Tom L: *Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect?* Fra: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Redigeret af Taylor, James Stacey. Cambridge University Press, 2005.

Birkler, Jacob: *Filosofi & sygepleje – Etik og menneskesyn i faglig praksis*. Munksgaard Danmark, København, 2003.

Childress, James F. og Tom L. Beauchamp: *Principles of Biomedical Ethics*. 3. Udgave. Oxford University Press, 1989.

Ekstrom, Laura Waddell: *Autonomy and Personal Integration. Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Redigeret af Taylor, James Stacey. Cambridge University Press, 2005.

Husted, Jørgen: *Etik og værdier i socialt arbejde*. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag, 2009.

Husted, Jørgen: *Værdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale].

Kant, Immanuel: *Grundlæggelse af Sædernes Metafysik*. På dansk ved og med indledning af Tom Bøgeskov. Hans Reitzels Forlag, København, 1999.

Løgstrup, Knud Ejler: *Den Ethiske Fordring*. 9. Oplag. Gyldendal, København, 1975.

Martinsen, Kari: *Løgstrup & sygeplejen*. På dansk ved Joachim Wrang. Forlaget Klim, 2012.

Mill, John Stuart: *Om Friheden*. Fra: Mill om friheden; *Oversættelse og Guide* af Jørgen Husted. Philosophia, Aarhus, 2008.

Mill, John Stuart: *Utilitarisme. Oversættelse, indledning og efterskrift* ved Helge Nørgaard Madsen. Det Lille Forlag, 2008.

Platon: *Lovene*. Udgivet ved Høeg, Carsten og Ræder, Hans. C.A. Reitzels Forlag, 1940.

Politikkens filosofi leksikon. Redigeret af Poul Lübcke. Forfattere: Anne Grøn, Jørgen Husted, Poul Lübcke, Stig Alstrup Rasmussen, Peter Sandøe og Niels Christian Stefansen. 1. Udgave, 18. oplag. Politikens Forlagshus, København, 2006.

Sygeplejeetisk Råd 2010. Dansk Sygeplejeråd.

Taylor, James Stacey: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy, Introduction*. Cambridge University Press, 2005.

Originale noter

Noterne er flyttet fra sidefoden til en samlet sektion. Indholdet er bevaret, mens nummereringen følger denne udgave.

1. Beauchamp, Tom L: Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect? Fra: Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy. Side 315
2. Kant, Immanuel; fra Indledning til Grundlæggelse af sædernes metafysik af Tom Bøgeskov. Side 23
3. Politikkens filosofi leksikon. Side 232
4. Kant, Immanuel; Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 51
5. Kant, Immanuel; Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 46
6. Kant, Immanuel; Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 100-01
7. Kant, Immanuel; Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 78
8. Kant, Immanuel; Grundlæggelse af sædernes metafysik. Side 88
9. Sygeplejeetisk råd 2010. §1.3
10. Sygeplejeetisk råd 2010. §2.4
11. Beauchamp, Tom L: Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect? Fra: Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy. Side 315
12. Childress, James F. og Beauchamp, Tom L: Principles of Biomedical Ethics. Side 85
13. Beauchamp, Tom L: Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect? Fra: Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy. Side 314-15
14. Beauchamp, Tom L: Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect? Fra: Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy. Side 314
15. Childress, James F. og Beauchamp, Tom L: Principles of Biomedical Ethics. Side 107
16. Med dette menes der, at det ikke er umiddelbart klart, hvorvidt patienten er autonom eller ej.
17. Anonym case præsenteret til Klinisk Ethiske Komiteer, Aarhus Universitetshospital torsdag d. 2. februar 2012
18. Husted, Jørgen: Etik og værdier i socialt arbejde. Side 187
19. Sygeplejeetisk råd 2010 §2.2
20. Jeg udelader bevidst at inddrage datteren i den pligtetiske analyse. Dette skyldes, at pligtetikken omhandler det direkte forhold mellem den professionelle og patienten og ikke de indirekte forhold som datteren er en del af.
21. Læser bedes være opmærksom på, at jeg ikke bruger Ekstroms filosofi som en konsekvensutilitaristisk etisk position men som en konsekvensbetragtende position.
22. Taylor, James Stacey: Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy, Introduction. Side 15
23. Sygeplejeetisk råd 2010. §2.3
24. Sygeplejeetisk råd 2010. §2.4

25. Ekstrom, Laura Waddell: Autonomy and Personal Integration. Side 144
26. Ekstrom, Laura Waddell: Autonomy and Personal Integration. Side 154
27. Ekstrom, Laura Waddell: Autonomy and Personal Integration. Side 151
28. Ekstrom, Laura Waddell: Autonomy and Personal Integration. Side 158
29. Husted, Jørgen: Etik og værdier i socialt arbejde. Side 149
30. Sygeplejeetisk råd 2010. §2.2
31. Husted, Jørgen; Værdier og etik i Sygeplejen [Upubliceret materiale]. Side 54
32. Husted, Jørgen; Værdier og etik i Sygeplejen [Upubliceret materiale]. Side 55
33. Husted, Jørgen; Værdier og etik i Sygeplejen [Upubliceret materiale]. Side 56
34. Mill, John Stuart; Utilitarisme. Side 53
35. Husted, Jørgen: Etik og værdier i socialt arbejde. Side 147
36. Husted, Jørgen: Etik og værdier i socialt arbejde. Side 135
37. Mill, John Stuart; Om Friheden. Side 90
38. Birkler, Jakob; Filosofi & sygepleje – Etik og menneskesyn i faglig praksis. Side 20
39. Løgstrup, Knud Ejler; Den etiske fordring. Side 25
40. Løgstrup, Knud Ejler; Den etiske fordring. Side 39
41. Løgstrup, Knud Ejler; Den etiske fordring. Side 35
42. Martinsen, Kari; Løgstrup & Sygeplejen. Side 51
43. Martinsen, Kari; Løgstrup & Sygeplejen. Side 52
44. Martinsen, Kari; Løgstrup & Sygeplejen. Side 52
45. Løgstrup, Knud Ejler; Den Ethiske Fordring Side 136
46. Løgstrup, Knud Ejler; Den Ethiske Fordring Side 56
47. Martinsen, Kari; Løgstrup & Sygeplejen. Side 55
48. Det skal dog tages in notits at fordringen er uopfyldig og at vi derved aldrig vil kunne opfylde denne ifølge Løgstrup.
49. Martinsen, Kari; fremlæggelse af Løgstrups formulering af den gyldne regel som er formuleret i Matthæusevangeliet 7,12: Løgstrup & Sygeplejen. Side 55
50. Husted, Jørgen; Etik og værdier i socialt arbejde. Kapitel 4
51. Martinsen, Kari; Løgstrup & Sygeplejen. Side 55
52. Sygeplejeetisk råd 2010. §1.2
53. Sygeplejeetisk råd 2010. §2.4
54. Husted, Jørgen; Værdier og etik i Sygeplejen [Upubliceret materiale]. Side 4
55. Læser bedes have in notits at denne skildring ikke kun kan anvendes på læger men også sygeplejersker mm, hvilket er dette speciales specifikke udgangspunkt.
56. Platon; Lovene. Bog IV. Side 141
57. Husted, Jørgen; Værdier og etik i Sygeplejen [Upubliceret materiale]. Side 5
58. Husted, Jørgen; Værdier og etik i Sygeplejen [Upubliceret materiale]. Side 9
59. Husted, Jørgen: Etik og værdier i socialt arbejde. Side 212
60. Husted, Jørgen: Etik og værdier i socialt arbejde. Side 190
61. Sygeplejeetisk råd 2010. Side 16-17

- 62.** Husted, Jørgen; Værdier og etik i Sygeplejen [Upubliceret materiale]. Side 14-15
- 63.** Sygeplejeetisk råd 2010 §1.2

Efterord • Fra eugenik til sygeplejeetik

De tre arbejder viser en tydelig faglig bevægelse. Bachelorprojektet undersøger, om teknologisk forbedring kan krænke et kommende menneskes mulighed for at forstå sit liv som sit eget. Den specialeforberedende opgave flytter spørgsmålet om autonomi ind i sygeplejens praksis. Specialet udfolder derefter en bredere etisk arkitektur, hvor pligt, konsekvenser, personlig integration, omsorg og professionsetik prøves mod konkrete dilemmaer.

Det gennemgående spørgsmål er ikke blot, om et menneske kan vælge, men hvad der skal til, for at et valg kan være dets eget. På tværs af værkerne bliver autonomi derfor både en beskyttelse mod andres magt og et krav om opmærksomhed på de betingelser, som gør selvbestemmelse mulig. Afhængighed ophæver ikke værdighed; den kan tværtimod gøre respektens konkrete form mere krævende.

Som historiske arbejder bærer teksterne deres tid med sig. Sproget er til tider kategorisk, bibliografien rummer fejlvarianter, og enkelte argumenter bevæger sig hurtigere end deres præmisser tillader. Det er netop grunden til, at denne udgave bevarer ordlyden og lægger den faglige kontrol ved siden af. En arkivudgave skal gøre udviklingen læsbar, ikke skrive fortiden om.

Sammenstillingen viser også en kontinuitet i interesse: menneskets ret til ikke at blive reduceret til middel, projekt eller sag. Fra det genetisk designede barn til patienten i en sårbar situation handler etikken om, hvordan frihed kan beskyttes uden at omsorg forsvinder, og hvordan omsorg kan udøves uden at frihed bliver overtaget.

Personlige og etiske refleksionsspørgsmål

Spørgsmålene er tænkt som private arbejdsredskaber til genlæsning, selvprøve og videre skrivning.

1. Hvornår bliver ønsket om at forbedre et menneskes liv til et forsøg på at bestemme dets liv på forhånd?
2. Hvilke egenskaber ved mit eget liv oplever jeg som gaver, og hvilke oplever jeg som resultater af valg?
3. Kan et menneske være autonomt, selv om det er dybt afhængigt af andre?
4. Hvornår har omsorg i mit eget liv føltes frigørende, og hvornår har den føltes styrende?
5. Hvordan skelner jeg mellem at respektere et valg og at opgive et menneske til konsekvenser, det ikke overskuer?
6. Hvad ville jeg ønske, at en professionel gjorde, hvis jeg traf et valg, som vedkommende mente var skadeligt?
7. Er der situationer, hvor min evne til selvbestemmelse bliver mindre uden at min værdighed bliver mindre?
8. Hvordan påvirker frygt, smerte eller afhængighed min opfattelse af et frit valg?
9. Hvilke former for paternalisme kan være begrundede, og hvilke bør aldrig accepteres?
10. Hvornår er en regel en beskyttelse, og hvornår bliver den en erstatning for dømmekraft?
11. Hvordan kan man tage den andens perspektiv alvorligt uden at foregive at kende den andens bedste fuldstændigt?
12. Hvad betyder integritet for mig, når et menneskes ønsker er indbyrdes modstridende?
13. Kan et etisk valg være velbegrundet, selv om resultatet bliver dårligt?
14. Hvilken rolle bør konsekvenser spille, når en persons autonome beslutning berører andre?
15. Hvornår bliver et ideal om det gode liv for snævert til at rumme den enkeltes liv?
16. Hvilken betydning har sproget for, om en patient oplever sig som deltager eller genstand?
17. Hvordan bør en historisk tekst læses, når dens sprog eller faglige grundlag ikke længere er tidssvarende?

- 18.** Hvilke af de tre arbejder viser tydeligst en udvikling i forståelsen af autonomi?
- 19.** Hvad ville jeg i dag formulere anderledes, uden at fornægte den person, der skrev teksten dengang?
- 20.** Hvilket spørgsmål fra værkerne er stadig åbent i mit eget liv?

Redaktionelle kontrolnoter

1. Værkernes ordlyd er bevaret som historisk tekst. Stavefejl, syntaks og faglige forenklinger er derfor ikke rettet lydløst.
2. Typografi, afsnitsrytme og overskriftsniveauer er normaliseret til seriens A5-format.
3. Originale fodnoter er flyttet til nummererede notesektioner efter hvert værk. Henvisningspunkterne står fortsat i teksten.
4. Bachelorarkivet rummer flere varianter. Den mest komplette sammenhængende version med resumé er anvendt som værktekst.
5. Den specialeforberedende PDF og DOCX-versionen er indholdsmæssigt sammenholdt; DOCX-teksten anvendes for at bevare notehenvisningerne.
6. Specialets færdige DOCX og udskriftsversion har samme hovedtekst. Den færdige, ikke-XTRA-markerede DOCX er anvendt.
7. Gammelt årskortnummer og gentagen navneblok er udeladt fra værkteksten. Forfatterkreditering står kun i bogens faste forfatterfelter.
8. Formelle forsider, godkendelser, mails og tilblivelsesdokumenter er registreret, men reserveret til bind II eller det private arkiv.
9. Faglig kontrol er foretaget mod de citerede primærværker samt officielle udgiver- og professionskilder.
10. Bilag A beskriver læsekorrektioner; det ændrer ikke de historiske teksters ordlyd eller konklusioner.

Kontrolgrundlag

- Habermas, Jürgen. Den menneskelige naturs fremtid – på vej mod en liberal eugenik?
- Agar, Nicholas. Liberal Eugenics: In Defence of Human Enhancement. Blackwell, 2004.
- Beauchamp, Tom L., og James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics.
- Taylor, James Stacey (red.). Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy. Cambridge University Press, 2005.
- Ekstrom, Laura Waddell. Autonomy and Personal Integration.
- Kant, Immanuel. Grundlæggelse af sædernes metafysik.
- Løgstrup, K. E. Den etiske fordring.
- Martinsen, Kari. Løgstrup & sygeplejen.
- Dansk Sygeplejeråd. De Sygeplejeetiske Retningslinjer 2010/2014 samt Etisk grundlag for sygeplejersker 2024.

Bilag A • Faglige rettelser og redaktionelle præciseringer

Bilaget dokumenterer de vigtigste steder, hvor en historisk formulering kræver præcisering. Hovedteksterne er ikke ændret; tabellen fungerer som en faglig læsenøgle.

Historisk formulering	Problem	Faglig præcisering	Grundlag
Agar omtales som forfatter til en artikel med titlen In Defence of Human Enhancement.	Titlen og genren bliver upræcis.	Nicholas Agars Liberal Eugenics: In Defence of Human Enhancement er en bog fra 2004.	Wiley/Blackwell, DOI 10.1002/9780470775004.
Habermas fremstilles enkelte steder som modstander af enhver genetisk intervention.	Skellet mellem behandling og positiv forbedring udviskes.	Kritikken retter sig især mod positiv liberal eugenik; terapeutiske indgreb behandles anderledes gennem antagelsen om mulig samtykke.	Habermas, Den menneskelige natur fremtid; Pugh 2015.
Genetisk design beskrives som noget, der fastlægger hele den designede persons liv.	Normativ påvirkning bliver til genetisk determinisme.	Habermas' bekyrning gælder asymmetri, ansvar og selvforståelse; den beviser ikke, at et livsforløb kausalt fastlægges.	Habermas 2003; Árnason 2014.
Den designede person mister nødvendigvis autonomi.	En omstridt tese præsenteres som et sikkert resultat.	Autonomitabet er Habermas' argument og skal vurderes kritisk; flere senere bidrag bestrider nødvendigheden.	Pugh 2014; Schäfer 2019.
Terapi og forbedring behandles som et helt skarpt og ukompliceret skel.	Grænsetilfælde og normbegreb overses.	Skellet er normativt betydningsfuldt, men det kræver fortolkning af normalitet, sygdom og forventet samtykke.	Habermas 2003; Mills 2015.
Habermas forventes at give en endelig definition af, hvad mennesket er.	Værkets artsetik forveksles med en fuld metafysisk antropologi.	Habermas undersøger betingelser for moralsk selvforståelse; han leverer ikke en udtømmende essensdefinition.	Habermas, Den menneskelige natur fremtid.
Kristendommen præsenteres som det nødvendige svar på, hvad det vil sige at være menneske.	En selvstændig teologisk konklusion følger ikke af analysen alene.	Religiøse perspektiver kan udvide undersøgelsen, men deres nødvendighed kræver et særskilt argument.	Redaktionel argumentkontrol.
Kants autonomibegreb anvendes direkte på fosteret.	Forholdet mellem rationel agens og moralsk status springes over.	En kantiansk beskyttelse af fosteret kræver en selvstændig begrundelse; den følger ikke umiddelbart af autonomibegrebet.	Kant, Grundlæggelse af sædernes metafysik; moralstatusdebatten.
Beauchamp og Childress fremstilles som en praktisk udgave af Kant.	Principismen reduceres til én etisk tradition.	De fire principper udgør en plural ramme og kan ikke uden videre afledes af pligtetik alene.	Beauchamp og Childress, Principles of Biomedical Ethics.
Respekt for autonomi står alene som sundhedsetikens grundprincip.	Ikke-skade, godgørehed og retfærdighed får sekundær status uden argument.	Principperne er prima facie-forpligtelser, som kan komme i konflikt og må afvejes og specificeres.	Beauchamp og Childress, Principles of Biomedical Ethics.
Autonomikompetence behandles som en global egenskab, man enten har eller ikke har.	Beslutningens art, tidspunkt og kompleksitet overses.	Beslutningskompetence vurderes i forhold til den konkrete beslutning og den aktuelle situation.	Beauchamp og Childress; nyere kapacitetslitteratur.
En liste over manglende evner anvendes som en afsluttende test.	Indikatorer bliver til mekaniske facitkriterier.	Forståelse, værdsættelse, begrundelse og valg er vurderingsdimensioner, ikke en automatisk pointtest.	Principles of Biomedical Ethics, kapitlet om autonomt valg.

Historisk formulering	Problem	Faglig præcisering	Grundlag
Et autonomt valg og en autonom person forbindes enkelte steder for tæt.	Handlingsautonomi og personlig autonomi har forskellige rækkevidder.	Et valg kan vurderes særskilt fra personens mere omfattende identitet og livslange selvforhold.	Taylor (red.), Personal Autonomy, 2005.
Ekstroms teori reduceres til simpel overensstemmelse mellem ønsker.	Refleksion, accept og personlig integration forsvinder.	Ekstroms kohærenstilgang handler om personens autoriserede præferencer og reflekterede selvforhold, ikke blot om fravær af konflikt.	Ekstrom, Autonomy and Personal Integration.
Svag paternalisme defineres blot som afværgelse af et onde.	Indgrebs relation til frivillighed og kompetence bliver uklar.	Svag paternalisme retter sig typisk mod valg, hvis frivillighed eller autonomi er utilstrækkelig eller usikker.	Standarddebatten om paternalisme; Mill som kontrast.
Løgstrups etiske fordring læses som en konkret handlingsregel.	Fordringens tavshed og situationsbundethed overses.	Fordringen angiver rettheden mod den andens bedste, men ikke et færdigt handlingsskema.	Løgstrup, Den etiske fordring.
Det ontologiske omsorgsideal fremstår som én entydig lære.	Løgstrups etik og senere sygeplejefaglige reception blandes sammen.	Løgstrups relationelle etik må skelnes fra Kari Martinsens selvstændige sygeplejefaglige fortolkning.	Løgstrup; Martinsen, Løgstrup & sygeplejen.
De Sygeplejeetiske Retningslinjer fra 2010 kan læses som nutidens gældende formulering.	Den historiske status markeres ikke.	Teksten bruger den version, der var gældende ved specialets tilblivelse; senere revisioner fra 2014 og det etiske grundlag fra 2024 ændrer konteksten.	Dansk Sygeplejeråd, historiske og aktuelle dokumenter.
Den professionsetiske beslutningsmodel kan fremstå som den eneste autoriserede metode.	Et arbejdsredskab bliver til universel standard.	Modellen er et refleksionsredskab blandt flere og skal anvendes sammen med faglig viden, lovgivning og konkret dømmekraft.	Redaktionel metodekontrol; Sygeplejeetisk Råd.
Childress; Philosophian; Grundlæggelse af Moralens Metafysik.	Navne- og titelvarianter er bibliografisk fejlagtige.	Childress; Philosophia; Grundlæggelse af sædernes metafysik i den anvendte danske udgave.	Bibliografisk kontrol mod værkernes titelblade.
Patientcases kan læses som klinisk vejledning.	En historisk filosofisk analyse forveksles med sundhedsfaglig instruks.	Cases læses som etiske tanke- og øvelseseksempler; de erstatter ikke kliniske retningslinjer eller individuel vurdering.	Redaktionel afgrænsning.
Sygeplejersken omtales konsekvent som 'hun'.	Historisk kønnet sprog kan opfattes som en nutidig norm.	Formuleringen er bevaret som del af originalteksten; professionen og ansvaret er ikke kønsbestemt.	Redaktionel sproglig præcisering.

Bilag B • Materiale- og filoversigt

Oversigten registrerer 90 fysiske filer i de tre arkiver. To midlertidige Word-låsefiler er bevaret, men ikke anvendt. Filnavne med personidentifikatorer er forkortet i denne bogudgave.

Arkiv	Fil / relativ placering	Redaktionel status
Bachelorprojekt	Bachelor projekt.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Bachelorprojekt	Bachelorpensum.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Bachelorprojekt	folk_faelllesskab_kap_5.pdf	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Bachelorprojekt	fællespen...doc	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Bachelorprojekt	Indholdsfortegnelse.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Bachelorprojekt	opgave_RETTET xtra.doc	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Bachelorprojekt	opgave_RETTET.doc	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Bachelorprojekt	Tekster fra AULA 2009/Habermas,_Den_menneskelige_naturs_fremtid.pdf	Kildetekst; registreret, ikke gengivet
Bachelorprojekt	Tekster fra AULA 2009/Nicholas_Agar,_Liberal_Eugenics.pdf	Kildetekst; registreret, ikke gengivet
Bachelorprojekt	Tekster fra AULA 2009/Nikolas_Rose,_The_Politics_of_Life_Itself_chap.1. pdf	Kildetekst; registreret, ikke gengivet
Bachelorprojekt	UDKAST Nødvendigheden af et opgør med den liberale eugenik 97 DOKUMENT.doc	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Bachelorprojekt	UDKAST Nødvendigheden af et opgør med den liberale eugenik xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Bachelorprojekt	UDKAST Nødvendigheden af et opgør med den liberale eugenik.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Bachelorprojekt	~\$gave_RETTET.doc	Midlertidig låsefil; ikke anvendt
Bachelorprojekt	~\$KAST Nødvendigheden af et opgør med den liberale eugenik.docx	Midlertidig låsefil; ikke anvendt
Specialeforberedende	opgave/Til aflevering/forsideskema.doc	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Specialeforberedende	opgave/Til aflevering/forsideskema.pdf	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Specialeforberedende	opgave/Til aflevering/Indholdsfortegnelse.pdf	Parallel/færdig version eller formelt bilag

Arkiv	Fil / relativ placering	Redaktionel status
Specialeforberedende	opgave/Til aflevering/specialeforberedende opgave.pdf færdig	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Specialeforberedende	opgave/Til aflevering/udkast opgave xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Specialeforberedende	opgave/Til aflevering/udkast opgave.docx	Hovedtekst i bind I
Specialeforberedende	opgave/udkast opgave.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Specialeforberedende	Speciale forberedende prøve brainstorm.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Andre filer/196jll2009.pdf	Kildetekst; registreret, ikke gengivet
Speciale	Andre filer/personlig autonomi - ekstrom mf.pdf	Kildetekst; registreret, ikke gengivet
Speciale	Anvendt litteratur.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Autonomi Etik og Værdi i sygeplejen – om patientens ret til det gode liv.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Cases/Birds with Records præsenterer MAIL.docx	Korrespondance/arbejdspapir; ikke gengivet
Speciale	Cases/Case - Den ældre kvinde.docx	Case-arbejdsmateriale; ikke gengivet særskilt
Speciale	Cases/Case 1 - lungecancer patienten.docx	Case-arbejdsmateriale; ikke gengivet særskilt
Speciale	Cases/Case 2 kronisk alkoholiseret patient.docx	Case-arbejdsmateriale; ikke gengivet særskilt
Speciale	Cases/Case analyse - lungecancer pt.docx	Case-arbejdsmateriale; ikke gengivet særskilt
Speciale	Cases/fraserteret case analyse.docx	Case-arbejdsmateriale; ikke gengivet særskilt
Speciale	Cases/Platon – den frie læge – på dansk.docx	Case-arbejdsmateriale; ikke gengivet særskilt
Speciale	Del 1 - Indledning - begrebs def mm/Indledning - begrebs def - metode.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Del 2 - Kant og Kant i praksis ved Beauchamp/Det kantianske autonomibegreb og Beauchamp - praksis.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Del 3 - Personlig autonomi v Ekstrom samt Freud diskussion/Fra moralsk autonomi til personlig autonomi - introduktion til ekstrom.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Del 3 - Personlig autonomi v Ekstrom samt Freud diskussion/Selvbestemmelse og personlig autonomi Ekstrom.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Del 4 - Autonomi og omsorgs ideal/Om forholdet mellem autonomi og omsorg samt kritik.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Del 5 - De Sygeplejeetiske Retningslinjer – Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis/De Sygeplejeetiske Retningslinjer.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Del 6 - Case analyse/Case analyse - Ældre kvinde - DROPPES.docx	Case-arbejdsmateriale; ikke gengivet særskilt

Arkiv	Fil / relativ placering	Redaktionel status
Speciale	Del 7 - Konklusion samt engelsk resume/Konklusion og eng resume.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	den frie og den ufrie læge.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	forhåndsgodkendelse.pdf	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	FÆRDIG/Autonomi, etik og sygepleje - speciale - [personidentifikator udeladt] XTRA.docx	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Speciale	FÆRDIG/Autonomi, etik og sygepleje - speciale - [personidentifikator udeladt].docx	Hovedtekst i bind I
Speciale	FÆRDIG/Forside.docx	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Speciale	FÆRDIG/Indholdsfortegnelse.docx	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Speciale	FÆRDIG/Udskrives/1 Forside.pdf	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Speciale	FÆRDIG/Udskrives/2 Indholdsfortegnelse.pdf	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Speciale	FÆRDIG/Udskrives/3 Autonomi, etik og sygepleje - speciale - [personidentifikator udeladt].docx	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Speciale	FÆRDIG/Udskrives/3 Autonomi, etik og sygepleje - speciale - [personidentifikator udeladt].pdf	Parallel/færdig version eller formelt bilag
Speciale	lit.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Litteraturlist.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Litteraturliste.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	mail til [navn udeladt].docx	Korrespondance/arbejdspapir; ikke gengivet
Speciale	privathed på hospitaler.pdf	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv
Speciale	Rettet råudkast 13 juli xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast 13 juli.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast 26 juli.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast 30 juli xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast 30 juli.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast 7 juli.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast 8 juli xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast 8 juli.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast ekstra 5 juli.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Rettet råudkast.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Speciale titel.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv

Arkiv	Fil / relativ placering	Redaktionel status
Speciale	Spørgsmål til Husted.docx	Korrespondance/arbejdsrapport; ikke gengivet
Speciale	Tidligere udkast/Del 0 - Indlednings mm/Engelsk resume.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 0 - Indlednings mm/Indledning plus metode.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 0 - Indlednings mm/Indledning.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 0 - Indlednings mm/Metodeovervejelse.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 1 - Autonomi - Kant - Beauchamp/Del 1 - Det kantianske autonomibegreb xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 1 - Autonomi - Kant - Beauchamp/Del 1 - Det kantianske autonomibegreb.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 2 - Selvbestemmelse/Del 2 - Selvbestemmelse - personlig autonomi ekstra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 2 - Selvbestemmelse/Del 2 - Selvbestemmelse - personlig autonomi.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 3 - Løgstrup/del 3 - Løgstrup xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 3 - Løgstrup/del 3 - Løgstrup.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 4 - de sygeplejeetiske retningslinier MM/Del 4 - De sygeplejeetiske retningslinier mm xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 4 - de sygeplejeetiske retningslinier MM/Del 4 - De sygeplejeetiske retningslinier mm.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 5 - Case analyse/Del 5 - Case analyse xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 5 - Case analyse/Del 5 - Case analyse.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 6 - Konklusion/Konklusion.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Del 7 - litteraturliste indholdsfortegnelse mm/Perspektivering.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Rettet råudkast - 26 juni.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Rettet råudkast xtra.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/Råudkast 21 juni.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Tidligere udkast/UDKAST 27 juni.docx	Tilblivelsesarkiv; reserveret til bind II
Speciale	Ting til opsætning.docx	Støtte-, variant- eller arbejdsfil; bind II/arkiv

Arkivprincip

Ingen originalfil er ændret eller slettet. Bind I gengiver kun de tre valgte værktekster. Arbejdsprocessen, varianterne og de formelle dokumenter behandles i bind II eller forbliver i det private arkiv.